

МОДУЛЬ III. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ, ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ТЕМА 1: ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лекция 1: Гигиена нервной системы и отдельных органов

План

1. Физиология и гигиена нервной системы в раннем и дошкольном возрасте.
2. Особенности и гигиена кожи ребенка.
3. Особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата ребенка.
4. Особенности и гигиена органов дыхания и голосового аппарата.
5. Особенности и гигиена органов пищеварения в детском возрасте.
6. Гигиена полости рта, профилактика кариеса.
7. Гигиена зрения у детей.

1. Физиология и гигиена нервной системы в раннем и дошкольном возрасте

Нервная система человека — биологический субстрат его психики — *интенсивно развивается на протяжении всего дошкольного детства*. К моменту рождения ребенка по сравнению с другими органами и системами она наименее развита и дифференцирована. Более закончен по строению спинной мозг; головной мозг продолжает быстро расти и развиваться. У новорожденного масса мозга составляет 350–400 г, но уже к году она утраивается, а к шести годам близка к массе мозга взрослого человека. После рождения продолжается изменение формы и величины борозд и извилин; особенно энергично оно происходит в первые пять лет жизни. Число нервных клеток в полушариях большого мозга новорожденного такое же, как у взрослого, но по строению они еще незрелы. Созревание клеток коры заканчивается к 18–20 месяцам, продолговатого мозга и регуляторных структур — к семи годам.

Развитие головного мозга запрограммировано генетически: в определенной последовательности на каждом этапе развития созревают его определенные структуры. Созревание наиболее эволюционно молодых отделов происходит только под влиянием внешней среды и зависит от поступающей в мозг информации. По мере роста и созревания мозга усложняется его взаимодействие с внешней средой, что, в свою очередь, стимулирует развитие мозга, совершенствует его структурно-функциональную организацию. Чем выше уровень развития мозга, тем

сложнее и разнообразнее становятся психические реакции, тем большее значение в регуляции поведения приобретает жизненный опыт.

Таким образом, *развитие нервной системы и психики ребенка зависит не только от биологической «программы», заложенной генетически, но и от формирующего воздействия окружающей среды, прежде всего социальной*. Развитие личности ребенка происходит в совместной с окружающими людьми деятельности. Известно, что недостаток стимулирующего воздействия на ребенка в периоды становления важных психических функций может привести к задержке и нарушению их формирования. В психологии существует понятие сензитивных периодов, в которые развивающийся организм бывает наиболее чувствителен к определенному рода влияниям окружающей действительности.

Сензитивные периоды — это периоды оптимальных сроков развития определенных мозговых структур, формирования протекающих в них процессов и

соответствующих свойств психики. Например, известно, что при неполноценном, скудном общении с ребенком в период становления речи его речевое развитие замедляется, страдают словарный запас и выразительность речи. Восстановить такой недостаток развития в более старшем возрасте не просто и полностью не всегда возможно. В возрасте около пяти лет дети особенно чувствительны к развитию фонематического слуха, а в более старшем возрасте эта чувствительность падает, поэтому недостатки восприятия звуков, имеющие место при различных логопедических дефектах, лучше всего поддаются коррекции в этом возрасте. Недостаточные условия для двигательного развития в первые три года жизни (ограничение подвижности, отсутствие стимулов для двигательного развития) ведут к задержке формирования координации и ловкости, тонких дифференцированных движений.

Функциональные особенности развивающегося мозга характеризуются повышенной возбудимостью подкорковых отделов и склонностью к **иррадиации** (распространению) возбуждения на другие отделы: чем моложе ребенок, тем более генерализованный характер имеют его реакции. Наблюдаются также **повышенная эмоциональность и более выраженная ориентировочная реакция**, обусловленные несовершенной регуляцией протекающих процессов.

Формирование высшей нервной деятельности происходит через этапы становления основных функций коры. Уже к моменту рождения у ребенка есть определенные возможности: он слышит, видит, воспринимает боль, тепло, холод, запахи и вкусовые раздражения, у него имеется ряд врожденных безусловных рефлексов (сосательный,

оборонительный, ориентировочный). С первых дней жизни возможна выработка условной реакции на время кормления. На 10-12-й день после рождения вырабатывается сложный условный рефлекс с включением нескольких анализаторов — вестибулярного, тактильного, а затем и зрительного. Это так называемый рефлекс на положение под грудью.

Показателем достаточного уровня функциональной активности коры в периоде новорожденности служит также **реакция типа «доминанта»**. Доминанта представляет собой такой очаг возбуждения, в котором любые дополнительные раздражители вызывают, с одной стороны, усиление возбуждения, а с другой — усугубление тормозного состояния в окружающих зонах. В таком случае перераспределение зон возбуждения происходит с большим трудом. В первые дни и недели жизни имеются пищевая и вестибулярная, а с третьего месяца четко выявляется и ориентировочная доминанта. Пищевая доминанта характеризуется тем, что посторонние раздражители (похлопывание по щеке, стук двери и др.) усиливают сосательные движения у ребенка. При ориентировочной доминанте, наоборот, добавочные раздражители вызывают прекращение сосания и поворот головы в сторону раздражителя. На вестибулярной доминанте основан обычай успокаивания ребенка покачиванием.

Дальнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка происходит по пути становления **условных рефлексов**. На их основе формируются простые, а затем и сложные действия, умения, поведенческие акты. Ранние условные рефлексы ребенка обладают определенными характеристиками: требуют для своей выработки большего числа повторений, нестойки, отличаются длительным латентным периодом. Они сохраняются в течение всего дошкольного периода, что сказывается на особенностях поведения детей.

На выработку реакций условно-рефлекторного плана влияют определенные условия:

1. Соматическое состояние ребенка. Болезнь или недомогание ослабляет функциональную активность коры, и дополнительные требования оказываются чрезмерной нагрузкой для организма.

2. Оптимальное состояние функциональной активности подкорковых центров, участвующих в образовании условного рефлекса. Нецелесообразно вырабатывать навык самостоятельной еды у сытого ребенка, так как не будет соответствующего безусловного подкрепления в виде возбуждения пищевого центра; заниматься с утомленным ребенком и т. д.

3. Уровень активности корковых клеток. В физиологии существует термин «состояние оптимальной возбудимости коры», который отражает достаточный уровень функциональной активности для выработки и

проявления наиболее адекватных реакций на окружающее. Обычно такое состояние наблюдается у здорового, не переутомленного ребенка.

4. Участие различных анализаторов в формировании условно-рефлекторной связи. Их функциональное состояние должно быть полноценным, а число максимальным, т. е. ребенок должен слышать что-то, увидеть, иметь возможность потрогать руками. Для активной познавательной деятельности существенно также участие двигательного анализатора: возможность манипулировать предметом, переносить или передвигать его является важным условием для закрепления реакции.

5. Определенная сила раздражителя. Громкие звуки, окрики т. д. вызывают разлитое возбуждение нервных клеток, препятствующее развитию специфической реакции. Очень слабый раздражитель вообще не вызывает достаточного уровня их возбуждения.

6. Подкрепление. У детей следует использовать только позитивное подкрепление. С первых месяцев жизни ребенка для подкрепления можно использовать ласковый голос, похвалу, тактильный контакт, т. е. удовлетворение потребности ребенка в общении со взрослым. Если реакция или поведенческий навык осуществляются ребенком только из опасения быть наказанным, то они будут выполняться лишь в специфической ситуации, предполагающей наказание. К тому же такой способ «воспитания» искажает отношения между воспитуемым и воспитателем.

Не следует вырабатывать сразу несколько новых реакций, навыков или умений. Освоить их сразу для ребенка очень трудно. Поэтому в первую очередь надо выработать ту реакцию, которая в данный период наиболее значима для него.

Защита нервных клеток от переутомления и регуляция взаимодействия безусловных и условно-рефлекторных процессов осуществляется посредством **торможения** — прекращения активности определенных групп нервных клеток.



Состояние *запредельного*

торможения возникает при сверхсильных или длительно, монотонно действующих раздражителях, воздействие которых накапливается. У ребенка запредельное торможение проявляется при наказаниях, резком окрике, испуге, длительном сидении в одном положении и др. Следует беречь ребенка от такого состояния.

Сон как вид **охранительного торможения** обеспечивает отдых клеткам центральной нервной системы. Во время него в нервных клетках происходят обменные процессы, восстанавливающие их функциональные возможности. Недостаток сна отрицательно сказывается на активности мозга ребенка во время бодрствования.

Виды **внутреннего**, или условного, торможения являются более сложными реакциями. Так, если у ребенка выработан рефлекс на положение под грудью, а затем его перестали брать на руки для кормления, то рефлекс угасает — ребенок, будучи взят на руки, перестает делать сосательные движения. Однако он не исчез полностью, так как достаточно лишь 1-2 раза полностью возобновить ситуацию подкрепления, чтобы рефлекс восстановился. Реакция условного торможения используется для отучения ребенка от вредных привычек, нежелательных форм поведения.

Сущность «**встречи двух возбуждений**» заключается в том, что если одновременно возбуждаются две функциональные системы, то через некоторое время система, менее значимая в данный момент, приходит в состояние торможения. У детей такая реакция наблюдается в виде отвлечения: например, когда ребенок ест и кто-то входит в комнату, ребенок отвлекается и перестает есть. У детей раннего и дошкольного возраста имеется существенная особенность: все новое в силу выраженности ориентировочной реакции является более значимым, чем та деятельность, которая в данный момент объективно более важна, например еда.

Дифференцировка реакции в зависимости от вызывающего ее стимула возможна с третьего месяца жизни. Первой дифференцировкой является улыбка на лицо и голос матери и отсутствие реакции на другого взрослого. Способность ребенка к дифференцированному восприятию в значительной степени отражает уровень его психического развития.

В основе **задерживания реакции** (с седьмого-восьмого месяца жизни) лежит способность произвольно отсрочить ее до того момента, когда она будет более целесообразна. Чем моложе ребенок, тем короче срок, в течение которого он может спокойно подождать. На втором году жизни ребенок спокойно ждет около 5 мин. Тренировать это качество целесообразно, используя ориентировочную реакцию или игровую ситуацию. Заставлять ждать ребенка второго года жизни в процессе еды 4-5 мин не следует, так как такой интервал может вызвать снижение пищеварительной активности. Кроме того, на втором году жизни должен активно формироваться навык

самостоятельной еды. У ребенка третьего года жизни для тренировки спокойного ожидания могут быть использованы и физиологические

потребности. В этом возрасте, например, ребенок должен уметь спокойно подождать 5-6 мин, пока остальные дети, сидящие за столом, закончат есть.

Условное торможение — еще более сложная реакция, при которой тормозящим фактором является дополнительное условие. Подобное поведение требует значительной функциональной зрелости мозга. Оно проявляется у ребенка с конца первого года жизни в виде адекватной реакции на универсальный для человека условный тормозящий фактор — слово «нельзя». На его основе формируются такие важные для человека качества, как способность произвольно откладывать удовлетворение органической потребности ради чего-то или кого-то, пожертвовать чем-то для блага другого человека. Это качество тоже нужно формировать в оптимальные сроки, стимулируя у детей интерес к окружающим, сопереживание, понимание чувств и потребностей других людей.

2. Особенности и гигиена кожи ребенка

Соприкасаясь непосредственно с окружающей средой, кожа выполняет многообразные и очень важные функции: она выступает в роли органа чувств (рецепторная функция), защищает внутренние органы от воздействий внешней среды (защитная функция), путем расширения или сужения сосудов и выделения пота регулирует теплоотдачу (терморегулирующая функция), участвует в газообмене (дыхательная функция), в обмене веществ и т. д.

Кожа ребенка ранима и чувствительна к неблагоприятным воздействиям, причем, чем младше ребенок, тем несовершеннее функции кожи. У маленьких детей недостаточно развиты терморегулирующая и выделительная функции кожи, сравнительно легко возникают аллергические кожные реакции. Потовые железы не закончили своего развития, поэтому потеря воды и минеральных веществ через кожу у детей в раннем возрасте в 2-3 раза больше, чем у взрослых. Для сохранения водного и солевого равновесия организм ребенка нуждается в строгом соблюдении режима питания и питья.

У детей хорошо развита всасывательная функция кожи, которую необходимо учитывать при нанесении ребенку лечебных или косметических мазей и кремов, строго соблюдая возрастную дозировку. Дыхательная функция кожи играет в жизнедеятельности детского организма гораздо большую роль, чем у взрослого. У малышей очень несовершенны защитные возможности кожи. Трещины и ссадины у них на коже могут явиться воротами для любой инфекции.

У детей раннего возраста при оценке состояния кожи используют два основных показателя: эластичность и тургор. Эластичность кожи определяют по кожной складке на животе. Если собранная в складку кожа быстро расправляется — эластичность нормальная, если складка не расправляется, то эластичность кожи нарушена. Такое нарушение может наблюдаться при обезвоживании организма из-за быстрой потери воды, например при желудочно-кишечных заболеваниях.

Тургором кожи обозначается сопротивление, которое ощущается при сдавливании кожи и подкожной клетчатки. Определяется тургор на внутренней поверхности бедер. Наиболее часто он ослабевает при острых и хронических расстройствах питания.

Большое значение имеет соблюдение гигиены кожи в профилактике не только кожных, но и других, особенно желудочно-кишечных, заболеваний. Прежде всего необходимо соблюдение чистоты и здорового состояния кожных покровов. Особое значение имеет **гигиена кожи детей первого года жизни**, когда она особенно уязвима

для самых разнообразных неблагоприятных воздействий. Для ухода за кожей грудного ребенка надо иметь специальную ванну для купания, мягкую мочалку, детское мыло, растворы марганцевокислого калия и борной кислоты, стерильное минеральное или растительное масло, вату, марлевые тампоны, небольшие ножницы и пр.

Ребенка можно купать после отпадения пуповины. В первую половину года, когда кожа малыша особенно нежна и ранима, гигиеническую ванну надо делать ежедневно, с шести месяцев его можно купать через день, после года — два раза в неделю, а после трех лет — один раз в неделю и обязательно ежедневно подмывать и обмывать ноги.

До полного заживления пупочной ранки ребенка купают в кипяченой воде или в слабом (бледно-розовом) растворе марганцевокислого калия. Перед купанием надо чистыми руками промыть детскую ванночку горячей водой с мылом, на дно ее положить чистую пеленку и налить воду, температура которой 36-37°C. Температура воздуха в помещении, где купают ребенка, в первые месяцы его жизни должна быть 22°C, затем 20°C. Тело ребенка осторожно погружают в воду, головку кладут на предплечье.

В первые дни взрослый сначала рукой, а затем мягкой губкой или варежкой, специально сшитой из мягкой ткани, обмывает тело ребенка водой (с мылом малыша купают не каждый день, а 2-3 раза в неделю). Во время купания надо следить, чтобы вода не попадала в глаза, уши и нос. После того как тело ребенка обмыто, голову и лицо промывают чистой кипяченой водой, а затем, повернув вниз лицом, его обливают водой, температура которой на 1-2°C ниже температуры воды в ванной.

Необходимо следить за тем, чтобы ребенок все время находился в чистой и сухой одежде и пеленках. После акта дефекации ребенка следует подмыть теплой проточной водой (температура 36-37°C), обсушить осторожным прикладыванием мягкого полотенца или простынки и завернуть в чистое, сухое белье. Ежедневно надо смазывать вазелиновым или подсолнечным маслом те места, где легко образуется опрелость. Применять присыпки не рекомендуется, так как, скатываясь в комочки, они сами нередко вызывают раздражение кожи. Для предупреждения образования опрелостей в тех местах, куда попадает срыгиваемая пища, следует прокладывать небольшую пеленку, сложенную в виде салфетки, концы которой закладываются за головку. Это предохраняет кожу и белье ребенка от срыгиваемых им масс. После каждого срыгивания салфетку надо менять.

Обслуживающий персонал детского учреждения должен ежедневно осматривать тело ребенка и обращать внимание на появление на коже даже небольшого покраснения или незначительной сыпи. В каждом таком случае малыша следует показать врачу. Если на коже ребенка имеются мелкие травмы (трещины, царапины, заусеницы, ссадины), их надо немедленно промыть кипяченой водой и смазать йодной настойкой или бриллиантовой зеленью, кровоточащие ранки промыть дезинфицирующим раствором и наклеить лейкопластырем.

3. Особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата ребенка

Скелет ребенка в процессе роста и развития подвергается сложным преобразованиям. Внутриутробно окостенение скелета происходит довольно поздно, и при рождении в нем еще много хрящевой ткани, особенно в позвоночнике, запястьях, костях таза. Костная ткань у ребенка грудного возраста имеет волокнистое строение, бедна минеральными солями, богата водой и кровеносными сосудами. Поэтому кости ребенка легкие, гибкие, не обладают достаточной прочностью, легко поддаются искривлению и приобретают неправильную форму под влиянием давления или при

систематическом неправильном положении тела. К 2 годам их строение уже в значительной степени приближается к строению костей взрослого.

Позвоночник у новорожденного выпрямлен, не имеет физиологических изгибов. Они появляются позднее, по мере роста ребенка и формирования новых функций:

- удержание головы — шейный лордоз — в 2 месяца,
- сидение — грудной изгиб — в 6 месяцев,
- ходьба — поясничный лордоз — после года.

Хотя к 3-4 годам и появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, постоянство шейной кривизны устанавливается к 7 годам, а поясничной — лишь к 12 годам. Позвоночник ребенка отличается очень большой гибкостью. Неблагоприятные внешние воздействия, длительно сохраняющаяся неправильная поза легко могут вызвать его искривления. Таз у детей до 3 лет состоит почти целиком из хрящевой ткани.

Ребенок рождается с зачатками молочных и постоянных зубов, которые прорезываются в определенные сроки. У здоровых детей обычно передние резцы появляются в 6-8 месяцев, боковые резцы — в 8-12 месяцев, первые моляры (четвертые пары зубов сверху и снизу) — в 12-16 месяцев, клыки (третьи пары) — в 16-20 месяцев, вторые моляры (пятые пары) — в 20-30 месяцев. Смена молочных зубов на постоянные начинается с 5-6 лет.

Сроки прорезывания молочных зубов и их смены на постоянные во многом зависят от состояния организма, поступления и обмена минеральных веществ, индивидуальных (наследственных) особенностей. Значительная задержка прорезывания зубов заставляет задуматься о латентном (вялом) течении рахита или отклонениях в формировании костной ткани организма, обусловленных каким-либо заболеванием.

Мышцы новорожденного и ребенка грудного возраста составляют около 25% массы его тела, т. е. почти наполовину меньше, чем у взрослого. Новорожденный обладает только хаотичной двигательной активностью. Координированные мышечные движения проявляются вначале у мышц шеи, что выражается в удерживании головы; затем при соответствующих условиях формируется хватательная функция кисти, которой предшествует развитие мышц плеча и предплечья; позже наблюдаются координированные движения туловища и нижних конечностей. Мышцы у ребенка слабые; постепенно их сила увеличивается в большей степени у мальчиков. Становлению координации и силы мышц в значительной степени способствуют гимнастика и массаж, которые нужно проводить со второго месяца жизни ребенка.

Становление костно-мышечной системы, интенсивно растущей и совершенствующейся на протяжении всего дошкольного детства, в значительной мере зависит от поступления необходимых для формирования костной и мышечной ткани питательных веществ (прежде всего белков, солей кальция и фосфора, витамина D). Вторым существенным условием ее оптимального развития является рациональный режим статических и динамических нагрузок, обеспечение достаточной двигательной активности. Для его соблюдения необходима правильная организация бодрствования, включающая наряду с физическими упражнениями достаточную возможность для подвижных игр.

4. Особенности и гигиена органов дыхания и голосового аппарата

Система органов дыхания ребенка имеет значительные особенности. Нос меньше и короче, носовые ходы уже, особенно у детей грудного возраста, слизистая оболочка

богата кровеносными сосудами — все это приводит к легкому возникновению отека и нарушения носового дыхания. Глотка у детей раннего возраста узкая, а слуховая евстахиева труба короткая и широкая. Ее отверстие расположено ниже и ближе к носовым ходам, чем у старших детей и взрослых, поэтому проникновение инфекции из носоглотки в слуховую трубу происходит очень легко.

Гортань у детей первого года жизни имеет воронкообразную форму, она относительно длиннее, чем у более старших детей, ее слизистая оболочка и голосовые связки нежны, богаты кровеносными сосудами и лимфоидной тканью. Такое строение обуславливает частое развитие отека гортани (крупа) в этом возрасте. На втором году жизни форма гортани постепенно меняется, но остальные особенности сохраняются на всем протяжении раннего детства. Все особенности анатомического строения гортани присущи и трахее. Здесь также легко развиваются воспалительные процессы и велика опасность отека.

Бронхи у детей узки, хрящи мягки и податливы. Слизистая оболочка сухая, но богата кровеносными сосудами, что также способствует развитию воспалительных явлений и отека. Легкие в раннем возрасте богаты соединительной тканью, обильно снабжены кровеносными сосудами; капилляры и лимфатические сосуды широкие, эластическая ткань развита слабо. Однако они менее воздушны и эластичны, более плотны и полнокровны, что облегчает легкое возникновение и развитие воспалительного процесса. Плевра в грудном возрасте тонка, плевральная полость легко растяжима. Диафрагма расположена относительно выше, чем у взрослого. В раннем детском возрасте сокращение диафрагмы слабое. Все условия, затрудняющие ее движения (метеоризм, увеличение печени), ухудшают вентиляцию легких.

Грудная клетка у грудного ребенка выпуклая, относительно короткая; ребра расположены горизонтально и под прямым углом к позвоночнику. Поскольку в первые месяцы жизни легкие больше грудной клетки, вентиляция недостаточно полная, затруднен полный выдох. На втором году жизни интенсивно изменяются форма грудной клетки и положение ребер, они переходят из горизонтального в косое положение, таким образом облегчаются дыхательные движения и вентиляция легких.

Дыхательная мускулатура у малышей развита слабо. Упругость легочной ткани выше, а растяжимость ниже, чем у взрослых и детей школьного возраста, относительно малый диаметр бронхов создает в дыхательных путях дополнительное сопротивление. Таким образом, чем моложе ребенок, тем большую работу выполняет он для обеспечения вентиляции легких.

Повышенный обмен веществ у детей обуславливает высокую потребность в кислороде, между тем особенности легких и грудной клетки во многом ограничивают глубину дыхания. Интенсивность газового обмена обеспечивается увеличением частоты, дыхания. Наибольшее число дыханий в минуту отмечается после рождения — 50-60, что иногда называют «физиологической одышкой» новорожденного, затем оно снижается с увеличением возраста. Так, у детей 1-2 лет оно находится в пределах 30-35, 5-6 лет — около 25, 10 лет — 18-20, у взрослых — 15-16.

В профилактике воспалительных заболеваний органов дыхания большое значение имеет соблюдение режима дня, занятия физкультурой, закаливание, лечение болезней, ослабляющих детский организм (таких, как малокровие, рахит, гипотрофия). Активный двигательный режим, достаточно свободная одежда, не стесняющая движения грудной клетки, дыхательные упражнения в комплексе утренней гимнастики,

физкультурные занятия, массаж и пассивная гимнастика у грудных детей, хорошая вентиляция помещений стимулируют воздухообмен и кровоток в легких, способствуя таким образом профилактике воспалительных явлений.

Большую роль в предупреждении заболеваний органов дыхания и голосового аппарата играет правильное дыхание — через нос. При носовом дыхании воздух, прежде чем попасть в гортань, бронхи и легкие, проходит через узкие, извилистые носовые пути, где очищается от пыли, микробов и других вредных примесей, увлажняется и согревается.

Дыхание через рот у детей чаще всего возникает при хроническом насморке, появлении в носоглотке *аденоидов* — разрастания лимфатической ткани на ее задней стенке. Нарушение носового дыхания отрицательно сказывается на общем состоянии ребенка: он бледнеет, становится вялым, легко утомляется, плохо спит, страдает головными болями, физическое и психическое развитие его замедляется. Такого ребенка надо срочно показать врачу. Если причиной неправильного дыхания являются аденоиды, их удаляют. После операции состояние ребенка значительно улучшается, физическое и умственное развитие быстро приходит к норме.

5. Особенности и гигиена органов пищеварения в детском возрасте

Нормальное развитие ребенка находится в тесной связи с деятельностью его органов пищеварения. Расстройство пищеварения приводит к расстройству питания, нарушению обмена, которое нередко сопровождается нарушением функций многих органов и систем.

Органы пищеварения ребенка, особенно раннего возраста, отличаются функциональной незрелостью и повышенной уязвимостью. В то же время интенсивность обмена веществ у детей требует высокой активности пищеварительных процессов. Поэтому педиатрия и детская гигиена уделяют большое внимание изучению и разработке детского питания и гигиеническим принципам его организации. Рациональное питание, соответствующее потребностям ребенка и отвечающее гигиеническим требованиям, — основная профилактика заболеваний органов пищеварительного тракта.

Органы пищеварения у детей раннего возраста имеют свои особенности. Малышам трудно усваивать сухую, жесткую и твердую пищу, у них легко возникают такие расстройства, как рвота и срыгивание, поносы и запоры. Проницаемость стенок кишечника у детей раннего возраста повышена, при его заболеваниях она способствует развитию интоксикации; кишечные инфекции часто сопровождаются нейротоксикозом и поражением сердечно-сосудистой системы.

Кишечник сразу после рождения стерилен, но с первых часов начинается заселение его микроорганизмами. Микрофлора в первые месяцы жизни в значительной степени обусловлена характером вскармливания. Она выполняет в организме определенные функции: подавляет и уничтожает болезнетворных и гнилостных микробов, принимает участие в синтезе витаминов и обладает ферментативными свойствами. Однако при ослаблении защитных сил организма или болезненных изменениях в кишечнике некоторые микробы, не опасные при других обстоятельствах, могут вызвать заболевания, объединяемые под названием **дисбактериоз**.

Согласованной работе органов пищеварения и пищеварительных желез способствует режим питания. К четко установленному времени приема пищи активность пищеварительных желез возрастает, они начинают вырабатывать пищеварительные соки

еще до того, как пища поступит в желудок. У ребенка появляется аппетит, он охотно съедает предложенную пищу, которая хорошо обрабатывается и усваивается организмом.

Важно, чтобы ребенок перед уходом в детский сад не получал завтрак. Даже небольшое количество съеденной пищи снижает аппетит и нарушает дальнейший ритм пищеварения. Очень важно, чтобы трехразовое питание детей в дошкольном учреждении обязательно дополнялось четвертым приемом пищи дома (ужином). Обеспечению наиболее полноценного рациона ребенка в течение суток служит составление врачом детского учреждения рекомендаций для ужина, которые ежедневно вывешиваются в приемных комнатах групп. Следует проводить с родителями разъяснительную работу о важности своевременного полноценного питания, бороться с «кусочничеством», когда взрослые, пришедшие за ребенком в детское учреждение, тут же дают ему в руки булку, печенье или конфету, перебивая таким образом аппетит перед ужином.

6. Гигиена полости рта, профилактика кариеса

Забота о молочных зубах имеет важное значение как для будущих — постоянных — зубов, так и для здоровья всего организма в целом. Молочные зубы очень уязвимы, они имеют тонкую эмаль, легко подвержены кариесу. Состояние молочных зубов в значительной степени зависит от питания матери во время беременности и от питания самого ребенка, достаточного поступления в организм солей кальция и фтора.

Кариес — разрушение эмали зуба под воздействием молочной кислоты, выделяемой бактериями. Распространенность его очень велика — больше 90% населения, включая детей, больны кариесом. Пораженные кариесом зубы создают хронический очаг инфекции в организме, который при неблагоприятных обстоятельствах может вызвать распространение возбудителя с током крови и поражение почек, сердечной мышцы, а также инфицировать зачатки постоянных зубов, расположенных под ними, и способствовать их разрушению. При кариесе дети хуже пережевывают пищу, что отрицательно влияет на дальнейшее пищеварение.

Тщательный уход за зубами предупреждает кариес. Приучать малыша чистить зубы надо со второго года жизни — сначала просто мягкой зубной щеткой, а затем с применением детских гигиенических зубных паст. С 3-4 лет можно переводить ребенка на использование лечебно-профилактических зубных паст. Щетка для малыша должна быть мягкой, обязательно с искусственной щетиной. Весь процесс чистки зубов должен занимать не менее 2-3 мин, так как за это время впитываются многие полезные элементы зубной пасты. Надо приучать детей чистить зубы дважды в день: утром — после завтрака и на ночь — перед сном, обучать правильным приемам их чистки.

Профилактике кариеса способствует также фторирование питьевой воды или употребление в пищу фторированной соли. Передозировка фтора также приводит к поражению зубной эмали —

флюорозу, поэтому без определения уровня фтора в воде добавление его в воду или пищу не рекомендуется. На заболеваемость кариесом сильно влияет употребление детьми сладостей: при повышенной концентрации сахара в полости рта активно размножаются бактерии, выделяющие молочную кислоту, вредную для зубной эмали. Ограничение сладостей и привычка полоскать рот после каждого употребления пищи (в том числе сладостей) способствует сохранению зубов здоровыми.

7. Гигиена зрения у детей

В воспитательной работе с детьми работники дошкольных учреждений должны помнить об охране зрения ребенка, знать наиболее часто встречающиеся нарушения зрительных функций, чтобы своевременно выявлять и предупреждать их.

Предупреждение нарушений зрения начинается еще до рождения ребенка — забота о здоровье беременной женщины очень важна для правильного формирования зрительного анализатора. Со второго месяца жизни у ребенка формируется предметное зрение — его кроватку надо располагать в самой светлой части комнаты, но следить, чтобы свет солнца или лампы не слепил глаза. Показывая игрушки, располагать их надо на расстоянии 25-30 см от лица ребенка, тогда они не занимают всего поля зрения, и ребенок может отвести взгляд и расслабить мышцы хрусталика.

Достаточная двигательная активность и пребывание на свежем воздухе, систематическое закаливание, рациональное питание способствуют хорошему функциональному состоянию нервной системы и тем самым хорошему состоянию зрения. Любое заболевание организма может повлиять на зрение, часто отмечается связь между травмами и развитием близорукости. После любой травмы, особенно сотрясения мозга, даже легкой степени, ребенок должен быть осмотрен офтальмологом.

Дополнительные зрительные нагрузки — просмотр диафильмов, видео - и телепередач, компьютерные игры — в значительной степени влияют на состояние зрения. ***Для охраны зрения в дошкольных учреждениях необходимо выполнять гигиенические требования к организации просмотра диапозитивных фильмов и телевизионных передач.***

Диапозитивные фильмы должны по содержанию соответствовать возрасту детей. Количество кадров в фильме не должно превышать для младших групп детского сада 25-30, средних — 35-40 и старших — 45-50. Детям 3-5 лет можно показать один-два диапозитивных фильма в течение 12-15 мин, старшим (6-7 лет) — два фильма, если общая их продолжительность не превышает 20-25 мин.

Экраны для показа диафильмов должны быть белыми (можно использовать белое полотно или ватманскую бумагу). Лучше всего иметь специальный экран ЭПП-1 или ЭПП-2 с коэффициентом отражения, равным 0,8. Центр экрана должен располагаться на уровне глаз дошкольников, сидящих на стульях (1-1,2 м от пола). Так как яркость освещения экрана зависит от срока службы лампы в фильмоскопе, то надо следить, чтобы он не превышал 20-30 часов, т. е. 40-50 сеансов.

Первый ряд стульев располагают от экрана на расстоянии, равном двойной его ширине, последний — не более 4 м от экрана.

Телевизор устанавливают на столике высотой 1-1,2 м над полом, добиваются хорошего качества изображения. Стулья расставляют так, чтобы первый их ряд стоял не ближе 2 м, последний — не дальше 5 м от экрана. В промежутке между первым и последним рядами устанавливают ряды стульев по 4-5 в каждом, на них удобно можно рассадить одну группу детей.

Продолжительность телевизионной передачи для детей четырех-пяти лет — не более 20 мин, для детей 6-7 лет — не более 30 мин.

В дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами во избежание отражения солнечных бликов на экране. В помещении, кроме светящегося экрана, необходимо иметь дополнительное освещение, естественное или искусственное, источник

которого расположен вне поля зрения детей. Это дополнительное освещение снижает утомление глаз при просмотре телевизионных передач.

Лекция 2: Рациональный режим жизни детей различных возрастных групп

План

- 1. Гигиеническая организация сна в дошкольных учреждениях**
- 2. Гигиеническая организация бодрствования детей**
- 3. Физическое воспитание, укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной осанки и закаливание организма**

Для организации правильного режима необходимо строить его в зависимости от ритмичности физиологических процессов. Известно, что живые механизмы обладают «внутренними часами», способными измерять время. На их основе вырабатываются биологические околосуточные («циркадные») и околόμεсячные ритмы, которые обусловлены колебаниями обменных процессов, связанных с цикличностью воздействий среды и регулирующим влиянием нервной системы.

В течение суток с определенной закономерностью изменяются температура тела, деятельность органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой и других систем. Особенно чувствительна к изменениям внешней и внутренней среды нервная система. Одной из основных причин нарушения суточного ритма является истощение клеток мозга и необходимость предохранения их от разрушения путем периодического сна. У взрослых и более старших детей главное время сна совпадает с темным временем суток, когда резко уменьшается количество возбуждающих мозг сигналов.

У детей раннего возраста нервные процессы истощаются особенно легко, и для них естественны более продолжительный сон и чередование его с бодрствованием в дневное время. В процессе жизнедеятельности ребенка на основе ритмичности физиологических функций вырабатываются и условные рефлексы на время. Построение режима с учетом биологических ритмов способствует активной жизнедеятельности органов и тканей, а также всего организма в целом, сохранению энергии и сил, росту и развитию ребенка.

На протяжении раннего и дошкольного возраста в соответствии с изменениями длительности бодрствования, сна и перерывов между кормлениями, режим меняется несколько раз. Где бы ни находился ребенок (дома в семье, в детском учреждении любого типа, одновозрастной или смешанной группе, в изоляторе или больнице), он должен жить по режиму, соответствующему его возрастным и индивидуальным особенностям и состоянию здоровья. Правильный ритм режимных моментов охраняет нервную систему от переутомления, благоприятно влияет на характер бодрствования и качество сна.

Бодрствование ребенка связано с активным состоянием клеток головного мозга, находящихся в активном взаимодействии с окружающей средой. Центральная нервная система детей раннего и дошкольного возраста еще слаба и во время бодрствования легко утомляется. Длительность периода бодрствования у маленького ребенка определяется пределом работоспособности нервной системы. Для восстановления нормального состояния нервных клеток огромное значение имеет правильно организованный и достаточно продолжительный сон ребенка. Сон характеризуется разлитым торможением в

клетках головного мозга, ослаблением восприимчивости органов чувств (слуха, зрения, осязания) и реакций на внешние раздражители, снижением двигательной активности.



Бодрствование и сон — взаимосвязанные состояния нервной системы: полноценный сон обеспечивает активное бодрствование и в то же время сон возможен только после достаточно длительного и продуктивного бодрствования («хороший сон надо заработать»).

Соблюдение режима имеет большое значение для здоровья и оптимального развития ребенка, однако в отдельных случаях от него возможны отступления, продиктованные потребностями конкретного ребенка в конкретной ситуации. Например, если поведение ребенка свидетельствует об утомлении, его следует уложить раньше спать; если ребенок крепко спит, целесообразно дать ему выспаться, а не будить «по режиму». Если такие отступления от режима часты, это свидетельствует о несоответствии режима индивидуальным особенностям ребенка (возможно, он нуждается в уменьшении кратности дневного сна или удлинении периода бодрствования).

1. Гигиеническая организация сна в дошкольных учреждениях

Детям в дошкольном учреждении необходимо обеспечить оптимальную для каждой возрастной группы продолжительность сна, быстрое засыпание, крепкий сон и спокойное пробуждение. Новорожденный ребенок спит большую часть суток, однако сон его еще неустойчив и беспорядочен. На втором месяце жизни бодрствование становится более длительным, а в 2-3 месяца может продолжаться до 1,5 ч. К году его продолжительность удлиняется до 3 ч, к 3 годам — до 5,5-6 часов.

Дети старшего дошкольного возраста с устойчивой здоровой нервной системой нередко отказываются от дневного сна (не засыпают при укладывании). В таких случаях нецелесообразно настаивать на пребывании ребенка в постели, надо предоставить ему возможность спокойного отдыха с каким-либо тихим занятием по вкусу.

Укладывают детей постепенно, не спеша, примерно в течение 25-30 мин. Младших, ослабленных, тех, кто проснулся раньше, укладывают первыми, более старших, крепких, вставших последними укладывают вслед за ними. Во время засыпания детей не должно быть громких разговоров, резких звуков. Чтобы создать у детей положительное отношение ко сну, движения ухаживающего за ними персонала должны быть спокойными, мягкими, речь тихой, ласковой.

2. Гигиеническая организация бодрствования детей

Если полноценный, правильно организованный сон необходим ребенку для защиты нервных клеток от переутомления и восстановления работоспособности организма в целом, то период бодрствования — время, когда удовлетворяются его основные физиологические и психологические потребности. От того, как организовано бодрствование, в значительной степени зависит, насколько продуктивным будет ребенок в своей деятельности и насколько успешным будет его развитие. Важное значение имеют гигиенические условия среды, в которой находится ребенок во время бодрствования:

достаточная освещенность, низкий уровень шума, свежий воздух, соответствие мебели, оборудования, игрушек его возрасту и уровню развития; не менее важен адекватный физиологическим потребностям ребенка ритм кормлений, чередование занятий и гигиенических процессов.

Важное условие бодрствования в любом возрасте — активность ребенка. Обеспечение достаточной двигательной активности — необходимое условие, повышающее эффективность обучения и оздоровления. Потребность ребенка в движениях при пребывании в детском коллективе не может быть обеспечена только занятиями гимнастикой, зарядкой и музыкальными занятиями.

Для движения необходимы простор, стимуляция со стороны взрослых. В группе обязательно должно быть предусмотрено место и для отдыха с подвижными играми, чтобы ребенок во время самостоятельной деятельности мог побегать, попрыгать, залезть куда-то, посидеть и даже полежать.

Искусственное ограничение движений недопустимо. Наоборот, если ребенок не двигается достаточно активно, то у персонала должна возникать тревога за его самочувствие.

Очень существенна правильная организация занятий, их длительность. Занятия, помимо обучающей функции, вносят разнообразие в деятельность детей, развивают их любознательность, повышают эмоциональный настрой. Однако они могут вызвать утомление и негативную реакцию у ребенка. Поэтому обязательным условием проведения занятий должно быть строгое соблюдение их длительности, допустимой нагрузки, внимание к эмоциональной реакции ребенка. Организуя деятельность ребенка, надо учитывать не только возраст, но и состояние здоровья, индивидуальные особенности и жизненный опыт.

Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе Типовой программы воспитания и обучения в детском саду.

3. Физическое воспитание, укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной осанки и закаливание организма

Систематические физические упражнения способствуют развитию всех органов и систем, и в первую очередь двигательного аппарата детей, повышают мышечный тонус ребенка, улучшают темп, силу, координацию движений и общую выносливость. Интенсивная активность мышц влечет за собой усиление сердечной деятельности, иными словами, тренировку сердца — органа, от работы которого зависит обеспечение всего организма кислородом и питательными веществами.

Под влиянием занятий физкультурой возрастает регуляция сосудистого тонуса, увеличивается количество циркулирующей крови, усиливается кровоток, уменьшаются застойные явления в органах и тканях, повышается содержание гемоглобина и эритроцитов, усиливается иммунологическая активность крови и тканей. Возрастание глубины дыхания, улучшение вентиляции легких активизирует окислительно-восстановительные процессы в организме. Физические упражнения способствуют улучшению обмена веществ, особенно в органах опорно-двигательного аппарата ребенка. Большое значение имеют лечебная гимнастика и массаж в нормализации функционального состояния высшей нервной деятельности больного ребенка, в повышении его эмоционального тонуса. С первых месяцев жизни над кроваткой ребенка подвешивают яркие игрушки, которые он может захватывать руками, на полу манежа раскладывают различные интересные предметы. Стремясь дотянуться до них, ребенок

быстрее приобретает умение переворачиваться со спинки на живот и обратно, ползать, садиться. Большое значение для правильного развития его мускулатуры и двигательного аппарата имеют **массаж, пассивная и активная гимнастика**.

Гимнастика рекомендуется детям всех возрастов, тогда как общий массаж здоровым детям делают до полутора лет жизни. Массаж — один из видов пассивной гимнастики. Он оказывает регулирующее влияние на функции сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем, воздействует на рецепторный аппарат поверхностных и глубокорасположенных тканей, улучшает обмен веществ. Стимуляция чувствительных рецепторов кожи способствует созреванию нервной системы, улучшает тонус организма.

Массаж для детей раннего возраста всегда сочетается с физическими упражнениями. Объем активных движений в раннем возрасте относительно небольшой — массаж стимулирует их развитие.

После 2 лет ребенок учится подниматься и спускаться по наклонной плоскости, перелезать через препятствия, бросать мяч, в 2,5-3 года стремится бегать, после 3 лет — прыгать. В его комплекс упражнений вводятся элементы бега и прыжки. Чтобы избежать переутомления одной группы мышц, не следует повторять упражнения более 5-6 раз. Нельзя также делать пассивные упражнения при повышенном тонусе мышц ребенка (например, при физиологической гипертонии мышц в первые два месяца жизни), в таких случаях возможны только массаж и рефлекторные упражнения. После 2-2,5 лет занятия проводятся с речевым сопровождением. Важно, чтобы ребенок полностью понимал речь взрослого. С целью повышения его интереса к упражнениям и уменьшения усталости комплекс упражнений периодически меняется.

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях проводится в соответствии с Типовой программой по физической культуре в детском саду. Программа составлена с учетом возрастных особенностей развития детей на каждом году жизни и направлена на укрепление здоровья и совершенствование функциональных возможностей детского организма.

Физкультурные занятия состоят из трех частей: непродолжительной **вводной**, подготавливающей организм; **основной**, включающей подвижные игры и упражнения в основных движениях; **заключительной**, в результате которой организм возвращается в исходное состояние. Упражнения и подвижные игры подбирают с учетом воздействия на группы мышц, участвующих в сохранении правильного положения туловища, головы, плечевого пояса.

Разнообразное спортивное оборудование: гимнастические стенки, заборчики для лазанья, горки, стойки для прыжков, а также мячи, обручи, флажки и др. — позволяет детям быстрее усвоить нужные движения, делает занятия более увлекательными. Желательно часть оборудования разместить в группах и чтобы дети имели к нему свободный доступ. Однако все рекомендованное спортивное оборудование в групповой комнате разместить нельзя, физкультурные занятия лучше проводить в специально оборудованных помещениях (спортивных залах), площадь которых не менее 3 м² на ребенка.

Для проведения массажа и физкультуры важное значение имеют температурные условия окружающего воздуха. Температура в помещении должна быть не ниже 20°C, с открытым окном — 20-22°C. В теплое время года занятия по развитию движений следует

проводить на воздухе, летом на воздухе в тени при 20-22°C. Одежда во время занятий должна быть легкой, не стесняющей движений: дети занимаются в майках, трусах, носках и тапочках (чешках). После массажа и физкультуры прогулка разрешается зимой не раньше, чем через 30 мин.

Начиная с четвертого года жизни помимо физкультурных занятий проводят утреннюю гимнастику. Продолжительность зарядки — 6-8 мин.

Утренней гимнастике в системе физкультурных занятий ребенка придается важнейшее значение.

В грудном возрасте гимнастические упражнения строго индивидуальны. Они всегда выполняются при активном участии взрослого, с учетом возрастных особенностей, сезона и состояния здоровья ребенка. Утренняя гимнастика у детей старшего ясельного возраста, а также у дошкольников и особенно школьников — групповое мероприятие. Здесь необходим лишь предварительный отбор детей и наблюдение за общей реакцией во время выполнения упражнений и после него. Комплекс утренней гимнастики должен составляться в соответствии с возрастом и включать упражнения, тренирующие основные крупные мышечные группы ног, плечевого пояса, спины, живота.

Закаливание

Организм человека непрерывно подвергается разнообразному воздействию внешней среды (солнечная радиация, химический состав атмосферного воздуха и его физические свойства, вода и др.).

Из всех факторов внешней среды наиболее длительное, по существу непрерывное воздействие на организм оказывает воздушная среда, солнечная радиация и вода.

Приспосабливаясь к сложному воздействию всех перечисленных внешних условий, организм способен уменьшить или увеличить свои теплопотери благодаря увеличению или уменьшению количества крови, притекающей к кожным покровам. Большой или меньший приток крови к коже в свою очередь обусловлен способностью кожных капилляров сужаться или расширяться в просвете (диаметре).

Сужение и расширение кожных капилляров осуществляется мышцами капилляров. В ответ на получаемые извне холодовые и тепловые раздражения из центральной нервной системы к кожным капиллярам по сосудосуживающим и сосудорасширяющим (сосудодвигательным) нервам направляются соответствующие импульсы. В результате кровенаполнение кожи либо увеличивается, и она отдает больше тепла в окружающую среду, либо уменьшается, и теплоотдача понижается.

Закаливание в раннем и дошкольном возрасте следует рассматривать как важнейшую составную часть физического воспитания детей. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы: воздух, солнце и вода. Под закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма главным образом низким температурам, поскольку в возникновении ряда заболеваний играет важную роль охлаждение организма (болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, почек, ревматизм и т. п.).

Цель закаливания — выработать способность организма быстро изменять работу органов и систем в зависимости от изменений внешней среды. Способность организма приспосабливаться к определенным внешним условиям вырабатывается многократным повторением воздействия того или иного фактора (холода, тепла и т. п.) и постепенного повышения его дозировки.

В процессе закаливания в организме ребенка происходят весьма сложные изменения. Клетки покровов тела и слизистых оболочек, нервные окончания и связанные с ними нервные центры начинают быстрее и целесообразнее реагировать на изменения окружающей среды. Все физиологические процессы в тканях и органах, в том числе расширение и сокращение кровеносных сосудов, протекают экономнее, быстрее и совершеннее. Кроме того, окрепшие под влиянием закаливания кожа и слизистые оболочки становятся менее чувствительными и проницаемыми для ряда болезнетворных микробов и их ядов, а способность организма к борьбе с уже проникшими в него микробами возрастает. В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к резким

изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к другим инфекционным болезням. Закаливание благотворно действует на общий тонус и подвижность нервной системы, на состояние других жизнеобеспечивающих систем организма, поэтому закаленные дети, как правило, обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью.

Принципы закаливания

Чтобы получить положительные результаты от применения закаливающих процедур, необходимо соблюдать основные принципы:

1. Постепенное увеличение дозировки раздражителя. Постепенность заключается прежде всего в том, что первые закаливающие процедуры должны как по своей силе, так и по длительности вызывать минимальные изменения в организме, и лишь по мере привыкания к данному раздражителю их можно осторожно усиливать. Закаливание лучше начинать в летнее время года, когда температура воздуха выше, чем в другие сезоны, и колебания ее не бывают резкими.

2. Последовательность применения закаливающих процедур. К водным процедурам и солнечным ваннам лучше переходить после того, как ребенок привык к воздушным ваннам, вызывающим меньшие изменения в организме; к обливанию не допускать детей, пока они не привыкли к обтиранию, а к купанию в открытых водоемах — раньше, чем с ними не проведены обливания.

3. Систематичность начатых процедур. Нельзя прерывать закаливающие процедуры без серьезных к тому оснований, так как исчезают выработанные в процессе закаливания защитные механизмы и чувствительность организма к внешнему раздражителю снова повышается.

4. Комплексность. Специальные закаливающие процедуры не дают нужных результатов, если они не сочетаются с мероприятиями в повседневной жизни ребенка, направленными на укрепление его организма (прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика, регулярное проветривание помещений и т. д.), и если они не проводятся комплексно. Так, воздушные ванны желательно сочетать с подвижными играми, физическими упражнениями и физической работой. Эти виды деятельности сопровождаются активными движениями, вызывающими потребность в глубоком дыхании, при котором площадь слизистых оболочек дыхательных путей, соприкасающаяся с воздухом, увеличивается.

5. Учет индивидуальных особенностей ребенка. Прежде чем начать закаливание, необходимо тщательно изучить физическое и психическое развитие каждого ребенка, проанализировать его индивидуальные реакции. На основании данных медицинского

обследования, педагогических наблюдений, сведений, полученных от родителей, воспитатель составляет характеристику ребенка.

При проведении закаливающих мероприятий в детских учреждениях всех детей по состоянию их здоровья делят на 3 группы.

Первая группа — практически здоровые дети, с которыми можно проводить полный комплекс закаливающих процедур.

Вторая группа — дети, с которыми закаливающие процедуры проводятся ограниченно. К ним относятся дети, предрасположенные к частым катарам верхних дыхательных путей, ангинам и другим простудным заболеваниям. Сюда же относятся дети со сниженным питанием, с повышенной реакцией на холодовые раздражители, проявляющиеся в виде спазма сосудов (бледность, «мраморная» окраска кожи, легкое возникновение озноба).

Третья группа — дети, которым в условиях массового проведения закаливающие мероприятия противопоказаны (имеющие острые или хронические воспаления среднего уха, почек, суставов, с пороком сердца; страдающие желудочно-кишечными заболеваниями).

6. Активное и положительное отношение детей к закаливающим процедурам. Результаты закаливания во многом зависят от того, как относятся к нему дети. Страх перед процедурами и тем более насильственное их проведение не будут способствовать положительному воздействию их на организм. Важно так продумать и организовать проведение процедур, чтобы они вызывали у детей положительные эмоции.

Лекция 3: Гигиенические основы питания как источник здоровья и нормального физического развития

План

1. **Состав пищи.**
2. **Вскармливание детей до 1 года: естественное вскармливание.**
3. **Искусственное и смешанное вскармливание.**
4. **Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет.**
5. **Питание детей дошкольного возраста.**

Правильное в количественном и качественном отношении питание — важнейший фактор роста и гармоничного развития ребенка. Оно необходимо для адаптации к меняющимся условиям внешней среды, высокой сопротивляемости болезням. Потребность в питательных веществах растущего, развивающегося и активно двигающегося ребенка очень высока. Вместе с тем организм маленьких детей может усвоить далеко не всякую пищу. Пища ребенка по своему количеству и качеству должна соответствовать особенностям пищеварительного тракта и удовлетворять потребность растущего организма в необходимых веществах.

Обеспечение детей пищей, адекватной их возможностям, имеет важное профилактическое значение, ведет к снижению детской заболеваемости.

1. Состав пищи

В понятие «рациональное вскармливание» включается введение пищевых веществ не только для создания источника энергии, но и для обеспечения оптимального обмена веществ, обеспечивающего жизнедеятельность органов и тканей, построение новых клеток и разрушение старых. Процессы обмена включают в себя ряд последовательных фаз — всасывание в кишечнике, внутриклеточные процессы усвоения, процессы накопления и расход энергии. В связи с этим основные пищевые вещества — белки, жиры, углеводы, минеральные соли, а также биологически активные элементы пищи (витамины) — должны вводиться в определенных количествах и иметь определенный качественный состав.

Белки. Быстрый рост ребенка требует сравнительно большого количества белка, являющегося основным пластическим (строительным) материалом. Из белков формируются клетки и ткани живого организма, они необходимы для синтеза гормонов, ферментов, для процессов кроветворения, выработки антител и формирования иммунитета.

Благодаря интенсивному росту и развитию у ребенка относительная потребность в белке выше, чем у взрослого. При искусственном вскармливании она выше, чем при естественном, в связи с тем что в желудочно-кишечном тракте усваивается около 90% белка коровьего молока и менее 60% — растительного, в женском же молоке содержится наиболее «идеальный» белок, усваивающийся почти полностью. Белок растительной пищи отличается и низкой биологической ценностью, поскольку часто не содержит незаменимых аминокислот: триптофана, фенилаланина, лизина, метионина, валина, лейцина, изолейцина и треонина. Для организма ребенка раннего возраста незаменимой аминокислотой является также гистидин, так как его синтез в первые годы жизни ограничен и не покрывает потребности растущего организма.

Жиры — один из источников энергии для организма. Кроме того, жиры обеспечивают многие биологические функции организма: участвуют в образовании клеточных мембран, являются носителями жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) и др. Часть жиров откладывается в печени, мышцах, под кожей, в сальнике, около почек и т. д., фиксируя и защищая многие органы, сосуды и нервы от травм, а весь организм в целом от излишних теплопотерь, а также создавая «стратегический запас» энергии.

Из *животных жиров* в детском питании предпочтительно использовать сливочное масло, которое содержит витамины А и D и хорошо усваивается детским организмом, так как температура плавления

этого жира ниже температуры тела ребенка (24-26°C). Тугоплавкие жиры, которые плохо усваиваются организмом: говяжий (температура плавления 41-43°C и тем более бараний (температура плавления 44-51°C) — лучше исключить из рациона детей первых лет жизни.

Углеводы — органические вещества, состоящие из углерода, водорода и кислорода. Они входят в состав продуктов растительного происхождения — овощей, фруктов, ягод, злаков — в виде сахарозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, крахмала и клетчатки. В организме человека и животных углеводы встречаются в виде животного крахмала — гликогена.

Углеводы разделяют на простые и сложные. *Сложные углеводы* — полисахариды, к которым относятся крахмал растений, гликоген животных, клетчатка, содержащаяся в

оболочках растительных клеток, — медленно расщепляются и усваиваются организмом. *Простые углеводы* — сахароза, глюкоза, фруктоза, галактоза и др. — имеют сладкий вкус и усваиваются организмом значительно быстрее.

Углеводы — важнейший источник энергии для организма. Они необходимы и как пластический материал, поскольку входят в состав всех клеток и тканей организма, а также способствуют синтезу белков и окислению жиров

Минеральные вещества входят в состав органов и тканей и играют большую роль во всех физико-химических процессах, протекающих в организме. Часть минеральных веществ содержится в клетках, другая часть находится во взвешенном состоянии в виде ионов в крови, лимфе и тканевой жидкости, многие из них являются составными частями гормонов, ферментов и сами по себе влияют на биохимические процессы. Минеральные вещества необходимы организму ребенка для построения скелета, правильного развития органов и систем, нервной, мышечной и костной ткани.

Основными элементами, необходимыми для жизнедеятельности организма человека, являются кальций, магний, калий, фосфор, хлор, сера. Потребность в кальции как главном строительном материале костной ткани у детей особенно велика, так как у них происходит интенсивное формирование костей. Кальций содержится в продуктах молочного происхождения, в овощах и фруктах.

Для строения костей, кроме кальция, необходим и фосфор. Около 80% от всего количества фосфора, необходимого ребенку, входит в состав костной, около 10% — в состав мышечной ткани. Достаточное количество фосфора в организме нормализует углеводный обмен и укрепляет нервную систему. Содержится фосфор в мясе, молоке, рыбе, зерновых (овес, просо) и бобовых растениях.

Железо входит в состав гемоглобина — сложного белкового соединения, находящегося в эритроцитах; оно содержится во фруктах, овощах, мясе, яичном желтке. Суточная потребность в железе у детей раннего возраста составляет 7-8 мг. Кроме перечисленных минеральных веществ, ребенку необходимы магний, медь, бром, йод, цинк, кобальт, фтор и некоторые другие минералы. Они получили название микроэлементов, так как содержатся в пище в минимальном количестве (менее 1мг/%). Они входят в состав многих ферментов, гормонов, витаминов и оказывают большое влияние на обмен веществ, рост и развитие организма. Недостаток того или иного из них в организме нередко влечет за собой специфическое заболевание: эндемический зоб при отсутствии йода, разрушение зубов при недостатке фтора и т. д.; медь, кобальт, молибден, марганец и другие элементы имеют важное значение для кроветворения и предупреждения малокровия.

Витамины — это группа биологически активных веществ, которые не являются строительным материалом или источником энергии, но необходимы организму для роста, развития, регуляции жизненных функций. Витамины играют важную роль в обмене веществ живого организма: без них нарушается нормальный обмен веществ, страдают пищеварение и кроветворение, падает работоспособность, снижается иммунитет и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-восстановительных процессах организма, регулирует деятельность ферментов и гормонов, рост хрящей и костей, повышает свертываемость крови, оказывает влияние на сопротивляемость организма к различным внешним воздействиям, в том числе к инфекциям. Витамин С играет важную роль в поддержании нормального состояния стенок капилляров и

сохранении их эластичности, при его недостатке усиливается проницаемость стенок капилляров, они становятся ломкими, появляется склонность к отекам и кровоизлияниям.

Витамин С в организме человека не образуется. Он содержится в овощах, зелени, фруктах, особенно в цитрусовых, ягодах (черная смородина, шиповник), в небольшом количестве — в мясе и молочных продуктах, особенно в летне-осенний период. Северные сорта растений содержат витамин С в большем количестве, чем южные. Основным поставщиком витамина С для большинства населения нашей страны является картофель, так как он употребляется значительно чаще, чем какие-либо другие растительные продукты. Однако надо помнить, что при хранении овощей и фруктов витамин С в них разрушается, поэтому к весне, например, картофель содержит лишь 50% витамина С по сравнению с осенью.

Витамин Р имеет много общего с витамином С, он стимулирует потребление кислорода клетками, препятствует разрушительному действию кислородной недостаточности, укрепляет стенки сосудов, уменьшает возникновение мелких кровоизлияний. В растительной природе выявлено большое количество веществ, обладающих Р-витаминной активностью. Все они получили общее название биофлавоноидов. Наиболее известен из них рутин, используемый в поливитаминных препаратах.

Потребность в витамине Р точно не установлена, ориентировочно для взрослых она составляет 35-50 мг в сутки. Витамин Р имеется в растительных продуктах: черноплодной рябине, черной смородине, шиповнике, цитрусовых, землянике, винограде, моркови, свекле, картофеле и др.

Витамины группы В принимают участие в процессах роста и обмена, особенно белкового и углеводного, способствуют нормальному кроветворению. При их недостатке в организме в первую очередь нарушаются состояние кожи, деятельность нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Витамины этой группы содержатся почти во всех растительных и молочных продуктах. Много их в пивных и пекарских дрожжах, мясе, печени, рыбе, злаках и особенно в оболочках и зародышах зерен. В то же время они практически отсутствуют в муке тонкого помола, перловой крупе, в хорошо очищенном, так называемом полированном, рисе.

Витамин В1 (тиамин) необходим для нормального протекания углеводного, белкового и жирового обмена. Недостаток его в организме приводит к неполному расщеплению веществ и накоплению продуктов их промежуточного обмена и, как следствие этого, к ухудшению функции нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем и желез внутренней секреции. Витамин В1 способствует росту и развитию детей, он необходим при физическом и нервном переутомлении, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Основным источником витамина В1 являются зерновые продукты, не освобожденные от зародыша, периферических частей оболочки, много его в дрожжах и печени. Он поступает в организм также с мясом, рыбой, молочными продуктами, частично может синтезироваться микрофлорой толстого кишечника.

Витамин В2 (рибофлавин) содержится в картофеле, овощах, молочных продуктах, мясе, печени, рыбе, гречневой и манной крупах, особенно много его в дрожжах. У человека он может синтезироваться микрофлорой кишечника. Этот витамин активно

участвует во всех процессах обмена веществ в организме ребенка, способствует его росту, наряду с витамином А улучшает состояние зрения. Недостаток витамина

В2 в организме приводит к нарушению нормальной функции нервной, сосудистой и пищеварительной систем.

Витамин В6, как и другие витамины этой группы, содержится во многих продуктах животного и растительного происхождения (мясе, рыбе, печени, крупах, хлебе грубого помола, молочных продуктах), может синтезироваться микрофлорой кишечника. Он участвует во многих процессах в организме, особенно велика его роль в регуляции обмена белков. Он существенно влияет на кроветворение и иммунитет, улучшает состояние печени и поджелудочной железы при их заболеваниях, восстанавливает нарушенные обменные процессы при рахите.

Витамин В12 поступает в организм с продуктами животного происхождения и синтезируется микроорганизмами, населяющими толстую кишку. Для всасывания витамина В12 необходим так называемый «внутренний фактор», выделяемый слизистой оболочкой желудка, — при его отсутствии всасывание витамина не происходит. Поэтому заболевания, нарушающие состояние слизистой оболочки желудка, например хронический гастрит, вызывают недостаток витамина В12 даже при достаточном поступлении его с пищей. Витамин В12 ускоряет рост и развитие ребенка, повышает иммунитет, улучшает состояние нервной системы и кожи, уменьшает проявления острой и хронической интоксикации.

Витамин РР (его называют также витамином В5 или никотиновой кислотой) в организме человека не синтезируется, он поступает с теми же продуктами, которые являются источником других витаминов группы В. Этот витамин хорошо сохраняется при сушке, консервировании и кулинарной обработке. Потребность в нем легко удовлетворяется обычным рационом питания.

Витамин РР участвует в регуляции углеводного и жирового обмена, нормализует обмен аминокислот и холестерина, снижает содержание сахара в крови. Отмечено его регулирующее действие на состояние нервной, сосудистой и пищеварительной систем. Это проявляется активирующим влиянием на функцию коры больших полушарий головного мозга (поддержание равновесия между процессами возбуждения и торможения), сосудорасширяющим действием, улучшением функции желудка, печени и поджелудочной железы.

Витамин Вс (фолиевая кислота, фолацин) необходим организму человека для оптимального протекания процессов кроветворения, для функционирования нервной системы, он участвует во многих процессах обмена. Этот витамин благотворно влияет на функции кишечника и печени. Поступает он в организм преимущественно с продуктами растительного происхождения, в некотором количестве содержится в продуктах животного происхождения и синтезируется в кишечнике человека. Недостаток фолиевой кислоты приводит к развитию специфической формы анемии, сопровождающейся появлением в кровяном русле незрелых крупных кровяных клеток, неспособных переносить кислород. Снижается также количество лейкоцитов и тромбоцитов, это проявляется кровотечениями из слизистых оболочек рта, носа, кишечника. Могут наблюдаться также понос, язвенное воспаление слизистой оболочки рта и миндалин.

Витамин А (ретинол) способствует росту детского организма, правильной функции желез внешней и внутренней секреции. Он обеспечивает нормальный рост и питание кожи, волос, слизистых оболочек, скелета, принимает участие в жировом обмене,

необходим палочковому аппарату сетчатки для осуществления ночного зрения. В палочковых клетках содержится чувствительное к свету вещество — зрительный пурпур, или родопан, представляющий собой соединение белка с ретинолом. Под влиянием света родопан разлагается. Восстановление его происходит в темноте. Этот процесс задерживается или прекращается, если в организме не хватает ретинола, в результате чего развивается заболевание гемералопия (куриная слепота). Недостаток ретинола сказывается и на дневном зрении, вызывая сужение зрачка и нарушение нормального цветоощущения. Роговица глаза подсыхает и мутнеет. Изменения в верхних слоях кожи, слизистых оболочках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, почек и других органов при недостатке ретинола приводят к значительному снижению сопротивляемости организма различным микробам.

Витамин D получил название антирахитического витамина, так как он играет очень важную роль в фосфорно-кальциевом обмене и препятствует возникновению рахита. Он содержится в продуктах животного происхождения: рыбе, рыбьем жире, икре, яичном желтке, в свежем молоке и сливочном масле, а также образуется в коже человека под влиянием ультрафиолетовых лучей. Витамин D нормализует всасывание из кишечника солей кальция и фосфора, оказывает регулирующее действие на их обмен в организме, способствует превращению органического фосфора тканей в неорганические его соединения и отложению фосфорнокислого кальция в костях, стимулирует их рост.

Витамин E (токоферол) улучшает использование тканями кислорода, препятствует образованию и накоплению в них свободных радикалов — соединений, обладающих повреждающим действием на клеточные структуры. Он принимает участие в обмене белка, нормализует мышечную деятельность, предотвращая развитие мышечного утомления.

Витамин K способствует нормальному свертыванию крови, участвует в обменных процессах, стимулирующих рост и развитие организма, в дыхании клеток. При заболеваниях желудочно-кишечного

тракта, печени, а также при длительном приеме некоторых лекарств количество витамина в организме резко снижается, что приводит к плохой свертываемости крови, ломкости сосудов, кровоизлияниям. Витамин K содержится в салате, капусте, шпинате, свиной печени, яйцах, молоке, синтезируется кишечной бактериальной флорой.

Группа витаминов F включают в себя линолевую, линоленовую и арахидоновую кислоты — полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), незаменимые для организма человека. Они играют важную роль в энергетическом обмене, в обмене жиров, входят в состав фосфолипидов, из которых состоят мембраны клеток. Очень важно их значение в синтезе веществ, участвующих в регуляторных процессах организма. Они оказывают также положительное влияние на пищеварение, способствуя образованию и выделению желчи.

Вода — важнейшая составная часть живого организма. Общее содержание ее у ребенка грудного возраста — 70-75%, а у взрослого — 60-65% массы тела.

Чем младше ребенок, тем с большей интенсивностью и напряженностью происходит его *водный обмен* и тем выше у него потребность в воде. Так, у новорожденного она составляет 150-200 мл/кг массы в сутки, у грудного ребенка — 100-150, в два года — 90-95, в пять лет — 60, в 13 лет — 40 мл/кг массы в сутки. Всасывание воды из желудочно-кишечного тракта в кровь происходит очень быстро, интенсивно идет обмен воды между кровью и тканями, так же быстро вода выделяется из организма. Из

общего количества принятой ребенком жидкости в организме задерживается только около 1%, остальная ее часть после участия в обменных процессах выводится из организма (около 60% выводится почками, до 34% — кожей и легкими, 6% — с испражнениями).

Потребность в воде у детей удовлетворяется за счет питья жидкости и частично за счет плотной пищи, также имеющей в своем составе воду. Потребность в дополнительном питье может быть различной и зависеть от индивидуальных особенностей обмена веществ, от вида вскармливания (дети, находящиеся на искусственном вскармливании, обычно нуждаются в большем количестве воды), а также от температуры и влажности помещения, в котором находится ребенок. Во всех случаях с первых дней жизни ребенку ежедневно следует давать несладкую кипяченую воду. Ориентировочное количество воды, предлагаемое ребенку первых месяцев жизни, составляет 30-50 мл, а при температуре воздуха выше 25°C — до 100 мл в сутки. Получившие в последние годы распространение различные травяные чаи и прочие напитки для детей грудного возраста не заменяют в рационе ребенка простую воду.

2. Вскармливание детей до 1 года: естественное вскармливание

Дети грудного возраста нуждаются в легкоусвояемой пище, обеспечивающей их высокую потребность в питательных веществах. Лучшей, наиболее физиологичной пищей для ребенка первого года жизни является материнское молоко. Оно является экологически чистым продуктом питания, содержит питательные вещества, ферменты, гормоны и другие биологически активные вещества, которые исключительно важны для роста и развития младенца. Грудное вскармливание способствует гармоничному росту и развитию, повышает сопротивляемость инфекциям и другим неблагоприятным влияниям внешней среды, способствует заселению кишечника новорожденного ребенка микроорганизмами, необходимыми для правильного пищеварения.

Состав грудного молока идеально подходит для вскармливания грудного ребенка. Женское молоко содержит больше альбуминов и меньше, чем коровье и козье, казеина. Белок грудного молока обеспечивает ребенка достаточным количеством незаменимых аминокислот. Жир женского молока больше чем на 50% состоит из полиненасыщенных жирных кислот, в нем мало летучих жирных кислот, много фосфатидов. Жир находится в мелкоэмульгированном состоянии и содержит фермент, способствующий его перевариванию. Из углеводов в женском молоке содержится преимущественно бета-лактоза, которая в кишечнике распадается на глюкозу и галактозу. Бета-лактоза угнетает рост кишечной палочки, способствует росту бифидобактерий и синтезу микробами кишечника витаминов группы В. Содержащаяся в коровьем молоке альфа-лактоза, наоборот, благоприятствует росту кишечной палочки. Состав минеральных веществ, макро- и микроэлементов в женском молоке лучше обеспечивает потребности ребенка, чем состав коровьего молока. В нем больше важных для кроветворения веществ: железа, меди, кобальта, марганца и др., оно богаче ферментами и витаминами групп В, А, С и др.

Первое прикладывание к груди здорового доношенного ребенка обычно практиковалось через 6-10 часов после рождения, однако в последние годы отмечается тенденция к раннему прикладыванию — сразу в родильном зале. Раннее прикладывание способствует установлению более тесного психологического контакта матери и ребенка, уменьшению родового стресса у новорожденного, стимулирует выделение молока.

Существуют разные способы расчета объема грудного молока, который должен получать ребенок: по возрасту, необходимым калориям и весу. При этом средний объем

разового кормления в зависимости от возраста ребенка должен составлять в 1-2 недели — 60-90 мл, 3 недели — 2 месяца — 120-150 мл, 2-3 месяца — 150-180 мл, 3-4 месяца — 180-200 мл и далее по 200-210 мл, а средний суточный объем — в 1 месяц — 600-650 мл, 2 месяца — 800 мл, 3 месяца — 850 мл, 4 месяца — 900 мл и 5-12 месяцев — 1000 мл. Существует также рекомендация ВОЗ по ориентировочной достаточности суточного количества молока: если ребенок мочится не менее 6 раз в сутки, то суточный объем питания ему достаточен.

По мере взросления ребенку рекомендуется вводить в питание соки, овощные и фруктовые отвары и прикормы овощами, кашами, мясными блюдами. Это необходимо для его правильного развития и предупреждения малокровия, рахита, отставания в физическом и психическом развитии. При естественном вскармливании с 3,5-4 месяцев следует вводить соки. Соки назначают между кормлениями вначале по 2-5 капель и постепенно увеличивают дневную дозу. Через две недели после введения соков в возрасте 4-4,5 месяца можно начинать давать ребенку пюре из яблок, абрикосов и других фруктов — с 1/3 – 1/2 чайной ложки с постепенным увеличением дозы до 20-50 г — так, чтобы к 1 году объем достиг 100 г.

Со временем грудное молоко перестает полностью удовлетворять потребности растущего ребенка. Кроме того, необходима тренировка развивающейся пищеварительной системы и жевательного аппарата. С этой целью с 4-4,5 месяца вводится прикорм.

Прикорм — это блюда, вводимые в рацион ребенка, постепенно вытесняющие женское молоко или смеси и приучающие его к взрослой пище.

Первый прикорм — овощное пюре, содержащее смесь различных овощей (картофель, капуста, морковь, кабачок, тыква, репа, патиссон, зеленый горошек, томаты и др.). Введение овощного прикорма следует начинать с одного вида овощей (картофель, вымоченный в течение 10-12 часов, капуста, кабачок и др.). Это позволяет в случае пищевой аллергии рано выявить продукт, который вызывает аллергическую реакцию, и исключить его из питания. Постепенно ассортимент овощей увеличивается. В овощной прикорм добавляется растительное масло, доза которого постепенно доводится до чайной ложки.

Второй прикорм вводится только после полной замены одного кормления овощным прикормом. Обычно это бывает при достижении ребенком возраста 5,5-6 месяцев (через 3-4 недели после введения овощного прикорма). В качестве 2-го прикорма используют безглютеновые злаки (рисовая, гречневая, кукурузная мука).

Вначале второй прикорм дается в виде 5%-ной каши на овощном отваре с добавлением растительного масла, а затем сливочного, спустя 1-2 недели переходят на кормление 10%-ной молочной кашей. Если ребенок

плохо набирает массу тела или у него часто бывает неустойчивый стул, рекомендуется сначала ввести кашу, а затем овощное пюре.

С шести-семи месяцев жизни можно давать желток куриного яйца, сваренного вкрутую, растертого с грудным молоком, начиная с 1/4 его части 2-3 раза в неделю. С семи-восьми месяцев в рацион ребенка рекомендуется вводить творог с 5-10 г перед основным кормлением. К году ежедневное количество творога достигает 50 г. Более раннее введение творога как дополнительного источника белка не рекомендуется, поскольку дети, находящиеся на естественном вскармливании, получают необходимое количество белка с женским молоком.

Мясо в виде мясного пюре вводится с 7 месяцев. В дальнейшем оно заменяется фрикадельками (8-9 месяцев) и паровыми котлетками (11-12 месяцев).

Третий прикорм — в 7,5-8 месяцев еще одно кормление полностью заменяется кефиром или другим кисломолочным продуктом, в это же кормление можно давать ребенку творог.

Вместо кефира могут использоваться специальные молочные смеси с оптимальным набором жирных кислот, минеральных веществ и витаминов, носящих название «последующих формул». С 8-9 месяцев вместо мясного блюда 1-2 раза в неделю дается рыбное пюре. Мясные и рыбные блюда рекомендуется сочетать с овощным пюре и свежей зеленью. Можно давать хлеб, печенье, белые сухарики, которые предварительно размачиваются в одном из видов прикорма. С 10-12 месяцев в питание вводится тертый сыр.

3. Искусственное и смешанное вскармливание

Искусственное вскармливание вводится в тех случаях, когда у матери полностью отсутствует молоко или состояние ее здоровья не позволяет кормить ребенка грудью. Однако, учитывая, что в первые 3 месяца особенно важно естественное вскармливание, в таких случаях до введения искусственного необходимо попытаться обеспечить ребенка донорским женским молоком. При искусственном вскармливании ребенок полностью переводится на питание молочными смесями, производимыми на основе коровьего молока. Лучше заменять грудное молоко смесями из коровьего молока постепенно.

Смешанным принято называть такое вскармливание, когда в первые шесть месяцев жизни ребенка его рацион состоит как из грудного молока, так и из молочных смесей. Причиной может быть развивающаяся гипогалактия (недостаточная продукция молока) у матери. Задача врача в таких случаях выяснить степень выраженности гипогалактии и предпринять меры, способствующие увеличению количества грудного молока. В каждом случае необходимо учитывать, сколько грудного молока

ребенок получает от матери. Для этого ребенка в течение 1-2 суток взвешивают до и после каждого кормления. Недостающее количество грудного молока восполняют смесями. Докорм надо давать лишь в строго необходимом количестве и с таким расчетом, чтобы объем и калорийность пищи соответствовали потребностям ребенка.

При переходе на смешанное вскармливание важно стремиться к тому, чтобы грудное молоко все-таки оставалось основным в питании ребенка. Введение докорма само по себе может способствовать уменьшению количества грудного молока, поэтому докорм необходимо давать после прикладывания к груди. После того как ребенок привыкнет к смесям, их можно давать как самостоятельное кормление, чередуя с кормлениями грудью. Режим питания при смешанном вскармливании остается таким же, как и при грудном. При искусственном вскармливании рекомендуется более ранний переход на пятиразовое кормление с длительными промежутками между отдельными кормлениями, так как чужеродная пища дольше задерживается в желудке. Объем пищи, как и при естественном вскармливании, зависит от возраста и веса ребенка.

4. Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет

Интенсивный рост организма продолжается на втором и третьем годах жизни, когда увеличивается подвижность ребенка и возрастают его энергетические затраты. Функциональная способность желудочно-кишечного тракта повышается. Ребенок начинает разжевывать пищу, дифференцированно относиться к ее качеству, приучается самостоятельно есть и т. д. Организуя питание детей старше года, надо учитывать их фи-

физиологические особенности: развитие жевательного аппарата, нарастание ферментативной активности пищеварительных соков, развитие вкусового восприятия.

Когда вскармливание ребенка организовано правильно, к году он привыкает к разнообразной пище, его можно переводить на общий стол. На втором году жизни, когда у ребенка уже достаточное количество зубов, его меню становится разнообразнее, жидкая и полужидкая пища заменяется более твердой. Теперь можно давать не только каши, но и запеканки, котлеты, оладьи, овощи вареные или тушеные, нарезанные кусочками. Мясное и рыбное пюре заменяют фрикадельками, котлетами, а после двух лет дают мясо в виде кусочков (рагу, гуляш, бефстроганов).

Основные ингредиенты пищи в этот период должны поступать в организм в соотношении 1:1:4 и составлять: белок — 4 г, жир — 4 г, углеводы — 15-16 г на 1 кг массы тела. Для полноценного питания важно, чтобы 75% белков были животного происхождения. В рацион ребенка должны включаться продукты, содержащие наиболее полноценные жиры:

сливки, масло, желтки, рыбий жир, 10-20% из них составляют растительные масла.

Потребность в углеводах покрывается за счет сахара, хлеба, овощей, картофеля, каш. С овощами и фруктами ребенок получает необходимые минеральные соли, а также витамины С, А, группы В.

В период от одного года до трех лет активно продолжается формирование скелета, увеличивается мышечная масса, сохраняется высокая потребность в минеральных веществах. Повышается суммарная потребность в витаминах.

До полутора лет ребенка целесообразно кормить 5, а начиная с конца второго года — 4 раза в сутки. Молоко остается важным пищевым продуктом, необходимый объем его — 600-650 мл в сутки. Часть его желательно заменять кефиром, который легче усваивается и нормализует микробный состав кишечника ребенка. Однако необходимо учитывать возможность быстрого перекисления кефира, особенно в летнее время, и накопление в нем алкоголя. С полутора лет ребенку рекомендуется давать супы, запеканки, овощные винегреты, оладьи. Очень ценен творог, поскольку он содержит полноценные белки и большое количество кальция, калия и фосфора. Солями кальция и фосфора богат также сыр. Можно использовать нежирные сливки для заправки овощных пюре, каш, в супы и салаты добавляют сметану.

Из мясных продуктов рекомендуется маложирная говядина, телятина, кури, индейка, крольчатина, не следует готовить блюда из жирной говядины, свинины, баранины, мяса гусей и уток. Периодически мясо можно заменять нежирными сортами тщательно очищенной от костей рыбы, лучше всего трески, хека, судака. Ежедневно к первым и вторым блюдам ребенку дается хлеб. Из круп рекомендуются овсяная, гречневая, рисовая, пшеничная, кукурузная, пшенная и их смеси.

В детском питании широко используют овощи, фрукты и ягоды, следует включать в рацион питания детей также огородную и дикорастущую зелень (лук, укроп, шпинат, салат, щавель, крапиву, ревень и т. п.). Сильно раздражающие продукты: горчицу, хрен, перец — употреблять в пищу детей до трех лет не следует.

5. Питание детей дошкольного возраста

Питание дошкольников отличается от питания детей раннего возраста как в количественном, так и в качественном отношении.

Масса тела ребенка с 4 до 7 лет нарастает в среднем с 15 до 25 кг, а прирост тела в длину составляет 20-30 см. Общая подвижность детей несколько уменьшается, но

увеличиваются физические нагрузки: пешие переходы, физкультурные и спортивные занятия и игры.

В периоды вытягивания и нарастания массы тела особенно важно обеспечить детей полноценной пищей. Недостаток в рационе важных питательных веществ сказывается на величине массы тела, размерах и функции отдельных органов, функциональном состоянии желез внутренней секреции, увеличение тела в длину (рост) обычно страдает меньше. Недостаток пищевых веществ и значительные физические и умственные нагрузки могут приводить к заболеванию детей. Поэтому одним из важнейших в дошкольном возрасте остается принцип сбалансированного питания.

Для растущего организма необходим полноценный белок, поэтому количество животных белков должно составлять у трехлетнего ребенка 70%, у пятилетнего — 60% от общего их числа. При правильном соотношении животных и растительных белков их усвоение происходит более полноценно. Белок в пище детей дошкольного возраста в среднем должен обеспечивать 15% ее общей калорийной ценности.

Количество жиров, необходимое после трех лет, практически такое же, как и белков (соотношение 1:1). В диете детей дошкольного и школьного возраста жиры должны быть не только животного, но и растительного происхождения, количество последних составляет 5-10% , а иногда и 25% от всех жиров. Необходимость употребления жиров растительного происхождения связана с большим содержанием в них незаменимых ненасыщенных жирных кислот. Следует учитывать, что липидный состав различных растительных масел неоднороден, поэтому полезно чередовать их (подсолнечное, кукурузное, хлопковое, оливковое).

Соотношение между белками, жирами и углеводами должно составлять 1:1:4. Излишек углеводов в питании ребенка дошкольного возраста в первую очередь угнетает аппетит к другим продуктам питания, увеличивает брожение в кишечнике, вызывает вздутие его, что способствует всасыванию недостаточно расщепленных веществ и аллергизации организма. Иногда после обильного употребления сладкого у ребенка незамедлительно появляются значительные высыпания на коже, исчезающие через несколько часов или суток.

Растущий организм ребенка остро нуждается в достаточном количестве минеральных веществ. Так, для него весьма чувствителен недостаток железа, основная роль которого — участие в образовании гемоглобина. Дефицит железа приводит к малокровию с задержкой роста, снижению сопротивляемости ребенка инфекциям, ухудшению всасывания различных компонентов пищи.

Обычное питание детей дошкольного возраста содержит достаточное количество солей кальция, фосфора, калия, магния. Однако дефицит их может возникнуть из-за нарушения переваривания и всасывания, в частности, такого важного продукта питания, как молоко.

Часть здоровых детей не любит молока в его натуральном виде. Исследования показали, что до 10% здоровых детей плохо переносят молоко. Настойчивое внедрение его в пищу может привести к заболеваниям, протекающим под маской различных аллергий, хронических расстройств пищеварения и т. д. Большая часть этих детей может употреблять кисломолочные продукты и творог, которыми можно заменить в рационе молоко. Если дети не переносят молочного белка ни в каком виде, то они нуждаются в консультации врача и составлении специальной диеты.

Рыба содержит до 19% высококачественного белка, она легче переваривается и усваивается, чем мясо. Наиболее подходящими видами рыбы в питании ребенка являются треска, хек, судак, морской окунь. Речная рыба (за исключением судака) более жирная, дети хуже переносят ее, к тому же она содержит много мелких костей.

Яйца содержат полноценный белок, в желтках содержатся очень ценные жироподобные вещества. В питание детей их можно включать почти ежедневно. Однако иногда потребление яиц вызывает аллергические реакции, возбуждение центральной нервной системы, запоры.

Овощи, фрукты, зелень, ягоды содержат большое количество минеральных солей, витаминов, и, кроме того, в них имеются пектиновые вещества, фитонциды и дубильные вещества, улучшающие функционирование пищеварительного тракта. Соки лучше употреблять неосветленными, с мякотью. В овощах и фруктах содержится тартроновая кислота (много в огурцах), тормозящая переход углеводов в жиры, что особенно важно учитывать при питании детей с избыточной массой.

Лекция 3: Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей

План

- 1. Гигиеническое воспитание детей.**
- 2. Работа с родителями.**
- 3. Психическое здоровье – база полноценного развития.**
- 4. Понятие о психокоррекции и психотерапии.**

1. Гигиеническое воспитание детей

Гигиенические навыки у детей воспитываются с самых ранних лет. Поддержание чистоты кожи и волос, гигиена полости рта, привычка к проведению утренней зарядки, соблюдение чистоты и аккуратности в одежде, порядка в комнате, на рабочем месте, в шкафах с книгами, игрушками — основные гигиенические навыки, которые должны быть сформированы в процессе воспитания ребенка. В дальнейшем они превращаются у детей в устойчивую привычку мыть руки и ноги и чистить зубы, аккуратно одеваться, убирать за собой игрушки и т. д. Создание такой «гигиенической детерминанты» в сознании ребенка, глубоко укоренившейся в психике и воспринимаемой как насущная необходимость, является лучшей защитой его от многих заболеваний.

Гигиенические навыки формируются медицинскими работниками, воспитателями, техническим персоналом детского учреждения и, конечно, родителями. Врач, входя в состав педагогического совета дошкольного учреждения, должен постоянно информировать его членов о новой литературе по данному вопросу, методических и наглядных материалах и др. Вместе со старшим воспитателем в детском саду врач организует методический уголок, в котором сосредоточиваются: а) конспекты занятий, уроков на гигиенические темы; б) наглядный и учебный материалы; в) картотека методической литературы; г) перечень гигиенических вопросов в различных разделах программы воспитания; д) наглядные пособия для детей, подобранные по теме охраны здоровья.

Содержание работы по гигиеническому обучению и воспитанию детей ясельного и дошкольного возраста определено следующими разделами Программы воспитания детей в детском саду: «Организация жизни группы и воспитание детей», «Воспитание навыков личной гигиены», «Игры», «Занятия», «Труд», «Физическая культура». Программа предусматривает сообщение по каждой возрастной ступени определенных гигиенических сведений и привитие гигиенических навыков, специализированную помощь в этом воспитателям оказывает врач.

В практической работе по привитию гигиенических навыков необходимо учитывать, что гигиеническая процедура — это целая серия взаимосвязанных действий, каждое из которых требует обучения. Указание «вымой руки» ребенку выполнить совсем не просто. Правильная процедура мытья рук в действительности состоит из 15 действий, а именно:

- 1) закатать рукава;
- 2) открыть кран;
- 3) смочить руки;
- 4) взять мыло;
- 5) смочить мыло и руки;
- 6) помыть руки;
- 7) положить мыло;
- 8) движениями кистей рук размыливать мыло на тыльной и ладонной поверхности, между пальцами, в области запястья;
- 9) смыть мыло;
- 10) взять мыло и, опять намылив руки, положить его, выполнить движения кистями, указанные в пункте 8;
- 11) тщательно смыть пену;
- 12) стряхнуть воду;
- 13) взять полотенце и тщательно вытереть руки со всех сторон;
- 14) повесить полотенце на место;
- 15) опустить рукава.

Если ребенка не учили этим действиям или он не освоил их полностью, не запомнил последовательности, то команда «вымой руки» понимается и выполняется по-разному. Без специального обучения ребенок может выполнить 2-3 действия, но не 15. Следовательно, в основе гигиенического обучения и воспитания должны лежать детальный показ и постепенное наращивание одного усвоенного звена на другое, исправление ошибок, закрепление усвоенного действия.

Детей надо обучать правильным приемам намыливания рук и смывания мыла водой, умывания лица, чистки зубов, полоскания рта и др., в доступной им форме разъяснять значение того или иного гигиенического правила и важности его соблюдения. Гигиеническое воспитание детей можно успешно осуществлять лишь при условии сознательного отношения к нему воспитателей и активной помощи родителей и технического персонала, работающего в дошкольном учреждении.

В процессе гигиенического обучения детям сообщаются определенные знания, формируются навыки гигиенического поведения. ***Гигиеническое обучение следует планировать, готовить и проводить так же тщательно и систематически, как занятия по счету, лепке, письму и др.*** Навыки личной гигиены формируются в раннем возрасте. Методика их воспитания со временем меняется. У детей до полутора лет в

основе ее лежит подражание, младшего возраста (1,5-3 года) — совместные действия, среднего (4-5 лет) — доступное данному возрасту обоснование требований, осознание навыков, контроль, старшего дошкольного (6-7 лет) — объяснение на более высоком уровне, осознание навыков, контроль и самоконтроль за действиями. При объяснениях (обоснованиях) излагается только необходимый для формирования нужного гигиенического навыка материал, тесно связанный с жизнью ребенка данного возраста. Наглядность сочетается со словесным воздействием: воспитатель показывает, рассказывает, поясняет, читает; ребенок смотрит, слушает, отвечает, пересказывает, объясняет.

Чтобы ребенок хорошо овладел гигиеническими навыками, необходимо наличие индивидуальных предметов туалета (мыло, зубная щетка, расческа, мочалка, кружка для полоскания рта) в определенном, доступном для ребенка месте, стеллажей и шкафов для хранения книг и игрушек такой высоты, чтобы ребенок без затруднений сам мог взять и положить на место нужные ему предметы; оснащение передней или вестибюля необходимыми приспособлениями для вытирания ног (мат, тряпка) и щетками для чистки обуви и одежды.

2. Работа с родителями

Задачу по сохранению и укреплению здоровья детей нельзя решить, не привлекая усилия семьи, которая играет решающую роль в формировании личности ребенка. В вопросах

санитарного просвещения и гигиенического воспитания большую роль играют средства массовой пропаганды: радио, телевидение, статьи в газетах и журналах, научно-популярные издания, санитарно-просветительные брошюры и памятки. Тем не менее необходимо учитывать, что широкое распространение средств массовой информации способствует повышению санитарно-гигиенических знаний населения, но, к сожалению, не всегда меняет поведение людей. Поэтому задача санитарного просвещения — не только давать теоретические знания, но и учить практическому овладению гигиеническими навыками. Особенно это важно в работе с детьми раннего и дошкольного возраста, так как для сохранения их здоровья громадное значение имеют условия, в которых они живут и воспитываются.

При поступлении ребенка в дошкольное учреждение проводится инструктаж родителей врачом или медицинской сестрой в присутствии воспитателя группы, в которую зачисляется ребенок. На инструктаже родителей знакомят с правилами ухода за ребенком, мерами предупреждения у него инфекционных заболеваний, гигиеническими основами детского питания, закаливания, указывают на необходимость соблюдения и дома режима дня, установленного в дошкольном учреждении, закрепления в семье гигиенических навыков, прививаемых ребенку в яслях или саду. Для родителей проводят лекции, беседы, выпускают санитарные стенные газеты или бюллетени, вешают доски вопросов и ответов и т. д.

Исключительно важны и наиболее действенны ***индивидуальные санитарно-просветительные беседы:*** во-первых, потому что они ведутся с учетом особенностей ребенка, его родителей и окружающей обстановки; во-вторых, сказанное относится конкретно к данному ребенку, и родители стараются выполнять данные рекомендации. Практика показывает, что медиков и педагогов, не жалеющих времени для бесед с родителями об уходе, питании, закаливании и воспитании здорового ребенка, родители глубоко уважают и ценят.

Эффективность санитарного просвещения повышается при использовании **наглядных пособий**, а также **обеспечении родителей специально подобранной литературой**, касающейся вопросов ухода, режима дня, питания, динамики физического и нервно-психического развития детей того возрастного периода, к которому относится конкретный ребенок.

Существенную помощь в гигиеническом воспитании родителей оказывают **санитарные бюллетени**, представляющие собой наглядную форму санитарно-просветительной работы, позволяющую осветить любые актуальные вопросы охраны детского здоровья. Санитарные бюллетени выпускаются силами сотрудников детского учреждения и

вывешиваются в местах пребывания родителей (холлах, коридорах, около медицинской комнаты и кабинета заведующей). Особая ценность санбюллетеней состоит в том, что они отражают насущные вопросы конкретного учреждения и приводят в качестве примеров местный материал. Выдумка, фантазия, доступный язык, яркое оформление — основные требования к этой форме работы.

3. Психическое здоровье – база полноценного развития

Нервно-психическое развитие детей оценивается по принятым в нашей стране показателям развития, которые отражают оптимальные последовательность и возрастные сроки формирования умения, а также уровень развития, который должен быть достигнут на каждом возрастном этапе. *Нервно-психическое развитие оценивается в обстановке, близкой к естественной, с помощью игрушек, пособий, вопросов взрослого, опроса родителей и/или воспитателей.* Родители и воспитатели, наблюдая за поведением ребенка, оказывают важную помощь в выявлении его эмоционального состояния, характера и длительности засыпания и сна, аппетита, характера бодрствования, взаимоотношений с детьми и взрослыми, возбудимости нервной системы, утомляемости, наличия патологических привычек.

Если развитие ребенка не соответствует возрасту (ниже или выше), то его проверяют по показателям предыдущего или более старшего возрастного периода.

На первом году жизни за нормальное развитие принимают формирование умений в пределах ± 15 дней от должного срока. Умения, формирующиеся до верхней границы нормы, т. е. раньше на 16 дней и более, свидетельствуют об ускоренном или раннем развитии. Овладение умениями по одному или нескольким показателям с задержкой до одного месяца свидетельствует о замедлении темпа развития, что может быть вызвано индивидуальным ходом развития, заболеванием в период формирования умения, педагогической запущенностью. Выяснив причину отставания ребенка, необходимо применить соответствующие воспитательные и обучающие воздействия. Формирование детей с задержкой от одного до двух месяцев классифицируется как отставание, а более чем на два месяца — как значительное, серьезное отставание, требующее консультации специалистов.

На втором году жизни за нормальное развитие принимают формирование умений в пределах квартала. Раннее развитие — овладение умениями с опережением на один квартал и больше. Овладение умениями

по одному или нескольким показателям на один квартал позже установленных сроков свидетельствует о замедлении темпов развития, на два квартала — отставание в развитии, на три квартала и больше — значительное, глубокое отставание.

На третьем году жизни за нормальное развитие принимают формирование умений в пределах одного полугодия. Раннее развитие — овладение умениями с опережением на полугодие и больше, позднее развитие — овладение умениями после срока, принятого за норму; позже на полугодие — отставание в развитии, позже на год (два полугодия) и более — значительное, или глубокое, отставание. У детей дошкольного возраста допускаются колебания в пределах года.

Дети с отклонениями в нервно-психическом, развитии (отставание в развитии, значительное или глубокое отставание) и нарушениями поведения должны быть обследованы в психолого-медикопедагогической консультации. На основании результатов обследования определяют задачи по коррекции развития. Начинают их с задач, направленных на устранение выявленного отставания (именно с того, что требует наибольшего внимания), а затем указываются задачи воспитания и обучения на следующий возрастной период. Психолого-педагогические воздействия должны быть строго согласованы с лечебными.

Развивающаяся нервная система ребенка функционирует очень интенсивно. В то же время способность ее находиться в деятельном состоянии весьма невысока. Кроме того, в связи со склонностью к иррадиации нервные процессы у детей осуществляются более энергозатратным способом, чем у взрослых. Следствием является быстрое **утомление**. Причинами его наступления часто бывают чрезмерно длительное бодрствование, недостаточный сон и наличие неблагоприятных физических факторов в среде, где живет ребенок (нарушение воздушного, температурного режима в помещении, плохое освещение, шум), а также непосильная умственная и физическая нагрузка.

Накапливающееся утомление, отсутствие своевременного отдыха приводят к формированию хронической усталости, или **переутомления**. Принципиальное различие между физиологическим утомлением и переутомлением заключается в том, что при утомлении работоспособность клеток мозга после отдыха восстанавливается до исходного уровня, а при переутомлении этого восстановления не происходит; утомление накладывается на утомление, приводя к серьезным сдвигам в общем состоянии организма. Переутомление является состоянием, пограничным между здоровьем и болезнью, оно становится благоприятным фоном для развития болезненных отклонений и в физической, и в психической сфере. При переутомлении наступают выраженные физиологические сдвиги в функциональном

состоянии головного мозга, задерживается его созревание, усиливается эмоциональная неустойчивость, раздражительность и непродуктивная возбужденность, возникают головные боли.

Для **нормального развития нервной системы** детей и предупреждения переутомления огромное значение имеет **правильная организация режима жизни** детей.

Правильный режим — это рациональное и четкое чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим должен предусматривать достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сон, прогулки, занятия и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования предохранять его организм от чрезмерного утомления. Соблюдение режима дня приводит к возникновению у детей прочных условных связей, облегчающих переход от одной деятельности к другой. Организм ребенка в каждый отдельный отрезок времени как бы подготавливается к тому виду деятельности, который ему предстоит выполнить, и все процессы (усвоение пищи, пробуждение, засыпание и пр.)

протекают быстрее и с меньшими затратами энергии. Правильный режим дисциплинирует детей, улучшает их аппетит, сон, работоспособность, способствует нормальному физическому развитию и укреплению здоровья.

Важным фактором полноценного и своевременного развития нервной системы является **рациональное питание**, включающее все необходимые ей питательные вещества (белки, витамины, фосфолипиды, достаточное количество глюкозы — основного «энергоносителя» для нервных клеток).



Всего несколько десятилетий назад представления об оптимальных условиях для полноценного развития ребенка ограничивались его физиологическими потребностями. В последние годы накопилось много данных о важности для психического развития ребенка прежде всего «человеческого» фактора: контактов с близкими, значимыми взрослыми, понимания и принятия его индивидуальности со своими специфическими особенностями и потребностями. Без учета этого фактора нельзя говорить об условиях полноценного нервно-психического развития, о становлении ребенка как личности.

4. Понятие о психокоррекции и психотерапии

Психотерапия и психокоррекция. Как правило, в происхождении нервно-психических расстройств у детей играют роль разные факторы: и неблагоприятное состояние нервной системы, и нарушение адаптации к условиям, в которых находится ребенок, и несформированные навыки общения со сверстниками, и конфликтные отношения в семье. Поэтому лечение отклонений в нервно-психическом здоровье у детей требует комплексного подхода. Во всех случаях необходима консультация специалиста — детского психиатра или психоневролога для выявления причин и особенностей нарушений, решения вопроса о необходимости применения лекарственных средств. Очень важна работа с родителями: не всегда адекватно оценивая состояние ребенка, они могут считать, что «все само пройдет», и отказываться от лечения. Задача педагога, имеющего более обширный опыт работы с детьми, доброжелательно и доступно, не пугая родителей, объяснить им необходимость своевременной и полноценной помощи ребенку, важность коррекции отклонений в здоровье для его дальнейшей судьбы.

От педагога в значительной степени зависит и атмосфера, окружающая ребенка в детском коллективе. Необходимо создать обстановку, предохраняющую его от

усугубления болезненных расстройств: спокойное, доброжелательное отношение, понимание и поддержка взрослых, оптимистичный настрой на выздоровление. Важно объяснить детям, окружающим больного ребенка, правильное к нему отношение, исключить насмешки и отторжение, убедить по возможности, что он нуждается в их внимании и поддержке.

Часто значительного улучшения можно добиться изменением неправильного отношения к ребенку, устранением травмирующих его факторов. Лекарственные средства, назначенные врачом, могут уменьшить тревогу у ребенка, улучшить сон, повысить устойчивость к психическим нагрузкам. Однако во всех случаях — и при применении лекарственных препаратов, и без них — ведущая роль в преодолении отклонений в нервно-психическом здоровье у детей принадлежит психотерапевтическим и психокоррекционным методам воздействия.

Психотерапией называется лечебное воздействие на психику ребенка нелекарственными методами. Детская психотерапия сравнительно молода и в настоящее время интенсивно развивается. Она имеет ряд существенных особенностей. Во-первых, в формировании личности ребенка и в создании среды, влияющей на него, огромная роль принадлежит родителям. Нередко родителям же принадлежит

ведущая роль в возникновении у ребенка тех или иных расстройств. Поэтому лечение начинается с работы с родителями: выяснения особенностей их личности, отношения к ребенку, воспитательной тактики и общей психологической атмосферы в семье, а также с воздействия на неблагоприятные для ребенка аспекты семейной жизни.

Во-вторых, в связи с преобладанием чувственных переживаний и повышенной внушаемостью основным способом психотерапевтического воздействия в детском возрасте считается опосредованное внушение через специально ориентированные игры, истории, театрализованные представления с вовлечением в них ребенка.

В-третьих, важную роль играет отвлечение ребенка от болезненных проявлений посредством вовлечения в игры, труд, культурно-массовые мероприятия, участие в которых позволяет постепенно преодолеть имеющиеся проблемы.

Самым распространенным методом психотерапевтической работы непосредственно с ребенком является игра. Игры могут быть театрализованными, спонтанными, кукольными, сюжеты игр помогают участвующим в них детям «выплеснуть» накопившиеся у них переживания, найти способы решения трудных проблем, обучают правильному поведению в психотравмирующих ситуациях и преодолению болезненных проявлений. Широко используются также рисование (особенно эффективно для преодоления детских страхов и скрытых проблем), сочинение различных сказок и историй, отражающих трудности ребенка и показывающих пути их преодоления.

Осуществляет психотерапевтическое лечение врач-психотерапевт или специально подготовленный психолог. Однако нельзя забывать, что, помимо специальных сеансов лечения, мощное психотерапевтическое воздействие на ребенка могут оказывать окружающие его люди, прежде всего родители и педагоги. Внимательное отношение к ребенку, понимание его переживаний помогает в преодолении болезненных расстройств, а неформальное, терапевтически ориентированное общение с ним может дать хороший лечебный эффект.

Помимо психотерапии, в работе с детьми широко используются методы **психологической коррекции**. Направлены они на улучшение отдельных

психических функций (развитие познавательных интересов, общеинтеллектуальных умений, концентрации внимания, увеличение объема памяти и др.), а также на совершенствование умения общаться со сверстниками, работать в коллективе, на повышение самооценки, ориентацию на успех. Эти методы, в отличие от психотерапевтических, являются скорее педагогическими, чем лечебными. Психокоррекционной работой занимаются, как правило, психологи, однако роль педагогов,

ежедневно проводящих с ребенком занятия, в этой работе переоценить невозможно — ведь именно от них зависит закрепление освоенных умений, поддержание ощущения успеха и стремления к дальнейшим достижениям.

Профилактика нервных расстройств у детей является важной задачей педагогов, работающих в дошкольных учреждениях. Организация правильного ухода, соблюдение рационального режима сна, питания, отдыха способствуют повышению адаптационных возможностей ребенка и служат лучшим предупреждением нервно-психических нарушений. Большую роль играют мероприятия, направленные на укрепление детского здоровья в целом: физическое воспитание и закаливание, своевременное выявление и лечение болезней.

Необходимо избегать ситуаций, травмирующих неокрепшую детскую психику. Родители и воспитатели должны разговаривать с ребенком спокойным тоном, без раздражения, не применять унижающих его телесных наказаний. Нельзя забывать, что травмы бывают не только физические, но и душевные — от грубого слова, несправедливого отношения. И напротив, спокойное, заинтересованное, доброжелательное отношение создает у ребенка чувство надежности, защищенности, формирует у него положительную самооценку, способствует гармоничному развитию личности.

Лекция 4: Гигиена окружающей среды

План

- 1. Гигиенические требования к оборудованию.**
- 2. Гигиенические требования к игрушкам и дидактическому материалу.**
- 3. Гигиенические требования к освещению.**
- 4. Гигиенические требования к составу воздуха.**
- 5. Санитарное содержание помещений и участка**

1. Гигиенические требования к оборудованию

К оборудованию детских дошкольных учреждений относят предметы, связанные с бытом детей и педагогическим процессом в учреждении: мебель, игрушки, строительный материал, дидактические пособия, а также инвентарь для работы на участке, уборки помещений. Оборудование должно соответствовать росту детей, способствовать их развитию и здоровью, не вызывать излишнего напряжения и тем более травм, оно должно быть безопасным в эпидемиологическом отношении, не загромождать помещений, не мешать свободному передвижению детей.

Оборудование игровых-столовых и групповых комнат

В игровых и групповых помещениях должны быть установлены столы и стулья по числу детей в группах:

- во второй группе раннего возраста и первой младшей группе, во второй младшей и средней группах — столы четырехместные и (дополнительно) столы двухместные трапециевидной формы;
- в старшей и подготовительной группах — столы двухместные с изменяющимся наклоном крышки.

Стулья составляют со столом комплект, т. е. относятся к одной группе и имеют одну маркировку.

Во время занятий в групповой комнате надо правильно расставить мебель. Столы и стулья должны стоять на таком расстоянии друг от друга, чтобы воспитатель во время занятий мог свободно подойти к каждому, а каждый ребенок имел бы возможность, отодвинув стул в сторону, выйти из-за стола, не мешая соседу.

Детей сажают за соответствующие их росту столы так, чтобы самые маленькие и с пониженным слухом находились ближе к воспитателю, с дефектами зрения — ближе к источнику света и доске. Нельзя сажать детей спиной к свету. Сидящих во время занятий напротив или справа от источников света время от времени следует пересаживать на места тех, которые сидят по отношению к свету правильно.

Кроме столов и стульев, в этих помещениях имеются шкафы и полки для белья, игрушек, дидактического и строительного материала, доска для занятий изобразительной деятельностью, буфет для посуды.

Оборудование туалетных комнат

В туалетных средних и старших ясельных групп имеются два детских умывальника и один взрослый, один детский унитаз (все унитазы обязательно должны иметь сиденья — гигиенические накладки), слив, душевой поддон, полотенцесушитель; в туалетной младшей ясельной группы — один умывальник взрослый, слив, ванна, полотенцесушитель, в приемной и игровой устанавливается взрослый умывальник с локтевым смесителем.

В туалетных дошкольных групп должно быть четыре детских умывальника, три детских унитаза в открытых кабинках с перегородками-экранами, душевой поддон с душевой сеткой на гибком шланге, один полотенцесушитель. Душевой поддон используют для мытья ног, оборудуют его нижним кронштейном для душевой сетки. Дополнительно для мытья ног предусматривается лоток длиной 1,2 м с перфорированной трубой по длине лотка. Высота борта унитаза над полом равняется длине голени ребенка со стопой, а ширина (поперечный размер) соответствует расстоянию между большими вертелами. Около унитаза устанавливают деревянные подножки соответствующей высоты, которые легко отодвигаются при уборке и просушке. Здесь обязательно наличие ящиков с туалетной бумагой и шкафов для хранения инвентаря, предназначенного для уборки помещений. В старших и подготовительных к школе группах туалетные комнаты раздельные для мальчиков и девочек. В группах, где дети умываются самостоятельно, кран умывальника располагается на высоте уровня локтя согнутой руки ребенка, тогда при умывании вода не затекает за рукава.

В умывальной должны быть вешалки с изолированными гнездами для хранения индивидуальных предметов личной гигиены ребенка: полотенца, мыла, стаканчика с зубной щеткой, коробки с зубным порошком.

Оборудование приемной и раздевальной комнат

В приемной младшей ясельной группы должны быть пеленальный стол для детей (с дополнительным искусственным освещением), стол для размещения термометров,

шпателей и предметов, необходимых при кормлении грудью (раствор борной кислоты, пинцеты, ватные тампоны и др.), умывальник, шкаф или вешалка для чистых халатов.

В приемной младшей и средней групп раннего возраста также стоят пеленальные столы, шкафы для верхней одежды детей, столы и шкафы для персонала.

Основным оборудованием раздевальни является мебель для хранения верхней одежды: индивидуальные шкафчики высотой 120-135 см. В шкафчике, помимо места для пальто, вверху делается одна ячейка для шапок и шарфов, внизу — две ячейки: одна для галош, другая для чистых тапочек или ботинок. Для одежды персонала и родителей имеется отдельная вешалка на 10-15 крючков.

В раздевальне должны быть низкие диванчики или скамейки-приступки высотой 18-20 см, зеркало с подзеркальной тумбочкой, в которой могут храниться щетки для чистки одежды и обуви. Чтобы дети могли видеть себя в зеркале во весь рост и следить за тем, аккуратно ли они одеты, его следует подвешивать на расстоянии от пола не более чем на 25-30 см.

2. Гигиенические требования к игрушкам и дидактическому материалу

Игрушка — важное средство ознакомления ребенка с внешним миром, поэтому необходимо, чтобы она радовала малыша и вызывала у него интерес, а значит, была хорошо выполнена технически и оформлена эстетически. Сюжет игрушки должен расширять кругозор ребенка, способствовать выработке ясного представления о природе и животных, о труде и быте человека.

С точки зрения гигиены воспитания далеко не безразлично, какой ассортимент игрушек предоставляется ребенку. При известных условиях она может причинить вред здоровью: привести к повреждению кожных покровов и заражению раневой поверхности, способствовать передаче инфекционных заболеваний или отравлению токсическими материалами, если они использовались при ее изготовлении.

Для изготовления **деревянных дидактических пособий, игрушек и строительного материала** требуется сухое дерево твердых пород (дуб,

ольха, береза), так как мягкие породы (сосна, ель), а также сырое дерево твердых пород легко расщепляются и откалывающиеся от них мелкие обломки могут поранить ребенка. Чтобы предохранить детей от заноз и других повреждений, промежутки и швы между отдельными деталями игрушек тщательно заделывают, поверхность их зачищают и окрашивают стойкими нетоксичными красками. Игрушки, окрашенные клеевой или масляной краской, обычно покрывают двумя-тремя слоями прозрачного лака или натуральной олифы для образования на них прочной пленки.

Для детей первого года жизни наиболее гигиеничными являются игрушки, изготовленные **из пластмассы и резины**. На них почти не задерживаются микробы, они хорошо поддаются очистке и дезинфекции, имеют (особенно пластмассовые) устойчивую окраску. Составные игрушки (пирамиды, набор колец или формочек) должны иметь самый маленький элемент не менее 30 мм в диаметре, чтобы дети не могли их проглотить, засунуть в нос или уши.

Бумага и картон удобный и дешевый материал для изготовления игрушек. Такими игрушками дети охотно играют. Однако надо помнить, что в случае возникновения в группе инфекционного заболевания все бумажные игрушки, находившиеся в пользовании детей, следует уничтожить (лучше всего сжечь). Игрушки, сделанные из папье-маше, в детских учреждениях иметь не рекомендуется, так как с них легко сходит краска и в местах, где она отсутствует, могут надолго задерживаться микробы.

Проблематичны в использовании *мягкие игрушки*. Они легко загрязняются и могут длительно оставаться источником инфекции, на них могут сохраняться и передаваться яйца остриц. В то же время лишить детей, особенно находящихся на круглосуточном режиме или в домах ребенка, мягких игрушек представляется неправильным с психологических позиций. В настоящее время выпускаются мягкие игрушки из синтетических материалов, которые можно стирать и подвергать дезинфекции влажными химическими средствами.

Музыкальные духовые игрушки (трубы, дудки, свистульки, губные гармошки и др.) представляют значительную опасность в распространении среди детей инфекционных заболеваний и поэтому в детских коллективах не используются.

Щипковые, ударные и клавишные инструменты можно использовать в детских играх, однако необходимо помнить, что они создают повышенный уровень шума, который может значительно утомлять детей.

Оптические игрушки — фильмоскопы, калейдоскопы, волшебные фонари, игрушечные подзорные трубы и др. — должны давать четкое, достаточно крупное изображение (высота букв не менее 2,75 см), не вызывающее напряжения зрения. Все игрушки, находящиеся в детском

учреждении, необходимо регулярно очищать от пыли и дезинфицировать. Средства очистки игрушек не должны изменять их внешнего вида, оставлять стойких запахов. Вновь приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в группы должны мыться в течение 15 мин проточной водой (температура 37°C) с мылом и затем высушиваться на воздухе. Резиновые, пенополиуретановые, пенолатексные, пластизольные и другие аналогичные игрушки нужно тщательно отжимать.

В дальнейшем игрушки в младшей ясельной группе следует мыть два раза в день горячей водой щеткой, мылом или 2%-ным раствором пищевой соды, в специально предназначенных для этого (промаркированных) тазах; затем — промывать проточной водой (температура 37°C) и высушивать. Игрушки для детей более старшего возраста необходимо мыть ежедневно в конце дня. Кукольная одежда и мягкие игрушки, подлежащие стирке, стираются по мере загрязнения. Мягкие игрушки ежедневно в конце дня дезинфицируют бактерицидными лампами, установленными на расстоянии 25 см, в течение 30 минут. Пенолатексные ворсовые игрушки обрабатывают согласно инструкции завода-изготовителя.

3. Гигиенические требования к освещению

Естественное освещение помещений в значительной степени зависит от величины окон. Чем больше застеклена поверхность, тем больше света проникает в помещение. Однако очень большая поверхность окон увеличивает в зимнее время охлаждение, в летнее — перегревание помещений. Поэтому площадь застекленной поверхности окон в детских учреждениях принята такой, при которой в ясный день на самом удаленном месте от окна освещенность равна 100 лк (минимально допустимая норма освещения). *Люкс* — единица освещенности. Один люкс равен освещенности, полученной от одной международной свечи на расстоянии 1 м. Отсюда следует, что величина окон зависит от величины помещения, и чем больше площадь последнего, тем больше должна быть площадь световой поверхности окон. Отношение площади остекленной поверхности окон к площади пола называется световым коэффициентом.

Для игровых и групповых помещений в городах России принята норма светового коэффициента 1:4; в сельской местности, где здания детских учреждений, как правило,

строятся на открытых со всех сторон площадках, световой коэффициент допускается 1:5 - 1:6. При площади групповой комнаты, равной 60-62,5 м², площадь окон должна быть равной 12-12,5 м².

Световой коэффициент для остальных помещений, имеющих в основном подсобное значение, составляет не менее 1:8 за исключением

приемной и кабинета врача, где световой коэффициент допускается 1:4-1:5.

Недостатком обычных стекол, даже самых лучших, является то, что они почти не пропускают ультрафиолетовых лучей. Так называемые увиолевые стекла, пропускающие эти лучи, являются более желательными для остекления окон в зданиях дошкольных учреждений, однако в практике строительства они не получили широкого распространения.

Для лучшего освещения детских помещений стены и мебель в них окрашивают в светлые тона — они отражают наибольшее количество света. Нижнюю часть стен на уровне 1,5-1,8 м от пола, подвергающуюся большому загрязнению, окрашивают красками, устойчивыми к влиянию горячей воды, мыла и дезинфицирующих растворов. Остальную часть стен покрывают клеевой краской, потолки помещений белят.

Определить естественную освещенность той или иной части помещения можно или с помощью люксметра — прибора, имеющего чувствительные фотоэлементы, или по наличию частично видимого в окна неба. Если с определенного места в ясный день виден полностью весь небосвод, освещенность этого места считается хорошей; если видно 2/3 небосвода — удовлетворительной, и если только 1/3 — неудовлетворительной.

Недостаток света сказывается на самочувствии ребенка и состоянии его органа зрения более неблагоприятно, чем смешанный свет, поэтому, когда естественного света в помещении мало, следует использовать искусственные его источники.

4. Гигиенические требования к составу воздуха

Воздушная среда помещений оказывает значительное влияние на здоровье ребенка. Плохой химический состав воздуха, очень высокая или очень низкая его температура и влажность могут вызвать нарушение нормальной деятельности организма.

Потребность детей в чистом свежем воздухе очень велика, так как большая частота и малый объем дыхательных движений у них сочетается с высокой потребностью в кислороде. Поэтому необходимо, чтобы химический, физический и биологический состав воздуха в помещениях, т. е. микроклимат, отвечал установленным гигиеническим нормам.

Состав воздуха в помещении в результате длительного пребывания в нем детей постепенно ухудшается: нарастает количество углекислого газа, водяных паров, тяжелых ионов, повышаются температура, запыленность, бактериальная загрязненность, появляются органические примеси, аммиак, сероводород и другие вещества, которые ухудшают самочувствие ребенка.

Органические вещества — аммиак, летучие жирные кислоты, сероводород — выделяются человеком через кожу, ротовую полость и кишечник. Их в воздухе помещений тем больше, чем хуже уход за телом и детской одеждой. Количество органических веществ особенно увеличивается там, где подсушивается плохо постиранное белье и пеленки, сырая одежда и обувь детей.

В помещениях постепенно изменяется и ионный состав воздуха. Легкие ионы, оказывающие положительное влияние на человека, адсорбируются дыхательными путями детей, парами воды, пылевыми частицами, количество их постепенно уменьшается, в то

время как количество тяжелых ионов, содержащихся в выдыхаемом детьми воздухе, увеличивается, тем самым качество воздуха ухудшается.

В процессе жизнедеятельности дети в окружающую среду выделяют значительное количество тепла и водяных паров, вследствие чего повышаются температура и влажность воздуха.

Опасность для организма представляет воздух, насыщенный пылью, в которой задерживается огромное количество микробов, выделяемых при дыхании, кашле, чихании.

Чтобы загрязненность воздуха микробами в дошкольных учреждениях была минимальной, следует внимательно следить за состоянием у детей полости рта и слизистых оболочек дыхательных путей. При разрушении зубов, воспалении слизистой оболочки рта (стоматит) или первых признаках заболевания верхних дыхательных путей: боль в горле, насморк, кашель — ребенка следует показать врачу, если надо, изолировать и провести лечение.

Все изменения химического состава и физических свойств воздуха в жилых помещениях, как правило, происходят параллельно с увеличением углекислого газа. Поэтому о качестве воздуха в помещениях принято судить по количеству содержащегося в нем углекислого газа. Установлено, что наиболее благоприятными для человека являются такие условия, при которых количество углекислого газа в воздухе не превышает 0,1%.

Естественный обмен воздуха в помещениях происходит через поры строительного материала, щели в окнах, дверях под действием ветра и за счет разности температуры, т. е. разности давления внутри помещения и снаружи. Такой обмен воздуха недостаточен. Чтобы усилить его, осуществляют проветривание помещений через открытые окна, фрамуги и форточки.

Длительность проветривания определяется температурой наружного воздуха. Сквозное проветривание при очень низких температурах наружного воздуха (ниже -20°C) проводится не более чем 2-3 мин во избежание переохлаждения помещения, при более теплой погоде — в течение 10-15 мин.

Проветривание должно проводиться одновременно с влажной уборкой помещения и заканчиваться за 30 мин до прихода детей, чтобы к этому времени обновленный воздух достиг оптимальной температуры.

5. Санитарное содержание помещений и участка

Чтобы в помещения проникало меньше пыли, дошкольные учреждения желательно строить вблизи зеленых массивов, при здании иметь озелененный участок, все дорожки, ведущие к дверям здания, залить асфальтом или замостить булыжником, кирпичом.

У входа в детское учреждение снаружи должны быть съемные скребки и деревянные решетки для очистки грязи с обуви, в тамбуре — маты, а в вестибюле — дорожки для окончательной очистки обуви от грязи и пыли. Приходя в детское учреждение, дети должны менять обувь.

Уборка помещений проводится ежедневно влажным способом при открытых окнах или фрамугах, с применением дезинфицирующих растворов.

Полы следует мыть не менее двух раз в день, один раз с обязательным отодвиганием мебели; мебель, радиаторы, подоконники протирают влажной тряпкой; шкафчики для детской одежды протирают ежедневно и раз в неделю моют. Генеральную уборку всех помещений проводят ежемесячно и по эпидпоказаниям.

Столы моют горячей водой с мылом после каждого приема пищи специально выделенной для этого ветошью, которую используют однократно, затем прополаскивают и в конце рабочего дня кипятят в течение 15 мин. Чистую высушенную ветошь хранят в специальной маркированной посуде. Клеенчатые нагрудники моют горячей водой с мылом.

Пеленальные столы, детские подкладные клеенки, покрытия манежа следует мыть водой с мылом два раза в день (послеобед и в конце дня). В случае загрязнения фекалиями очищенные места дополнительно протирать чистой ветошью, смоченной в 1%-ном растворе хлорамина; использованную ветошь обеззараживают в 1 % - ном растворе хлорамина в течение 4 часов в специально выделенной для этой цели посуде. Ковры ежедневно чистят пылесосом, периодически выколачивают и протирают влажной щеткой.

Уборка мусора с участка детского учреждения должна производиться ежедневно утром за 1-2 часа до прихода детей или после их ухода, при закрытых окнах основного здания. В летнее время не менее двух раз в день (перед приходом или подъемом детей и перед дневным сном) необходимо поливать участок.

Вопросы для самопроверки:

1. Особенности и гигиена кожи ребенка.
2. Пиодермит, профилактика.
3. Особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата ребенка.
4. Особенности и гигиена органов дыхания и голосового аппарата
5. Профилактика заболеваний дыхательной системы.
6. Особенности и гигиена органов пищеварения.
7. Клиника молочницы, афтозного стоматита, кариеса.
8. Гигиена зрения у детей.
9. Рациональный режим жизни детей различных возрастных групп.
10. Подвижные игры как фактор развития опорно-двигательного аппарата.
11. Нарушения осанки (плоскостопие, сколиоз), профилактика.
12. Закаливание. Принципы закаливания.
13. Гигиеническая оценка количества и качества составляемой пищи. Рацион питания.
14. Витамины, их значение для организма ребенка.
15. Вскармливание детей до 1 года.
16. Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
17. Питание детей дошкольного возраста.
18. Нарушения питания в детском возрасте, их профилактика.
19. Гигиеническое воспитание детей.
20. Санитарное просвещение родителей.
21. Психическое здоровье — база полноценного развития.
22. Понятие о психокоррекции и психотерапии.
23. Гигиенические требования к оборудованию ДДУ.
24. Гигиенические требования к игрушкам и дидактическому материалу.
25. Гигиенические требования к освещению ДДУ.
26. Гигиенические требования к составу воздуха.

Практические занятия

Темы практических и семинарных занятий

Раздел 1. Практические занятия по дошкольной гигиене

Тема 1. Физиолого-гигиеническая оценка физического развития детей дошкольного возраста.

Вопросы для подготовки:

1. Определение понятия «Физическое развитие».
2. Закономерности развития организма ребенка.
3. Значение знаний о закономерностях роста и развития детей в деятельности работника детского дошкольного учреждения (ДДУ).
4. Понятие и определение «здоровье».
5. Положительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние на формирование здоровья ребенка.
6. Критерии и группы здоровья ребенка.
7. Характеристика возрастных периодов.
8. Показатели физического развития и их физиолого-гигиеническая оценка.

Самостоятельная работа

1. Знакомство с индивидуальными медицинскими картами физического развития детей и формой их заполнения.
2. Освоение методики антропометрических измерений. Слушатели измеряют друг у друга рост, массу тела, окружность грудной клетки, динамометрию кистей рук и спирометрию.
3. Освоение методики оценки физического развития детей по сигмальным отклонениям.
4. Оценивают физическое развитие детей по данным учебных медицинских карт физического развития. Полученные данные оформляют в виде таблицы.

Таблица 1

№ п/п	Ф.И.О. ребенка	Возраст	Рост	Вес	Оценка физ.развития по сигмальным отклонениям
-------	-------------------	---------	------	-----	--

Заключение.

Оснащение:

1. Ростомер.
2. Весы.
3. Сантиметровая лента.
4. Ручной динамометр.
5. Спирометр.
6. Стакан с раствором перманганата калия, спирт.
7. Стандарты физического развития детей дошкольного возраста.
8. Индивидуальные карты развития ребенка.

Тема 2. Гигиенические требования и оценка участка, здания и помещения детского дошкольного учреждения.

Вопросы для подготовки:

1. Гигиенические требования к размещению и планировке ДДУ в городе и сельской местности.
2. Гигиенические требования к зданиям ДДУ.
3. Гигиенические требования к планировке к оборудованию ДДУ.

Самостоятельная работа студентов.

1. Изучение «Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных учреждений».
2. Заготовка рабочих таблиц по оценке участка, здания и помещения ДДУ, проводимых в период прохождения педпрактики.
3. Результаты исследований оформить в виде отчета и доложить на курсовой конференции в конце семестра.

Оснащение:

1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений.
2. Учебные таблицы по теме занятия.

Тема 3. Гигиенические требования и оценка микроклимата в ДДУ.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие о микроклимате, его значение в формировании здоровья ребенка.
2. Физические свойства воздуха, их значение в формировании микроклимата.
3. Теплообмен человека. Теплопродукция, теплоотдача. Особенности теплообмена у ребенка.
4. Способы теплоотдачи. Особенности теплоотдачи у ребенка.
5. Приборы и методика определения параметров микроклимата.
6. Нормирование параметров микроклимата.
7. Причины ухудшения микроклимата и способы его улучшения.
8. Коэффициент аэрации. Определение, норма.

Самостоятельная работа студентов.

1. Изучение «Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных учреждений». Заготовка рабочих таблиц для педпрактики.
2. Измерение параметров микроклимата (температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в учебном помещении. Дать оценку групповой комнаты детского сада.
3. Определить коэффициент аэрации и дать оценку существующей вентиляции в учебном помещении.
4. Полученные результаты исследований оформить в виде таблицы с заключением.

Таблица 2

№ п/п	Показатели	Норма ^x	Фактически	Оценка
1	Температура			
2	Относительная влажность воздуха			
3	Коэффициент аэрации			

^xПримечание. Значение нормы выписываются из «Санитарных правил» в зависимости от выбранного помещения ДДУ.

Оснащение:

1. Психрометр.
2. Катотермометр с инструкцией.
3. Анемометр.
4. Барометр.
5. Электроплитка.
6. Колба с водой, флакон с дистиллированной водой.
7. Салфетка, пипетки.
8. Учебные таблицы.

Тема 4. Гигиенические требования и оценка освещения в ДДУ.

Вопросы для подготовки:

1. Гигиеническое и биологическое значение солнечной радиации.
2. Гигиенические требования к естественному освещению.
3. Факторы, влияющие на интенсивность естественной освещенности в помещениях дошкольного учреждения.
4. Показатели для оценки естественной освещенности, методика их определения и гигиенические нормы: - коэффициент естественной освещенности (КЕО); - световой коэффициент (СК); - коэффициент заглубления; - угол падения; - угол отверстия.
5. Гигиенические требования к искусственному освещению.
6. Нормирование искусственного освещения в ДДУ.
7. Оценка освещенности (искусственной) по удельной электропотребности.

Самостоятельная работа студентов

1. Изучение «Санитарных правил» раздел IV и приложения 7.
2. Определение показателей естественной и искусственной освещенности в учебной комнате.
3. Результаты исследований оформить в виде таблицы и написать заключение.

Таблица 3

№ п/п	Показатели	Норма	Фактически	Оценка
Наименование помещения				
1	КЕО	1, 2-1,5		
2	СК	1:4; 1:5		
3	Коэффициент заглубления	1:2		

4	Угол падения	Не менее 27°		
5	Угол отверстия	Не менее 5°		
6	Освещение на рабочем месте			
7	Удельная электромощность Вт/м ²	42-48		
8	Ориентация	20-23 люм		

Оснащение:

1. Люксметр 10-116.
2. Сантиметровая лента.
3. Рулетка.
4. Угломер.
5. Компас.

Тема 5. Гигиеническая оценка оборудования, игрушек, детской одежды и обуви.

Вопросы для подготовки:

1. Гигиенические требования к оборудованию.
2. Оборудование игровых комнат.
3. Оборудование туалетных, спален, приемной и раздевалки.
4. Гигиенические требования к игрушкам и дидактическому материалу.
5. Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
6. Назначение одежды и обуви.
7. Свойства, предъявляемые к тканям одежды для прогулок в холодное и теплое время года, комнатной одежды.
8. Требования к весу, фасону и покрою детской одежды для различных возрастных групп.
9. Гигиенические требования по уходу за одеждой и обувью.

Самостоятельная работа студентов.

1. Изучение «Санитарных правил», раздел V, VI b, VII, с. 14-21.
2. Отрабатывается методика оценки мебели на мебели учебной комнаты. По результатам исследований составляется протокол и пишется заключение.
3. Оработка методики гигиенической оценки игрушки по схеме:
 - Название игрушки и ее краткое описание;
 - Определение размеров и формы игрушек (наличие острых углов, краев, мелких и легко отделимых деталей);
 - Определение прочности, массы;
 - Описание материалов, из которых сделана игрушка (количество красителей), определение их пригодности для производства игрушек (прочность, загрязняемость и т.д.).
 - Проведение лабораторного определения прочности фиксации красителей:
 - а) мытье игрушки горячей водой (60° C) с мылом не менее 3 мин, затем определяют состояние красок;
 - б) мытье игрушки в течение 3 мин 2%-м раствором хлорной извести комнатной температуры (18° C);
 - в) определяют состояние красителей при воздействии на них в течение 2 мин 1%-м раствором HCl, KOH.

По результатам исследований составляется протокол и пишется заключение.

Оснащение:

1. «Санитарные правила».
2. Санитарная лента, пипетки.
3. Набор детских игрушек.
4. Горячая вода.
5. Мыло, стиральный порошок.
6. 2%-й раствор хлорной извести (хлорамин).
7. 1%-й раствор HCl, KOH.

Тема 6. Гигиеническая оценка режима дня и учебных занятий в детском дошкольном учреждении.

Вопросы для подготовки.

1. Режим дня – определение, значение в развитии и формировании здоровья ребенка.
2. Основные режимные моменты в ДДУ.
3. Гигиенические требования к режиму дня.
4. Учебные занятия и их виды, физиолого-гигиеническое значение в формировании здоровья ребенка.
5. Гигиеническая организация физических упражнений.
6. Организация закаливания детей дошкольного возраста.

Самостоятельная работа студентов.

1. Изучение «Санитарных правил», раздел XII и XIV.
2. Проработка схемы обследования ДДУ по теме занятия.
3. Оценка организации режима дня в ДДУ по данным исследования кафедры.
4. Составление протокола, написание заключения.

Оснащение:

1. Санитарные правила».
2. Методическое пособие для студентов дошкольного факультета по педагогической практике.
3. Таблицы по теме.

Тема 7. Гигиеническая оценка и методы изучения питания детей в детских дошкольных учреждениях.

Вопросы для подготовки.

1. Значение пищи в процессе роста и формировании здоровья ребенка.
2. Принципы нормирования детского питания.
3. Состав пищи.
4. Вскармливание детей первого года жизни.
5. Вскармливание детей от года до 7 лет.
6. Принципы составления сбалансированного рациона питания.
7. Роль пищевого фактора в детской заболеваемости.

Оснащение:

1. «Санитарные правила».
2. Методическое пособие для студентов дошкольного факультета по педагогической практике.

3. Таблицы по теме.

Тема 8. Гигиеническая оценка и методы изучения питания детей в детских дошкольных учреждениях (продолжение занятия № 7).

Вопросы для подготовки.

1. Контроль за организацией питания в дошкольных учреждениях.
2. Основные методы контроля.
3. Органолептическая оценка пищи.
4. Лабораторный контроль за качеством готовой пищи.
5. Оценка эффективности питания детей.
6. Роль родительского комитета, и общественности в организации питания детей в ДДУ.

Самостоятельная работа студентов.

1. Расчет химического состава однодневного меню составленного на предыдущем занятии.
2. Гигиеническая оценка питания детей в ДДУ по материалам исследований кафедры.
3. Составление протокола в виде таблиц (см. метод. указания для студентов).
4. Написание заключения по оценке питания в ДДУ.

Оснащение:

1. Таблицы химического состава пищевых продуктов.
2. Методическое пособие для студентов дошкольного факультета по педагогической практике.
3. Учебные таблицы.

Тема 9. Воспитание осанки и предупреждение плоскостопия.

Вопросы для подготовки:

1. Признаки правильной осанки.
2. Виды неправильной осанки у детей.
3. Меры предупреждения неправильной осанки.
4. Влияние неправильной осанки на организм ребенка.
5. Плоскостопие и меры предупреждения.

Самостоятельная работа студентов.

1. Отработка методики определения осанки на студентах обучающейся группы.
2. Оценка осанки по рисункам, соматометрическим и соматоскопическим описаниям.
3. Написание развернутого заключения по оценке осанки.
4. Отработка методики определения плоскостопия на студентах обучающейся группы.

Оснащение:

1. Учебные таблицы.
2. Синька (раствор)
3. Листы бумаги (формат А 4).
4. Учебные описания индивидуальной осанки детей (по материалам педпрактики).

Тема 10. Методы оценки заболеваемости в детском дошкольном учреждении.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие «Здоровье». Группы здоровья.
2. Значение изучения детской заболеваемости в дошкольном учреждении.
3. Показатель общей интенсивности заболеваний в случаях и днях.
4. Удельный вес или структура заболеваемости в случаях и днях.
5. Индекс здоровья. Процент часто и длительно болеющих детей.
6. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение детской заболеваемости.

Самостоятельная работа студентов.

1. Расчет показателей заболеваемости.

Показатели заболеваемости	Способ расчета
1. Болевшие лица	$\frac{\text{Число болевших детей}}{\text{Численность круглогод. лиц}} \times 100$
2. Случаи	$\frac{\text{Число невыходов в ДДУ по болезни}}{\text{Численность круглогод. лиц}} \times 100$
3. Дни	$\frac{\text{Число дней нетрудоспособности}}{\text{Численность круглогод. лиц}} \times 100$
4. Средняя длительность или тяжесть заболевания	$\frac{\text{Число дней нетрудоспособности}}{\text{Число случаев заболеваний}}$
5. Распределение (удельный вес или структура заболеваемости)	$\frac{\text{Число случаев (или дней) заболевания}}{\text{Число случаев (или дней) по всем заболеваниям}} \times 100$
6. Часто и длительно болеющие (ЧДБ)	$\frac{\text{Число часто болевших детей}}{\text{Численность круглогод. лиц}} \times 100 (\%)$
7. Индекс здоровья	$\frac{\text{Число неболевших детей}}{\text{Численность круглогод. лиц}}$
8. Процент потери детодней по болезни	$\frac{\text{Пропущенные дни по болезни}}{\text{Сумма детодней (всего)}} \times 100 (\%)$
9. Процент изменения заболеваемости по случаям и дням	$\frac{\text{Заболеваемость в случаях (или днях) Текущего периода}}{\text{Заболеваемость в случаях (или днях) Предыдущего периода}} \times 100$

Таблица 4

№ п/п	Название болезни	Случаи				Дни		Дни		Распределение	Процент изменения
		Абс:	На 100 чел, 1990 г.	Абс:	На 100 чел, 1991 г.	Абс:	На 100 чел, 1990 г.	Абс:	На 100 чел, 1991 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Оформить результаты расчетов в виде протокола и таблицы, написать заключение.
3. Составить план мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости.

Оснащение:

1. Исходный первичный материал по заболеваемости по данным предыдущим педагогических практик.
2. Учебные таблицы.

Литература:

1. *Дробинская А. О.* Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. М., 2003.
2. *Кашанов Р.* Практическая психология для родителей или педагогика взаимности. М., 2003
3. *Гуровец Г. В.* Детская невропатология. М., 2004.
4. *Казин Э. М., Блинова М. Г., Литвинова Н. А.* Основы индивидуального здоровья человека. М., 2000.
5. *Тонкова-Ямпольская Р. В., Черток Т. Я., Алферова И. Н.* Основы медицинских знаний. М., 1993

**МОДУЛЬ III. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ, ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ**
**ТЕМА 2: САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, СанПиН**

**Лекция 1: Основная характеристика санитарных норм и правил в сфере
дошкольного образования, СанПиН**

План

- 1. Санитарно-гигиенические нормы для детского сада: требования к приему детей в группы дошкольного образования.**
- 2. Санитарно-гигиенические нормы в детском саду для персонала групп дошкольного образования.**
- 3. Санитарно-гигиенические нормы для детского сада: требования к благоустройству помещений для групп дошкольного образования.**
- 4. Санитарно-гигиенические нормы в детском саду: требования для групп дошкольного образования**

Роспотребнадзор утвердил очередные изменения в сфере санитарных норм для дошкольных учреждений. Особенно достойны внимания утвержденные санитарно-гигиенические нормы в детских садах для групп дошкольного образования, размещенных в жилых помещениях. Данные требования являются обязательными для исполнения как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, их образованию.

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 № 68 (далее – СанПиН 2.4.1.3147-13), вступили в силу в феврале 2014 г.

Требования данного документа распространяются на любые дошкольные группы, расположенные в жилых квартирах, в том числе и на группы, осуществляющие присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.

Следует иметь в виду, что при организации дошкольных групп в жилых помещениях нужно руководствоваться не только СанПиН 2.4.1.3147-13, но и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-гигиенические нормы условий проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 (в части, не противоречащей СанПиН 2.4.1.3147-13).

Важно! Обязательных документов, оформляемых до начала работы группы дошкольного образования в жилом помещении, новыми санитарно-гигиеническими нормами для детского сада предусмотрено немного. Несмотря на то что деятельность по уходу и присмотру за детьми не подлежит лицензированию, нужно получить санитарно-эпидемиологическое заключение на жилые помещения для дошкольных групп (п. 1.8 СанПиН 2.4.1.3147-13).

1. Санитарно-гигиенические нормы для детского сада: требования к приему детей в группы дошкольного образования

Минимальный возраст детей, принимаемых в дошкольные группы, нормами СанПиН 2.4.1.3147-13, не ограничен, а максимальный выше, чем предусмотрен для традиционных дошкольных образовательных организаций – 8 лет.

При этом требования к площади более лояльны, чем установленные для детских садов – не менее 2 м² площади игровой комнаты на одного ребенка (п. 1.5 СанПиН 2.4.1.3147-13). Кроме того, прием детей, впервые поступающих в дошкольные группы, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами для детского сада, осуществляется на основании медицинского заключения.

2. Санитарно-гигиенические нормы в детском саду для персонала групп дошкольного образования

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами для детского сада, персонал дошкольных групп, расположенных в жилых помещениях, должен проходить:

- вакцинацию согласно национальному календарю прививок;
- предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в общем для всех работников дошкольных образовательных организаций порядке (согласно приказу Минздрав соцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»);
- аттестацию на знание СанПиН 2.4.1.3147-13 один раз в два года, а персонал пищеблока и лица, участвующие в раздаче пищи детям, – не реже одного раза в год.

3. Санитарно-гигиенические нормы для детского сада: требования к благоустройству помещений для групп дошкольного образования

Для организации дошкольных групп, новыми санитарно-гигиеническими нормами для детского сада предусмотрен минимальный набор помещений: одна комната (игровая), кухня, прихожая, туалет (допускается общий для детей и персонала), умывальная комната. Места для сна и приема пищи могут быть оборудованы в игровой комнате. При этом для оснащения игровой комнаты обычная «домашняя» мебель не подойдет.

Требования к мебели, предназначенной для дошкольных групп, предъявляются почти такие же, как и к мебели, установленной в детских садах. В пунктах 2.6, 2.9 СанПиН 2.4.1.3147-13 описаны правила подбора столов, стульев и кроватей для детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

Отделка стен и потолков, в соответствии с новыми санитарно-гигиеническими нормами для детского сада должна быть такой, чтобы обеспечить возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. По этой причине бумажные обои в дошкольных группах использовать нельзя.

Санитарно-гигиенические нормы для детского сада, расположенного в жилом помещении, допускают оснащение кухни как для обыкновенной жилой квартиры, обязательно наличие двухсекционной мойки, как минимум двух рабочих столов (с маркировками «сырая продукция» и «готовая продукция»), а также двух мясорубок (или

двух различных насадок для бытового кухонного комбайна) – для сырой и готовой продукции. Допускается использование посудомоечной машины.

Кухонная посуда и разделочный инвентарь также должны быть промаркированы соответственно назначению и храниться отдельно от столовой посуды. На кухне достаточно одного холодильника, но для сырых и готовых продуктов санитарно-гигиенические нормы для детского сада предусматривают необходимость использования разных полок: продукты, подлежащие тепловой обработке при приготовлении, хранятся ниже готовых к употреблению в пищу. Во всех отделениях холодильника с разным температурным режимом должны быть термометры для контроля температуры.

Новые санитарно-гигиенические нормы в детском саду позволяют не оборудовать кухню и место для сна в группах кратковременного (менее четырех часов) пребывания детей.

4. Санитарно-гигиенические нормы в детском саду: требования для групп дошкольного образования

Санитарно-гигиенические нормы для детского сада, расположенного в жилом помещении, схожи требованиями к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций в плане соблюдения правил личной гигиены и санитарно-гигиенического режима.

Например, у каждого ребенка должно быть индивидуальное полотенце, а смена постельного белья и полотенец – не реже одного раза в неделю. Для стирки белья в условиях жилого помещения можно использовать бытовую стиральную машину. При этом рекомендуется выбрать модель стиральной машины с сушилкой, так как сушка белья в основных помещениях групп не допускается.

Гигиенические требования в детском саду предусматривают ежедневное проведение влажной уборки с использованием моющих средств. Раковины и унитазы обрабатываются обычными моющими средствами, а дезинфицирующие средства используются только по предписанию специалистов Роспотребнадзора (при наличии показаний).

Вполне логичными представляются меры, которые предусмотрены СанПиН 2.4.1.3147-13 в отношении заболевших воспитанников: изолировать от других детей, сообщить родителям и в детскую поликлинику, при необходимости госпитализировать. Для того чтобы не пришлось прибегать к подобным действиям, воспитатели должны ежедневно проводить опрос родителей при приеме детей в группу для выявления у них симптомов заболеваний.

Требования к режиму дня воспитанников, предусмотренные санитарно-гигиеническими нормами детского сада в жилом помещении Санитарно-гигиеническими требованиями для детского сада предъявляются минимальные требования к режиму дня воспитанников. Регламентируются продолжительность прогулок (3–4 часа два раза в день) и дневного сна (2 часа), максимальная продолжительность занятий (от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей) и перерывов между ними (не менее 10 минут).

Для организации прогулок подойдут обычные детские площадки, внутридомовые территории, скверы и парки. Требования к организации питания в дошкольных группах, в новых санитарно-гигиенических нормах для детского сада, расписаны крайне подробно, однако по сути не отличаются от требований к организации питания в детских садах. Пища должна готовиться на месте из сырья или полуфабрикатов, но допускается доставка

готовых блюд в термосах из комбинатов питания, пищеблоков детских садов и школ, а также организаций общественного питания.

Примерное меню составляется на две или более недели и не требует согласования с контролирующими органами. Рацион питания должен обеспечивать физиологические потребности в энергии и пищевых веществах детей соответствующего возраста с учетом времени их пребывания в группе дошкольного образования и количества приемов пищи.

В выполнении этого требования помогут Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», утв. Роспотребнадзором 18.12.2008.

В Санитарно-гигиенических нормах для детского сада указаны четкие требования к продолжительности времени между приемами пищи – не более четырех часов. Остальные положения относительно режима питания являются рекомендуемыми.

Для приготовления пищи целесообразно использовать набор разнообразных пищевых продуктов, взяв за ориентир рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, приведенные в приложении 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. В п. 3.5 СанПиН 2.4.1.3147-13 приводится типовой набор блюд для каждого приема пищи (вполне традиционный), а в п. 3.6 – суммарный объем порций блюд для детей каждого возраста, обеспечивающий насыщение и исключающий переизбыток.

В соответствии с новыми санитарно-гигиеническими нормами для детского сада, документы на получаемые продукты или готовую пищу (товарно-транспортные накладные с указанными в них реквизитами деклараций о соответствии) требуются лишь при централизованной поставке.

В случае если продукты закупаются в магазинах и на рынках, достаточно наличия маркировочных ярлыков (этикеток) и кассового чека, которые сохраняются до окончания срока реализации пищевых продуктов и блюд.

Поскольку многие продукты, реализуемые в магазинах, не подходят для организации детского питания, рекомендую внимательно ознакомиться со следующими документами:

- список продуктов, запрещенных к использованию в питании детей (приложение 2 к СанПиН 2.4.1.3147-13);
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 № 3;
- раздел 1 главы II Единых санитарно-гигиенических норм к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Выдаваемые детям блюда должны проходить обязательный контроль с записью в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, форма которого приведена в СанПиН 2.4.1.3147-13. При организации дошкольных групп в жилых помещениях не следует забывать и о питьевом режиме. Для этой цели рекомендуется использовать бутилированную питьевую воду, допускается и кипяченая водопроводная вода, срок хранения которой не более трех часов. Следует помнить, что персонал и администрация дошкольных групп, размещенных в жилых помещениях, несут такую же ответственность

за соблюдение санитарного законодательства, как и работники дошкольных образовательных организаций.

Вопросы для самопроверки:

1. СанПиН для дошкольных образовательных учреждений (основные положения и область применения).
2. Требования СанПиНа (режим дня).
3. Требования к соблюдению санитарных правил.
4. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала.
5. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций.
6. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.
7. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.
8. Требования к организации физического воспитания.
9. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса.
10. Требования к дошкольным образовательным организациям и группам для детей с ограниченными возможностями здоровья.
11. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию.
12. Требования к размещению дошкольных образовательных организаций. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций.
13. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций.
14. Требования к естественному и искусственному освещению помещений.
15. Требования к отоплению и вентиляции.

Литература:

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13). - http://www.consultant.ru/law/podborki/sanpin_dlya_doshkolnyh_uchrezhdenij

2. Цветкова Т.В. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13) / Т.В. Цветкова. – СПб.: Сфера, 2015. – 96 с.

МОДУЛЬ III. ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ, ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ТЕМА 3: ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Лекция 1: Профилактика болезней детей и первая помощь при несчастных случаях и травмах

План

- 1. Пищевые отравления.**
- 2. Отравления небактериального происхождения.**
- 3. Другие неотложные состояния.**

1. Пищевые отравления

Выделяют пищевые отравления, возникающие при употреблении продуктов, содержащих большое количество болезнетворных микробов и их токсинов, и отравления небактериальными веществами: солями тяжелых металлов, лекарствами, ядохимикатами, ядовитыми растениями и грибами.

При неправильном хранении, перевозке и обработке продуктов питания в них могут попасть болезнетворные микробы или вредные вещества. Такие продукты, даже иногда не имеющие видимых признаков порчи, могут вызвать тяжелые заболевания, получившие название *пищевых токсикоинфекций*.

В большинстве случаев пищевые бактериальные отравления связаны с употреблением в пищу недоброкачественных продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молока, консервов и т. д. Первые признаки отравления появляются довольно быстро, обычно по прошествии нескольких часов. Особенность пищевых отравлений в детских учреждениях — массовый характер заболевания, не ограничивающийся одной группой.

Наиболее часто встречаются следующие виды пищевых отравлений бактериального происхождения:

- отравления, вызванные микробами из группы сальмонелл, которые чаще всего обитают в мясе и мясных продуктах, полученных от больных животных, а также поражают гусиные и утиные яйца, поэтому использование этих яиц для питания детей запрещается;

- отравления, вызванные условно-патогенными бактериями, главным образом кишечной палочкой и протеем. Заражение ими продуктов питания происходит только там, где плохо соблюдаются санитарно-гигиенические правила содержания пищеблока, правила личной гигиены, обработка и хранение продуктов питания;

- стафилококковые отравления. Источником заражения продуктов питания стафилококками являются люди, болеющие ангинами, гнойничковыми заболеваниями кожи. Стафилококки хорошо развиваются в молоке и молочных продуктах, мясе, рыбе.

Первые признаки отравления сальмонеллами, кишечной палочкой, стафилококками — общая слабость, боли в животе, тошнота, рвота. В дальнейшем может повыситься температура, присоединиться жидкий стул;

- ботулизм, вызываемый особым микроорганизмом — подвижной палочкой, живущей в анаэробных условиях (без доступа кислорода). Палочка ботулизма находится в почве, откуда попадает в воду, на свежие овощи и фрукты, в пищевые продукты, а с ними в кишечник человека, животных и рыб, где и размножается. Оптимальные условия для

сохранения и размножения микроба ботулизма представляют собой различные виды консервов, как мясных и рыбных, так и фруктовых и овощных.

При подозрении на пищевое отравление заболевших детей изолируют и оказывают им первую помощь: проводятся мероприятия, направленные на удаление недоброкачественных продуктов питания из желудочно-кишечного тракта ребенка — вызывание рвоты или промывание желудка физиологическим раствором, прием адсорбирующего вещества (обычно активированного угля). Больного надо уложить в постель, тепло укрыть, давать обильное питье (глюкозо-солевой раствор). Вопрос о необходимости госпитализации и дальнейшем лечении решает врач. Лечение, прежде всего, должно быть направлено на предотвращение обезвоживания в результате рвоты, уменьшение интоксикации (внутривенное введение жидкости, мочегонные средства), иногда применяются антибактериальные препараты.

Профилактика пищевых токсикоинфекций заключается в строгом и постоянном соблюдении персоналом и детьми правил личной и общественной гигиены, контроле за качеством, условиями и сроками хранения продуктов.

2. Отравления небактериального происхождения

Не бактериальные отравления чаще всего бывают вызваны следующими причинами:

- попаданием в организм солей тяжелых металлов (наиболее частые — отравления свинцом, цинком, железом). Отравление свинцом может быть острым или хроническим и встречается у детей в экологически угрожающих районах, при употреблении водопроводной воды плохого качества, при облизывании и обгрызании маленькими детьми предметов, покрытых красками, содержащими свинец. Проявления такого отравления — снижение аппетита, боль в животе, раздражительность, сонливость, в тяжелых случаях судороги. Отравления цинком встречаются несколько чаще других и возникают при хранении в оцинкованной посуде кислых продуктов и напитков, например кваса, молока, компота и т. д. Признаки отравления появляются быстро, через 20-30 мин после принятия отравленного продукта. Основные из них — кратковременная рвота, головокружение, слабость.

Отравление железом возможно при небрежном хранении лекарственных препаратов, содержащих железо. Признаками его являются тошнота, понос, кровь в кале, боль в животе, сонливость;

- употреблением продуктов, на которые при обработке сельхозпродуктов или помещений пищеблока попали ядохимикаты (ДДТ, гексахлоран и др.). Проявляются эти отравления как симптомами раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос), так и нарушением функции легких (одышка, кашель) и нервной системы (беспокойство, сонливость, отсутствие сознания). Основными предупредительными мероприятиями являются строгое соблюдение правил по применению ядохимикатов;

- грибами в результате неправильной заготовки или хранения, а также при употреблении в пищу несъедобных грибов. Поэтому при сборе и заготовке грибов, особенно с участием самих детей, необходим строгий контроль со стороны взрослых, хорошо знающих грибы;

- употреблением ядовитых растений и ягод. Отравления возникают при неумении отличить ядовитые растения и ягоды от несъедобных (съедобных). Чаще других встречаются отравления семенами белены, плодами крушины, корневищами веха (дикая морковь), листьями болиголова и др. Основные предупредительные мероприятия сводятся

к ознакомлению всех детей с ядовитыми растениями, строжайшему запрещению употребления в пищу всех неизвестных детям ягод, плодов, семян, корневищ и т. д.;

- лекарствами при их хранении в доступных для детей местах. Природная любознательность маленьких детей, яркая соблазнительная расцветка многих таблеток, их сладкая оболочка способствуют тому, что лекарственные отравления являются актуальной проблемой у детей раннего и дошкольного возраста. Для профилактики этого вида отравлений необходим строгий контроль за хранением лекарственных средств, размещение их в недоступных для детей местах;

- случайным употреблением кислот и щелочей, моющих и отбеливающих средств, парфюмерных средств и другой бытовой химии, алкоголя.

Отравления могут возникнуть как при проглатывании ядовитого вещества, так и при дыхании его парами или нанесении на кожу. Последний путь проникновения яда в организм нередок у маленьких детей, так как их кожа обладает повышенной способностью к всасыванию (например, алкогольная интоксикация возможна у ребенка первых месяцев жизни при проведении ему спиртового компресса).

Признаками отравления могут быть:

- острая боль в желудке; рвота; понос;
- шатающаяся походка или неспособность ходить;
- медленные или нерегулярные удары сердца, учащенное сердцебиение; одышка, нерегулярный ритм дыхания, очень медленное глубокое дыхание; необычный запах при дыхании;
- синие губы; сильная потливость или слюноотделение;
- сухость во рту; галлюцинации;
- снижение температуры тела, озноб;
- снижение кровяного давления вплоть до потери сознания;
- расширенные или сильно суженные зрачки;
- возбужденное или агрессивное поведение, растерянность, спутанное сознание; судороги; головная боль;
- кома (потеря сознания с отсутствием реакции на болевые стимулы).

При всех видах отравлений помощь ребенку должна оказываться незамедлительно. Он срочно должен быть осмотрен врачом, в тяжелых случаях требуется немедленная госпитализация в отделение интенсивной терапии для поддержания жизненных функций организма. В некоторых случаях возможно применение антидота — специфического противоядия, однако некоторые яды не имеют антидотов.

Мероприятия по оказанию первой помощи ребенку необходимо начать немедленно, *не дожидаясь прихода врача*. Направлены они, прежде всего, на предотвращение всасывания токсического вещества в кровь. При попадании токсического вещества на кожу его смывают струей проточной воды, при вдыхании — перемещают ребенка на свежий воздух, а при поступлении внутрь, прежде всего, уменьшают всасывание в желудочно-кишечном тракте. В последнем случае существует три способа: удаление содержимого желудка путем промывания его физиологическим раствором, введение вещества, связывающего яд (обычно активированного угля), и применение слабительных (обычно сернокислая магнезия из расчета 250 мг на 1 кг веса). Набор для оказания первой помощи при отравлениях должен быть в медицинской комнате каждого детского учреждения.

3. Другие неотложные состояния

Обморок вызывается малокровием мозга. Причины его различны: усталость, сильное волнение, голод, потеря крови, угар, длительное пребывание в непроветриваемом помещении и др. Признаки обморока: бледность, потеря сознания, редкое дыхание, слабый пульс.

Если обморок у ребенка случился в помещении, надо открыть все форточки, фрамуги, а в теплое время года — и окна, чтобы обеспечить наилучший приток чистого воздуха. У больного расстегивают воротничок,

лиф, пояс и укладывают его на спину, чтобы голова была слегка ниже, а ноги на 30-40 см выше туловища (при таком положении тела приток крови к голове усиливается). Затем смачивают ватку нашатырным спиртом и подносят ее к носу больного на несколько секунд. Запах нашатырного спирта способствует расширению сосудов мозга, однако большие его концентрации могут вызвать временный паралич сосудодвигательного центра, поэтому долго вдыхать его запах больному не следует. При потере сознания с остановкой дыхания следует сделать искусственное дыхание. В случае появления у больного рвоты его голову надо повернуть набок и удалить рвотные массы изо рта, чтобы они не попали в дыхательные пути. Когда больной пришел в сознание, ему дают крепкий чай или кофе.

Шок представляет собой проявление тяжелого нарушения кровообращения, приводящего к кислородной недостаточности мозга и других тканей и органов. Проявляется шок изменением сознания (сознание может отсутствовать, может быть недостаточно ясным — ребенок как бы находится в прострации), бледностью, потливостью, вялой реакцией зрачков на свет, снижением давления и температуры кожных покровов, уменьшением количества мочи. Характерным признаком шока является потеря болевой чувствительности и неадекватное состоянию поведение больного — например, ребенок с тяжелым переломом ноги может стремиться самостоятельно ходить и удивляться, почему нога у него сгибается в необычном месте.

Для того чтобы свести к минимуму вероятность развития шока, необходимо своевременно оказать пострадавшему первую помощь. Прежде всего, надо *уменьшить боль*, так как она в значительной мере способствует развитию шока. С этой целью проводится иммобилизация поврежденных частей тела, минимизируются манипуляции с поврежденной поверхностью, обязательно вводятся обезболивающие средства. Очень важно *остановить кровотечение*, особенно артериальное — потеря крови усугубляет шоковое состояние, а также сама может вызвать его. Для предупреждения инфекционного шока, часто сопровождающего менингококковую инфекцию, дифтерию, заражение крови (сепсис), необходимо *раннее выявление и своевременное лечение инфекции*. Вероятность анафилактического (аллергического) шока снизится, если перед введением ребенку лекарственных препаратов или вакцин будет уточнена его аллергическая реактивность, при необходимости введены противоаллергические препараты. Если же препарат введен и аллергическая реакция интенсивно развивается, необходимо *наложить жгут на конечность выше места введения препарата, вызвавшего аллергию* (если он введен в конечность), *обложить ее льдом для замедления всасывания*.

Тепловой и солнечный удар. У ребенка, длительное время находящегося в сильно нагретом помещении или в жаркую безветренную погоду на воздухе, нарушается нормальная терморегуляция организма, и температура тела повышается — происходит *тепловой удар*. Проявляется он вялостью, покраснением лица, обильным

потоотделением, головной болью, нарушением координации движений. В более тяжелых случаях дыхание ребенка учащается, лицо бледнеет, наступает потеря сознания. Такие же явления происходят при длительном действии на непокрытую голову ребенка прямых солнечных лучей(*солнечный удар*).

Заметив признаки теплового или солнечного удара, пострадавшего необходимо перевести в тенистое, прохладное место, уложить, снять одежду, смочить голову и грудь прохладной водой. При отсутствии дыхания или сильном его ослаблении следует сделать ребенку искусственное дыхание, после чего показать его врачу.

Укусы насекомых. *Укусы насекомых* (комаров, пчел, ос, шершней, слепней, блох) и клещей особенно распространены летом, когда дети много времени проводят на улице. Укусам блох нередко подвергаются дети, общающиеся с домашними животными, когда те не получают должного ухода. Укусы вшей возникают при заражении педикулезом, которое может произойти как в детском коллективе, так и при случайном контакте.

Обычно укус вызывает появление красного пятна с небольшой ранкой, иногда кровоточащей, а также небольшую припухлость вокруг. Расчесывая кожу после укусов, дети могут занести инфекцию, в результате чего возникают гнойничковые заболевания.

Укусы блох вызывают появление красноватых пупырышков на руках, ногах, шее или на закрытых частях тела, соприкасающихся с трущейся одеждой.

Укусы клещей часто напоминают крупные родинки, на них часто и удерживается насекомое. Если клещ уже отстал от кожи, то на месте, где он внедрялся, остается красное пятно или опухоль. Иногда может возникнуть пятно с красным центром, с белым кольцом вокруг места укуса, вокруг которого расположено еще одно красное кольцо или просто красная расширяющаяся зона. Клещи особенно опасны тем, что могут быть переносчиками тяжелой болезни — клещевого энцефалита, поражающего вещество мозга.

После укусов комаров могут возникать волдыри с сильным зудом, иногда настолько выраженным, что дети становятся беспокойными, плохо спят.

Пчелы, осы, шершни жалят больно, место укуса окружено опухолью, в нем нередко остается жало насекомого.

В организм ребенка от укуса попадает яд, вызывающий припухлость и покраснение кожных покровов. Острая боль, которую пострадавший испытывает в первое время после укуса, в дальнейшем переходит в сильный зуд. Через 2-3 дня все болезненные явления проходят.

Вши — мелкие насекомые, они двигаются быстро и часто неразличимы невооруженным глазом. Распространяются они обычно при тесном контакте людей. Их яйца выглядят как белые или серые крошки на одежде или на волосах. Вши могут быть разносчиками тяжелой инфекции — сыпного тифа. Сами укусы не слишком болезненны, почти не заметны, но они вызывают интенсивный зуд, при расчесывании ребенок может поцарапать кожу и занести в ранку инфекцию. На месте укусов появляется гной, набухают и размягчаются лимфатические узлы. Если расчесанных и воспалившихся участков много, у ребенка может повыситься температура.

В большинстве случаев укусы насекомых доставляют беспокойство, но не опасны. Укусы кровососущих и жалящих насекомых можно лечить дома, промыв пораженное место водой с мылом, приложив лед или холодный компресс, чтобы снять боль и зуд. Если жало с ядом осталось в коже, его нужно удалить пинцетом так, чтобы не раздавить, в противном случае яд проникнет в тело. Чтобы уменьшить зуд, можно протереть укушенные места спиртом, одеколоном, водкой. По приезде на дачу наиболее открытые

части тела ребенка (лицо, шею, руки, ноги) следует смазывать кремами-репеллентами, отпугивающими комаров.

Однако при измененной реактивности организма ребенка, при предрасположенности к аллергии, а также при множественных укусах, особенно у маленьких детей, реакция на укусы может быть тяжелой. Необходимо обратиться к врачу в тех случаях, когда в месте укуса возникает значительная опухоль или появляется гной, опухают региональные лимфатические узлы, через какое-то время после укуса повышается температура, появляются головные боли, сонливость или другие нарушения общего состояния. Необходимо срочно обратиться к врачу, если у ребенка наблюдаются распространенные отеки и покраснение кожи, крапивница, тошнота, затрудненное дыхание.

Для профилактики укусов кровососущих и жалящих насекомых надо избегать мест их скопления и размножения, использовать репелленты (отпугивающие средства) и механические средства защиты (противомоскитные сетки и т. п.). Детей необходимо обучать правилам обращения с живой природой (не разорять гнезда ос, не хватать насекомых в руки). От укусов клещей предохраняет одежда, поэтому находиться в местах, где могут встречаться клещи, следует в одежде, закрывающей ноги и нижнюю часть туловища, после прогулки рекомендуется внимательно осмотреть тело ребенка и удалить обнаруженных клещей. Если речь идет об укусах блох, то нужно осмотреть домашних животных и уничтожить у них насекомых. При обнаружении у ребенка вшей волосистая часть головы обрабатывается специальным противопедикулезным шампунем, ребенок моется, одежда подвергается сухожаровой обработке, осматриваются находившиеся в контакте взрослые.

Инородные тела (кости, пуговицы и др.) нередко попадают в **глотку и пищевод** детей и, застревая там, приводят к затруднениям при приеме пищи, к повреждениям, а при длительном их пребывании там — и к прободению стенки глотки или пищевода, развитию гнойного процесса в окружающих тканях. Пострадавшего необходимо срочно направить к врачу, запрещается прием пищи или проглатывание хлебных корок для проталкивания инородного тела в желудок. Если инородное тело из пищевода попало в желудок, то через двое-трое суток оно безболезненно выйдет естественным путем.

При попадании инородного тела **в желудок и кишечник** не следует ограничивать ребенка в пище, а также давать ему слабительные средства. Голодная диета, уменьшая перистальтику, задерживает выход инородного тела, слабительные же средства, наоборот, значительно усиливают сокращение стенок кишечника, что может способствовать их повреждению инородным телом. В указанных случаях ребенку нужно давать мягкий хлеб, каши, кисели, т. е. такую пищу, которая, обволакивая инородное тело, защищала бы стенки желудка и кишечника от повреждений. Если проглоченный предмет был острым (гвоздь, игла, вилка и др.), то ребенка немедленно направляют в больницу

Попадание инородных тел **в гортань, трахею, бронхи** ребенка вызывает внезапный приступ удушья (асфиксия), сопровождающийся посинением лица и губ, судорогами, кашлем. В большинстве случаев, если инородное тело небольших размеров, после сильного приступа кашля оно со струей воздуха вырывается наружу и дыхание ребенка восстанавливается. Если же инородное тело остается в дыхательных путях, оно может вызвать там воспалительные процессы или закупорку бронхов, остановку дыхания,

впадение легочной ткани. Поэтому при первых признаках асфиксии ребенка следует немедленно отправить в больницу.

Инородное тело **в конъюнктиве и роговице глаз** (песчинка, выпавшая ресница, мошка и т. д.) вызывает жжение, слезотечение, светобоязнь. Если при осмотре глаза оно хорошо видно, его надо удалить кусочком марли, смоченным в 1%-ном растворе борной кислоты. Можно попытаться удалить инородное тело, интенсивно промывая глаз водой из пипетки; если это не поможет, ребенка надо отправить к специалисту, так как длительное пребывание инородного тела в глазу вызывает воспаление конъюнктивы и роговицы.

Попадание инородных тел **в ухо** (горошина, бусина, пуговица и др.) вызывает шум, дискомфорт, ухудшение слуха. Особенно неприятные ощущения бывают от насекомых, попавших в ухо: мух, муравьев, пауков и пр. Для удаления их из уха в него вливают половину чайной ложки подогретого жидкого масла, глицерина, спирта или водки, а затем на 5-10 мин кладут ребенка больным ухом вниз. Инородное тело или погибшее насекомое должно выйти вместе с жидкостью. Если таким способом инородное тело из уха ребенка удалить не удастся, его направляют к врачу.

Инородное тело, попавшее **в нос** ребенка, затрудняет дыхание, вызывает чихание, а в запущенных случаях обильные слизисто-кровянисто-гнойные выделения. Чтобы удалить инородное тело из носа, ребенку надо предложить зажать здоровую ноздрю и с силой высморкаться; раздражая слизистую носа перышком, бумажкой, вызвать у него чихательный рефлекс. Если предлагаемые меры не помогут, ребенка следует направить к врачу.

Утопление. Вытащив пострадавшего из воды, надо снять или срезать с него мокрую одежду, очистить обернутыми чистым платком или марлей пальцами рот и глотку от грязи, тины и земли и удалить из дыхательных путей и желудка воду. Для удаления воды надо встать на одно колено, положить пострадавшего поперек другого своего колена и, осторожно надавливая на спину, сжимать его грудь. После того как вода будет удалена, пострадавшего следует уложить на теплую подстилку, сделать ему искусственное дыхание, избегая надавливания на живот, чтобы остатки воды из желудка не попали в дыхательные пути. Искусственное дыхание производят с помощью резиновой трубки, один конец которой вставляют в нос или рот пострадавшего, другой должен находиться во рту оказывающего помощь. Если резиновой трубки нет, воздух можно вдыхать непосредственно ртом в рот пострадавшего, проложив между губами несколько слоев марли или чистый носовой платок. Движения, производящие вдох, надо повторять спокойно, размеренно, согласно частоте дыхания пострадавшего (у детей дошкольного возраста примерно 22-26 раз в минуту). Искусственное дыхание нужно проводить непрерывно и долго, иногда несколько часов, пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно. Одновременно с искусственным дыханием пострадавшего по возможности надо хорошо укрыть, обложив грелками, растирать его тело, давать ему нюхать нашатырный спирт.

Когда пострадавший придет в сознание, надо надеть на него сухое белье, потеплее укрыть, напоить горячим чаем или кофе и отправить в лечебное заведение.

Лекция 2: Причины заболеваний и травматизм у детей, влияние их на организм

План

1. **Виды детского травматизма, оказание доврачебной помощи.**
2. **Признаки, по которым можно определить заболевания у ребенка.**
3. **Меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в ДОУ.**
4. **Медицинское обслуживание в дошкольных учреждениях.**

Для предупреждения, детского травматизма и несчастных случаев дети всегда должны находиться в поле зрения взрослых, не оставаться одни ни в помещении, ни во время прогулок. Вся мебель должна быть устойчивой, картины — висеть прочно, электроприборы, штепсели, выключатели должны быть недосягаемы для детей. На территории дошкольного учреждения необходимо удалять все острые предметы: гвозди, железо, стекло и др. В местах прогулок за пределами территории должны быть надежно закрыты сточные люки, не должно быть канав и ям с водой.

Мелкие предметы для игр детям не даются и хранятся в недоступных для них местах. Все медикаменты должны храниться в запертых шкафах и быть абсолютно недоступны детям.

Во избежание ожогов ведра с горячей водой могут вноситься в группы только во время прогулок или сна детей. Кастрюли с супом можно подавать в группу только после того, как они простоят на пищеблоке снятыми с огня 10 минут. В групповом помещении нельзя оставлять кастрюли с супом без присмотра, раскладывать пищу надо на высоком раздаточном столе (по росту взрослого).

Однако даже при соблюдении всех приведенных правил во время занятий, игр, прогулок на свежем воздухе дети могут получить травмы, подвергнуться укусам насекомых, змей, животных, влияниям высоких или низких температур. Во всех случаях работники детских учреждений (медперсонал, воспитатели, заведующая) должны уметь быстро оказать ребенку первую доврачебную помощь. В некоторых случаях жизнь ребенка зависит от оказания эффективной реанимационной помощи в течение первых минут после происшествия. Поэтому *необходимо, чтобы взрослые, работающие с детьми, владели эффективными приемами восстановления дыхания и кровообращения, знали, как оказывать помощь больному в каждом конкретном случае, и имели возможность срочно вызвать скорую и неотложную медицинскую помощь. В дошкольных учреждениях средства оказания экстренной помощи должны, находиться в медицинском кабинете, в каждой группе должны быть сумки-аптечки первой помощи и общая сумка-аптечка для оказания экстренной помощи вне стен учреждения.*

1. Виды детского травматизма, оказание доврачебной помощи

Виды повреждений в зависимости от характера бывают механические (при падении, ударе), физические (при воздействии высокой или низкой температуры — ожоги, обморожения, действие электрического тока, проникающей радиации и т. п.), химические (при воздействии на

ткани разных химических веществ — кислот, щелочей, отравляющих веществ и пр.).

Различают **закрытые** и **открытые** повреждения. К первым относятся повреждения, при которых отсутствует нарушение целостности кожи и слизистых оболочек:

ушибы мягких тканей, растяжения связок, большинство вывихов и переломов. Открытые повреждения связаны с нарушением целостности наружных покровов: раны, открытые вывихи и переломы, ожоги и др.

Закрытые повреждения. Самым частым закрытым повреждением бывает *ушиб*. При ушибах целостность кожи не нарушена, нет наружного кровотечения, но под кожей в мышцах травмируются небольшие кровеносные сосуды, из которых кровь просачивается в ткани. На месте ушиба появляются припухлость и синюшно-красное пятно, которое постепенно меняет свой цвет на синебагровый, зеленый и желтый (кровоподтек, или синяк).

Для уменьшения боли и кровоизлияния на ушибленное место прикладывают холод — пузырь с холодной водой или холодные примочки. Ушибленную часть тела приподнять и обеспечить ей полный покой.

Растяжение связок и сухожилий возникает при резких движениях, неудачных прыжках, неловких поворотах. Чаще всего наблюдается растяжение связочного аппарата голеностопного сустава. При падениях на вытянутую кисть может возникнуть растяжение лучезапястного сустава. Реже наблюдаются растяжения локтевого и коленного суставов. При растяжении возникают болезненность, припухлость, ограничение движений в суставе, через 2-3 дня может выявиться кровоподтек. Первая помощь заключается в наложении на поврежденное место тугой, давящей повязки из бинта или мягкой ткани. Ноге придать высокое положение. Поверх повязки кладут пузырь со льдом или снегом.

В некоторых случаях может произойти не только растяжение, но и надрыв или разрыв связок и суставной сумки, со стойким смещением концов костей, входящих в тот или иной сустав. Такое повреждение называют *вывихом*. При вывихе могут разрываться мышцы и их сухожилия, прикрепляющиеся в области сустава, а также повреждаться соседние сосуды и нервы. В месте повреждения возникает резкая, усиливающаяся при малейшей попытке к движению боль, опухоль и кровоподтеки, ненормальное положение поврежденной руки или ноги, которое ни в коем случае исправлять неспециалисту нельзя. При вывихе суставов руки ее подвешивают на косынке; с вывихом суставов ног пострадавшего укладывают на носилки с мягкой подстилкой, на которых его и доставляют к врачу, обложив поврежденную ногу мягкими подушками или одеждой.

Переломом называется полное или частичное нарушение целостности кости. Если при переломе кости кожные покровы остались целыми, его называют *закрытым*; если наряду с переломом кости имеется рана, перелом называют *открытым*. Открытый перелом опаснее, так как через рану возможно проникновение микробов. Перелом кости сопровождается резкой болью, усиливающейся при малейшем движении, может наблюдаться подвижность кости в том месте, где нет сустава, изменение внешней формы сломанной конечности (наличие ненормальных выступов, искривлений, западаний).

Первая помощь при переломах обеспечивается прежде всего полным покоем поврежденной части тела. Это предупредит еще большее смещение костей, которые могут поранить окружающие ткани (мышцы, сосуды, нервы) и усилить боль. Для обеспечения сломанной конечности (руке, ноге) неподвижности применяют *шины*. В продаже имеются готовые шины из дерева или проволоки, размеры и форма которых соответствуют разным частям рук и ног (в срочных случаях можно воспользоваться палкой зонта, пучком прутьев или прибинтовать сломанную руку к грудной клетке, ногу — к здоровой ноге).

При открытом переломе перед наложением шины на поврежденную конечность кожу вокруг раны смазывают йодом и на рану накладывают стерильную повязку.

Открытые повреждения. *Раной* называется повреждение, при котором нарушается целостность кожи или слизистых оболочек, а иногда и глубже лежащих тканей (подкожная клетчатка, мышцы и др.).

Все раны, даже самые незначительные, инфицированы. В первые часы после ранения микробы в основном находятся на поверхности раны и еще не проявляют своих болезнетворных свойств, поэтому при любом повреждении кожных или слизистых покровов надо срочно принять все необходимые меры, чтобы устранить или хотя бы ослабить вредное влияние микробов на рану, не дать им возможности проникнуть в организм. С этой целью применяется обработка раны 3%-ным раствором перекиси водорода или слабо-розовым раствором марганцовокислого калия (1:1000 или 0,5%-ный раствор), края раны смазываются 5%-ной спиртовой настойкой йода или 1%-ным спиртовым раствором бриллиантовой зелени, на рану накладывается повязка с 1-5%-ной синтомициновой эмульсией или мазью Вишневского. Основное правило, которое надо соблюдать при обработке раны,— не касаться ее руками, на которых всегда имеются микробы. Нельзя промывать рану водой.

Царапины, ссадины, неглубокие порезы, которые не сопровождаются сильным кровотечением, достаточно обработать йодом или другим обеззараживающим средством и перевязать стерильным бинтом или заклеить бактерицидным пластырем.

Если ребенок носит тесную или малоразношенную обувь, у него может возникнуть *потертость* ног — покраснение или отслойка эпителия, под которой скопилась жидкость (пузырь). Потертость следует осторожно промыть слабым раствором марганцовокислого калия, смазать йодом и наложить стерильную повязку, смоченную стерильным касторовым маслом или рыбьим жиром. Если целостность пузыря не нарушена, вскрывать его не рекомендуется, чтобы не вызвать инфицирование ранки. Обувь ребенка надо поменять на более удобную и соответствующую его размеру.

Кровотечение. В зависимости от характера поврежденных сосудов различают артериальное, венозное и капиллярное кровотечение.

Артериальное кровотечение является наиболее опасным, так как оно возникает при повреждении крупных артерий. Для артериального кровотечения характерны пульсирующая струя крови и алый ее цвет.

Венозное кровотечение является следствием повреждения более или менее крупных вен. Кровь темно-красного цвета, вытекает из раны равномерной струей.

Капиллярное кровотечение — следствие повреждения мельчайших сосудов. При капиллярном кровотечении кровь сочится каплями. Кровотечение останавливается самопроизвольно в первые минуты после ранения, так как в просвете поврежденных сосудов вследствие свертывания крови образуются кровянистые сгустки (тромбы). Если кровотечение не приостанавливается, надо наложить давящую повязку.

Сильное артериальное кровотечение можно остановить прижатием соответствующей артерии выше раны, наложением выше места ранения кровоостанавливающего жгута — резиновой трубки, имеющей на одном конце металлическую цепочку, а на другом — металлический крючок. При отсутствии жгута можно использовать любую резиновую трубку, полотенце, ремень, веревку, платок и т. д. На верхней конечности жгут накладывают в области плеча или предплечья, на нижней — в области бедра или голени. Накладывают жгут следующим образом: часть конечности,

где будет лежать жгут, обертывают полотенцем или несколькими слоями бинта, в случае их отсутствия жгут можно накладывать и поверх одежды. Затем поврежденную конечность приподнимают, жгут растягивают, делают 2-3 оборота вокруг конечности с целью сдавить мягкие ткани и закрепляют его конец с помощью цепочки и крючка.

Так как при наложении жгута сдавливаются все сосуды поврежденной конечности и питание нижележащих ее отделов резко нарушается, *держат жгут можно не более 1-1,5 ч; время наложения его необходимо точно указать в документе, сопровождающем ребенка в лечебное заведение.*

Носовое кровотечение чаще всего возникает при ушибах лица и носа, а также при некоторых заболеваниях (корь, грипп, коклюш и др.). Степень кровотечения при этом бывает различной: от кратковременного с потерей нескольких капель крови до длительного и обильного. При кровотечении из носа ребенка надо успокоить, расстегнуть ему ворот, пояс, усадить его со слегка опущенной головой, для того чтобы кровь могла свободно вытекать наружу. Запрокидывание головы при носовом кровотечении может привести к поперхиванию кровью или рвоте в результате ее заглатывания. На переносицу рекомендуется положить холодную примочку или кусочек льда, снега, завернутые в непромокаемую ткань. Если это не поможет, можно в носовые ходы вставить тампоны из ваты, смоченные раствором перекиси водорода.

Ожоги могут быть вызваны пламенем, кипятком, паром, различными химическими веществами — кислотами, щелочами, некоторыми медикаментами (ляпис, йод, нашатырный спирт и др.), электрическим током, радиоактивными веществами, солнечными лучами. В зависимости от причины, вызвавшей ожог, различают термические, химические, электрические и лучевые ожоги.

Термические ожоги чаще всего наблюдаются на коже, но могут быть и ожоги глаз, слизистых рта, глотки, пищевода и даже желудка. На коже различают три степени ожога. Ожог первой степени сопровождается покраснением и небольшой припухлостью кожи, которые через 2-3 дня проходят, поврежденный участок кожи темнеет и слущивается. При ожоге второй степени на покрасневшей и припухшей поверхности в дальнейшем образуются пузыри, наполненные сывороткой крови.

Задача первой помощи при ожогах первой и второй степени — облегчить состояние пострадавшего. С этой целью обожженный участок кожи длительно (20-30 мин) обливают струей холодной воды, можно приложить к месту ожога лед. Срезать пузыри ни в коем случае нельзя, так как они защищают поврежденную часть кожи от микробов. Ожог нельзя обрабатывать йодом или спиртом, накладывать на него жировые повязки, обрабатывать красящими средствами (марганцовокислым калием, зеленкой). Для облегчения боли и предупреждения инфицирования можно использовать 1-5%-ную синтомициновую эмульсию или ограничиться наложением стерильной повязки.

Ожог третьей степени — омертвление (обугливание или сваривание) всей толщи кожи, а иногда и более глубоких тканей, образованием в дальнейшем язв и рубцов. При ожоге третьей степени (а при обширных поражениях — второй и даже первой степени) в патологический процесс вовлекается весь организм, очень высок риск инфицирования ожоговой поверхности с развитием заражения крови (сепсиса), высока вероятность развития ожогового шока — нарушения жизнеобеспечивающих систем организма, угрожающего смертельным исходом. При ожоге третьей степени необходимо на раневую поверхность наложить стерильную повязку и ребенка немедленно отправить в больницу.

Первая помощь при термических ожогах глаз — закапать 1-2 капли стерильного вазелинового, подсолнечного или касторового масла, наложить повязку и доставить ребенка к врачу. Для предупреждения термических ожогов следует избегать нахождения детей в помещениях, где есть открытый огонь (печи, камины), кипяточные приборы, сосуды с кипятком, обучать детей правилам обращения с огнем, со спичками. Контроль за времяпрепровождением детей играет большую роль в профилактике всех несчастных случаев, в том числе и ожогов.

Обморожение. Ребенок может получить обморожение не только при очень низкой температуре воздуха, но и при $+3$ — -5°C , если есть повышенная влажность и/или сильный ветер.

Обычно обмораживаются открытые или плохо защищенные участки тела, а также места, недостаточно снабжающиеся кровью: кончик носа, уши, щеки, пальцы рук и ног (особенно если на ногах тесная обувь). При действии холода кровеносные сосуды кожи сужаются, нормальное питание и газообмен в них нарушаются, кожа бледнеет, в ней появляется ощущение пощипывания или покалывания, сменяющееся в дальнейшем полной потерей чувствительности.

В зависимости от тяжести поражения обморожение делят на три степени. При обморожении первой степени после согревания в поврежденном месте появляются болезненность, отечность, синюшная окраска, которые в течение 1-2 недель полностью проходят. При обморожении второй степени образуются пузыри, наполненные мутной кровянистой жидкостью. При обморожении третьей степени наступает омертвление кожи, а иногда и глубоко лежащих тканей. Обморожение второй и третьей степени обычно сопровождается сильной болью.

При первых признаках обморожения пострадавшего прежде всего надо ввести в помещение и согреть. Не рекомендуется растирать обмороженные участки кожи, так как их повреждение приведет к инфицированию. Ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок снегом, поскольку дополнительное охлаждение препятствует восстановлению кровообращения. Лучше всего поместить обмороженный участок в достаточно теплую, но не горячую воду. Хорошо погрузить всего ребенка в ванну с водой температурой $22-25^{\circ}\text{C}$, постепенно доводя ее до $36-38^{\circ}\text{C}$. В ванне ребенка держат до 30 минут, затем насухо вытирают, одевают в теплую сухую одежду. Одновременно массируют и растирают все тело, дают сердечные средства (3-5 капель кордиамина) и горячее питье.

На поврежденные части тела при обморожении первой степени следует наложить повязку с вазелиновым, касторовым маслом или рыбьим жиром. При обморожении второй степени пузырей не срезать, а наложить на них повязку с синтомициновой эмульсией, ребенка показать врачу. При обморожении третьей степени на поврежденную поверхность наложить сухую стерильную повязку, ребенка срочно отправить в ближайшее лечебное учреждение.

2. Признаки, по которым можно определить заболевания у ребенка

Анамнестические сведения

В связи с увеличением количества детей с отклонениями в развитии возникла необходимость организации специальных консультативных центров, осуществляющих обследование таких детей, а также дошкольных учреждений, в которых дети могут получить квалифицированную медицинскую, дефектологическую и психологическую помощь. В настоящее время возросло число детей со сложной структурой дефекта

(сочетанием различных компонентов зрительных, слуховых, речевых, моторных, интеллектуальных, эмоциональных и других расстройств). Особенно сложна в детском возрасте диагностика отклонений в развитии, когда структуры нервной системы еще не полностью сформированы, а симптоматика нерезко очерчена.

Для решения вопроса о состоянии здоровья ребенка и выявлении причин отклонения в развитии необходимо провести беседу с родителями и составить *анамнез*. Анамнестические данные по определенной схеме может собрать врач или педагог-дефектолог, работающий совместно с врачом. При собеседовании с родителями необходимо установить доверительные отношения, чтобы получить достоверные сведения о состоянии здоровья ребенка, самих родителей и их ближайших родственников.

Беседа с родителями начинается со сбора жалоб, которые могут охватывать различные стороны жизни и деятельности ребенка. Так, в раннем возрасте родителей больше беспокоят вопросы психомоторного и речевого развития (неусидчивость, медленное и плохое развитие речи, общей моторики), частые инфекции, судорожные приступы. В дошкольном — задержки психомоторного и речевого развития, трудности поведения, ограниченность запаса общих понятий, головные боли и др. В школьном возрасте основные жалобы сводятся к затруднениям в школьном обучении, плохой памяти, неусидчивости, невнимательности и т. д.

1. Сбор анамнестических данных начинается со знакомства с *социальным статусом родителей* ребенка:

- учитывается их возраст;
- профессия, место работы в период ожидания потомства;
- особенности домашнего уклада;
- количество членов семьи (полная ли семья);
- кто и как воспитывает ребенка; жилищные условия и др.

Эта часть беседы оформляется как паспортная.

2. Переходя непосредственно к составлению истории болезни и сбору анамнеза, врач интересуется *состоянием здоровья родителей* (отдельно отца и матери) в настоящее время и в более молодые годы с целью выяснения, не страдали ли они теми же болезненными состояниями, которые наблюдаются в данное время у их ребенка.

По ходу беседы выясняется *состояние здоровья ближайших родственников*: братьев и сестер, их детей, бабушек и дедушек. Расспрашивают о наличии хронических заболеваний в семье (ревматизма, туберкулеза, бронхиальной астмы и др.), о злоупотреблении алкоголем, никотином, лекарственными препаратами и т. д.

3. Сбор анамнестических данных о ребенке необходимо начать со следующих вопросов, касающихся *состояния здоровья матери*:

- от какой по счету беременности обследуемый ребенок и была ли желанной беременность;
- не употребляла ли мать в это время противозачаточные средства, лекарственные препараты.

Каждый вопрос, задаваемый родителям, имеет большое значение для понимания возможного этиологического фактора болезни. Например:

- выяснение здоровья матери, отца и их родственников может указать на наследственную предрасположенность к возникновению заболевания;

- выяснение причин абортов может помочь оценить состояние эндокринной системы матери (неразвивающийся плод) или домашнюю ситуацию, при которой ребенок является нежелательным;

- уточнение времени между предыдущей беременностью и настоящей, особенно в случаях хирургического вмешательства, необходимо для того, чтобы оценить условия, в которых происходило развитие плода;

- хирургические вмешательства (в том числе частые аборты), воспалительные процессы в слизистой матки нарушают функцию ворсинчатого эпителия, которые приводят к формированию плаценты на патологической основе, нарушая процесс внутриутробного развития плода.

4. При опросе матери о *течении беременности* обследуемым ребенком необходимо уточнить состояние ее здоровья в это время:

- инфекции, интоксикации, травмы, в том числе психические, операции;
- употребление лекарственных препаратов, никотина, алкогольных напитков и др.

Различные заболевания матери оказывают влияние на развивающийся плод, который всегда реагирует диффузно (недоразвитием или задержкой развития отдельных структур). Если мать подвергалась воздействию какого-либо из перечисленных факторов, важно знать, в каком триместре беременности это происходило:

- так как в первые три месяца внутриутробного развития идет закладка органов и тканей, становится понятным, что заболевания в этот период могли привести к порокам развития;

- в последующие месяцы, когда идет совершенствование структур органов и тканей всего организма и нервной системы, возможно возникновение несформированности этих органов или задержка в развитии структур нервной системы.

5. Очень важно при опросе матери получить сведения о периоде *родовой деятельности*:

- сроки родов (досрочно, своевременно, перенос);
- длительности родов (быстрые или затяжные);
- оказание акушерской помощи (вакуум, щипцы, кесарево сечение).

А также сведения о наличии *послеродовых осложнений у ребенка*. В частности, при асфиксии выяснить длительность периода оживления и его способы.

6. Дальнейшие вопросы касаются оценки *состояний ребенка после рождения по шкале Апгар*. Уточняют массу и длину тела при рождении и состояние ребенка в *период новорожденности* (на какой день приложили к груди, как сосал грудь и т. п.).

7. В последующих вопросах уточняется физическое и психомоторное развитие ребенка в *первый год* жизни:

- не было ли срыгивания, рвоты, кишечных расстройств;
- как прибавлял в весе; был ли спокойным или крикливым;
- когда начал держать голову и сидеть;
- какие заболевания перенес.

8. Если ребенку *менее трех лет*, интересуются этапами дальнейшего физического, психомоторного, речевого и психического развития ребенка и уточняется степень подготовки его к посещению детского сада:

- перенесенные инфекционные болезни, вакцинации;
- особенность игрового процесса;
- интерес к общению с детьми;

- формирование элементов опрятности, самообслуживания и т. п.

9. Если ребенок *старше трех лет*, интересуются особенностями дальнейшего психомоторного и речевого развития:

- контактами с детьми и персоналом детского учреждения;
- условиями воспитания в детском учреждении и дома;
- формирования игрового процесса;
- интересом к прослушиванию сказок;
- запоминанием стихов; умением рисовать;
- восприятием пространства и времени;
- знанием основ грамоты и т. п.

10. Другая часть анамнеза посвящена *заболеванию*, по поводу которого мать обратилась к специалистам:

- уточняют перенесенные ребенком заболевания, их течение и осложнения;
- время возникновения отклонений; изменения поведения, судороги, ухудшение памяти, речевые расстройства;
- какие меры принимались в семье для улучшения общего состояния ребенка: обращения к специалистам, методы лечения, педагогические рекомендации и т. д.;
- в каких случаях отмечалось улучшение или ухудшение состояния ребенка.

Психоневрологические обследования

Психоневрологические обследования заключаются в исследовании функций различных отделов нервной системы. Они проводятся в присутствии матери и воспитателя только врачом.

Исследование черепно-мозговой иннервации

При исследовании состояния черепно-мозговых нервов особо важное значение имеют нервы, участвующие в *функциях зрения, слуха и речи*.

Путем демонстрации ребенку специальных таблиц с буквами, набором цветных дощечек врач проверяет остроту зрения, цветоощущение. Для исследования остроты слуха применяется такой прием: врач произносит отдельные слова или фразы на определенном расстоянии и предлагает ребенку повторить их. Нормальное ухо воспринимает несложные фразы, произнесенные шепотом на расстоянии 5-6 метров. В сложных ситуациях при оценке зрительной или слуховой функций обращаются за консультацией к специалистам (офтальмологу, отоларингологу), которые применяют для обследования специальные приборы.

Исследование двигательной сферы

Переходя к исследованию двигательной сферы, врач обращает внимание

- на осанку, походку;
- характер активных и пассивных движений в суставах, их объем, силу, равномерность;
- большое диагностическое значение имеет состояние мышц — их сила и характер мышечного тонуса (повышенный или пониженный тонус), а также состояние рефлексорной сферы.
- обычно исследуются сухожильные, периостальные (надкостничные), кожные рефлексы и рефлексы со слизистых оболочек.

Сухожильные рефлексы проверяются ударом специального молоточка в определенных зонах, кожные — штриховым движением по коже. Важно установить

степень активности рефлексов (повышение, понижение или отсутствие рефлекторной реакции), а также их равномерность с обеих сторон.

В процессе обследования определяется состояние координации:

- симптом Ромберга (стоять с вытянутыми руками и закрытыми глазами);
- пальценосовая проба и др.

Этими методами обследования выявляется отсутствие или наличие парезов (параличей), гиперкинезов.

Исследование психической сферы

Исследование состояния психической деятельности проводится врачом совместно с педагогом-дефектологом, логопедом, психологом и в присутствии воспитателя.

1. При знакомстве с ребенком необходимо спросить: его имя, фамилию, возраст; с кем он пришел на обследование (имя матери). Ответы на эти вопросы

- создают первое впечатление;
- показывают состояние контакта, понимание речи;
- определяют возможность произнесения первых слов или фраз.

2. Продолжая беседу с ребенком:

- выявляют запас общих понятий, предлагая назвать предметы, их цвет, форму;
- обращают внимание на уровень интереса ребенка к книге, картинке, игрушке;
- оценивают уровень игрового процесса, его организацию, включение в деятельность, понимание условий и выполнение задания, использование помощи педагога.

3. При обследовании старшего дошкольника обращается внимание:

- на уровень подготовки к школе (знание букв, слияние их в слоги, умение рисовать, считать);
- состояние психических процессов (внимание, память, эмоции, воображение, мышление);
- большое значение придается пониманию пространственного восприятия и времени (времени года, месяцы, дни недели).

4. При беседе с ребенком фиксируется внимание на состоянии речи. Обращается внимание на состояние *импрессивной речи*:

- понимание значения отдельных слов, словосочетаний, грамматических конструкций;
- способность удерживать в памяти целую фразу, короткий стишок;
- способность различать на слух отдельные фонемы.

Состояние *экспрессивной речи* оценивают:

- по использованию ребенком отдельных слов или словосочетаний;
- по состоянию звукопроизношения;
- по способности составить самостоятельную фразу или рассказ по картинке, по просмотренному фильму;
- по знанию наизусть стихотворений;
- по умению писать и особенностям почерка.

Составление заключения

Заканчивается физическое, психоневрологическое и психолого-педагогическое обследование обсуждением и составлением заключения. В отсутствие ребенка и родителей сводятся и обобщаются данные, полученные специалистами, и ставится диагноз.

3. Меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в ДОУ

Знание внутреннего мира ребенка дошкольного возраста, его психологических и психофизиологических особенностей, развитие личностных качеств в их сенситивные периоды - необходимое условие успешной адаптации к меняющимся условиям в дальнейшие периоды жизни, поскольку морфофункциональные и психофизиологические особенности учащейся молодежи во многом обусловлены спецификой формирования предшествующих периодов онтогенеза.

Согласно концепции Т. К.Зайцева, В. В.Колбанова, педагогическую работу в детском саду следует проводить с учетом потребностей занимающихся в игре и креативности по следующим направлениям: формирование потребности в физическом и психическом саморазвитии, воспитание мотивации здорового образа жизни, развитие резервных возможностей и профилактика заболеваний, обучение родителей методам анализа и коррекции здоровья собственных детей.

Основной акцент необходимо делать на педагогические средства обеспечения здоровья, среди которых преобладают:

1) подвижные игры и самостоятельные занятия на площадках физического саморазвития (в бассейне в виде аквариума),

способствующие общему физическому развитию детей, а также закаливанию и нормализации их психического состояния;

2) креативные (художественно-эстетические и театрализованные) действия, положенные в основу различных учебных занятий, включая уроки валеологии, способствующие психическому саморазвитию детей и формированию у них групповой сплоченности;

3) педагогическая работа с родителями по овладению ими методами коррекции образа жизни собственных детей и укрепления их здоровья.

Г. К.Зайцевым разработана образовательная программа «Уроки Здоровейки» и модели валеологических занятий для детей по уходу за своим телом и соблюдению правил безопасной жизни, построенные на игровой и творческой основе, способствующие формированию у них мотивации в здоровом образе жизни.

В процессе формирования потребности в здоровом образе жизни педагоги, используя адекватные методики (занятия, игры, чтение, беседы, мультфильмы) знакомят детей дошкольного возраста с понятием «здоровье», со строением человеческого тела, с помощью иллюстрированного материала доступного содержания рассказывают об основных системах и органах (опорно-двигательном аппарате, пищеварительной, выделительной, дыхательной, нервной системах, кровообращении, органах чувств).

Исходя из тех привычек и потребностей, которые прививаются в ДОУ, у детей формируются знания относительно основных санитарно-гигиенических норм и правил поведения.

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий в ДОУ направлен на: снижение уровня заболеваемости, выделение основных факторов риска, снижение уровня функциональной напряженности, регламентацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей детей.

Лечебно-профилактическая и оздоровительная работа с детьми должна проводиться в три этапа с включением специфических физиотерапевтических и общеукрепляющих процедур.

1. Этап интенсивной профилактики готовит ребенка к самому неблагоприятному сезону года, проводятся УФО, массаж, разрабатываются новые мероприятия.

2. Восстановительный этап - используется система защитных мер для предупреждения ОРВИ, ангины.

3. Реабилитационный этап - детям предлагаются кислородные коктейли, травяные чаи, оздоровительные напитки, витаминотерапия.

Одним из эффективных способов профилактики острых респираторных заболеваний у детей является аэрофитотерапия с использованием американского аппарата «Rainbow», который позволяет распылять

естественные природные концентраты, обладающие антибактериальным, противовирусным, спазмолитическим действием.

Необходимо создать в ДОО условия для физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы, выделить и оснастить специальные помещения: спортивные залы, бассейн, сауну, фитобар, физиокабинет, кабинет массажа, спортплощадку, кабинет врача-педиатра.

Положительному результату от проводимой в ДОО лечебно-профилактической работы способствуют методические кабинеты, физиотерапевтические процедуры, которые многообразно воздействуют на организм ребенка, устраняя поведенческие и эмоциональные нарушения, стимулируя развитие памяти, внимания, умственной работоспособности, мобилизуя защитные силы организма. Устранить психический дискомфорт у детей помогает разработанный врачом-педиатром оздоровительный комплекс, включающий диагностику физического и психического развития, индивидуальную коррекцию, лечебную гимнастику, музыка-, игро-, сказкотерапию.

4. Медицинское обслуживание в дошкольных учреждениях

В детском дошкольном учреждении, в соответствии с действующими инструкциями, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции в группе или вне группы в зависимости от характера инфекции, способа передачи — карантин, дезинфекция, прививки и пр. по указанию эпидемиолога. В связи с распространенностью респираторных инфекций, способствующих высокой заболеваемости детей в детских дошкольных учреждениях, профилактические мероприятия следует проводить в соответствии с методическими рекомендациями.



После перенесенного заболевания дети принимаются в детское дошкольное учреждение только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также с указанием рекомендаций по индивидуальному режиму выздоравливающего ребенка на первые 10-14 дней.

Для контроля за физическим развитием детей и раннего выявления отклонений в состоянии здоровья врачами проводятся профилактические осмотры. Частота их регламентируется методическими рекомендациями по проведению диспансеризации детского населения.

Профилактические осмотры дошкольников целесообразно проводить непосредственно в детском учреждении, куда приглашаются необходимые специалисты.

Углубленные осмотры с привлечением специалистов проводятся на четвертом и седьмом году жизни. *На четвертом году жизни* в углубленном осмотре принимают участие оториноларинголог, офтальмолог, хирург-ортопед, логопед. *На седьмом году жизни* (предшкольная диспансеризация) обязательно участие оториноларинголога, офтальмолога, хирурга-ортопеда, невропатолога, по показаниям — других специалистов. Во время углубленных осмотров детям проводятся антропометрия, клинические исследования крови, мочи и кала на яйца глистов. Заканчивает профилактический осмотр педиатр, который делает общее заключение о состоянии здоровья ребенка и определяет группу для занятий физкультурой. Данные медицинского осмотра заносятся в медицинские карты детей (формы 112У и 026У), а при наличии тех или иных хронических заболеваний у ребенка заполняется учетная форма диспансерного наблюдения (форма 30) и назначается комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий. Результаты углубленных осмотров тщательно анализируются врачом. С рекомендациями по оздоровлению детей знакомятся воспитатели и родители.

Дошкольные учреждения выполняют важную роль в подготовке детей к школьному обучению: целенаправленная компенсация отклонений в их здоровье очень важна перед поступлением в школу. У детей с отклонениями в состоянии здоровья, как правило, трудно проходит адаптация к школе, уже в первом классе ухудшается здоровье, тяжелее протекают заболевания, возникают хронические болезни.

Важный этап профилактической работы и укрепления здоровья воспитанников детских дошкольных учреждений — рационально организованный отдых в летнее время. Роль и ответственность медицинского персонала в этот период значительно возрастает. На врача лежит ответственность не только за соблюдение всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проводимых с детьми, находящимися на летней даче круглосуточно. Контроль за физическим и психическим здоровьем ребенка, первая помощь при заболеваниях и несчастных случаях, а также их профилактика становятся весомой частью деятельности медперсонала. Все оздоровительные мероприятия должны проводиться по указанию и под контролем врача, а в его отсутствие — под наблюдением медсестры.

Наличие в детском учреждении врача и медицинской сестры не снимает ответственности за санитарный режим, организацию питания и физического воспитания с заведующей, а также с каждого воспитателя. Успех оздоровительной и профилактической работы в дошкольном учреждении

в большой степени зависит от четкости и слаженности работы всего персонала учреждения, от взаимопонимания между руководителем учреждения, педагогическим и медицинским персоналом. Периодический контроль за обеспечением санитарного режима, за организацией, качеством и полноценностью питания в дошкольных учреждениях осуществляется специальным врачом, входящим в состав санитарно-эпидемиологической службы города или района.

Важное условие эффективной работы медицинского персонала дошкольного учреждения — четко налаженные контакты и преемственность с участковыми педиатрами, врачами-специалистами, отделениями гигиены детей и подростков и противоэпидемическими отделениями санэпидстанций и местными органами власти.

Вопросы для самопроверки:

1. Предмет и задачи педиатрии в дошкольной гигиене.
2. Характеристика возрастных периодов.
3. Особенности детей раннего и дошкольного возраста.
4. Здоровье и физическое развитие детей.
5. Пищевые отравления, первая помощь и профилактика.
6. Обморок, шок, тепловой и солнечный удар. Первая помощь и профилактика.
7. Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути, в желудочно-кишечный тракт, в глаз, нос, ухо.
8. Первая помощь при утоплении.
9. Виды детского травматизма, оказание доврачебной помощи.
10. Признаки, по которым можно определить заболевания у ребёнка.
11. Меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в ДДУ.
12. Сензитивные периоды.
13. Профилактика заболеваний ЦНС. Клиника невроза, истерии.
14. Профилактика и клиника чесотки.
15. Понятие об инфекции и инфекционных заболеваниях.
16. Пути распространения детской инфекции.
17. Кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез). Клиника и доврачебная помощь.

Практические задания:

1. Составить рекомендуемый набор продуктов питания в день на 1 ребенка (12-часовое пребывание) в ДООУ.
2. Составить полноценное 7-дневное меню питания дошкольников младшей возрастной группы.
3. Составить полноценное 7-дневное меню питания дошкольников средней возрастной группы.
4. Составить полноценное 7-дневное меню питания дошкольников старшей возрастной группы.
5. Составить перечень одежды для младших дошкольников на прогулке в летнее время года при средней двигательной активности.
6. Составить перечень одежды для среднего дошкольника на прогулке в летнее время года при средней двигательной активности.
7. Составить календарь профилактических прививок в ДООУ для дошкольников.
8. Составить таблицу общей и местной реакции детей на профилактические прививки.
9. Составить комплекс закаливающих процедур (с использованием фактора – воды) для среднего дошкольника в ДООУ.
10. Составить комплекс закаливающих процедур (с использованием фактора – воздуха) для старшего дошкольника в ДООУ.
11. Составить комплекс закаливающих процедур (с использованием фактора – солнце) для среднего дошкольника в ДООУ.
12. Составить комплекс мероприятий по проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца при неотложных состояниях детей.
13. Составить комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской доврачебной помощи ребенку при отравлении лекарственными препаратами.
14. Составить комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской доврачебной помощи ребенку при бутулизме.
15. Составить комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской доврачебной помощи ребенку при попадании инородного тела в глаз.
16. Составить комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской доврачебной помощи ребенку при попадании инородного тела в дыхательные пути.
17. Составить комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской доврачебной помощи дошкольнику при вывихе и растяжении в суставе.
18. Составить перечень рекомендуемой одежды для дошкольников при проведении занятий по физической культуре.
19. Составить перечень гигиенических требований к игрушкам дошкольников.
20. Составить комплексный режим дня для дошкольников подготовительной к школе группы в ДООУ.
21. Составить комплекс методик оценивания физического развития ребенка (соматология, соматоскопия, физиометрия).
22. Составить комплекс мероприятий по медицинскому обследованию детей в ДООУ.
23. Составить программу или план проведения оздоровительных процедур для дошкольников (разных возрастных групп) в ДООУ.
24. Составить комплекс лечебно-профилактической помощи детям в ДООУ.
25. Составить комплекс мероприятий по санитарному просвещению и гигиенической подготовки персонала в дошкольных учреждениях.
26. Изготовить книжку-раскладушку по теме: «Витамины в питании детей».
27. Изготовить книжку-раскладушку по теме: «Личная гигиена дошкольника».
28. Изготовить буклет для родителей дошкольников по теме: «Режим дня дошкольника дома».
29. Изготовить буклет для родителей дошкольников по теме: «Закаливание ребенка дома».
30. Изготовить книжку-раскладушку по теме: «Гигиена одежды и обуви дошкольников».

Литература:

Основные источники:

1. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков: учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений.-М.: Медицина, 2008 – 218с.
2. Бениаминова М.В. Воспитание детей: учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений.-М.: Академия, 2010 – 320с.
3. Богоявленский В.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях.-СПб., Гиппократ, 2009-180с.
4. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник.-7-е изд.,перераб.и доп.- М.: Медицина, 2009 -224с.
5. Детские болезни /под ред. Л.А. Исаева и других/.- М.: Академия, 2010-166с.
6. Диагностика и профилактика ранних отклонений в состоянии здоровья детей под редакцией В.А.Доскина/.-М.: Медицина, 2010 – 250с.
7. Кузлинева А.Т., Шарлай Н.В. Детские инфекционные болезни. Учебник.- 3-е издание., перераб. И доп. – М.: Медицина, 2010 -312с.
8. Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учебное пособие/ И.М.Красильникова, Е.Г. Моисеева/.-М.: АНМИ, 2011 – 190с.
9. Мазурин А.В. и другие. Пропедевтика детских болезней, учебное пособие 4-е издание, перераб и доп.-М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 190с.
10. Организация медицинской помощи детям в дошкольных учреждениях / Под ред И,И,Гребешковой –М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 240с.
11. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений.- М.: Издательский центр «Академия», 2010– 270с.

Дополнительные источники:

1. Гребенев А.А.Пропедевтика внутренних болезней: учебник,5-е издание,перераб.и доп. –М.: Медицина, 2009 – 592с.
2. Жданов Г.Г. Реанимация: учебное пособие, Саратов: Слово, 2008 – 102с.
3. Окружающая среда и профилактика заболеваний детей и подростков в учебно-воспитательных учреждениях (под редакцией Г.Н.Сердюковской).-М.: Издательский центр «Академия», 2009– 190с.
4. Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровлении в условиях детского сада, школы (под редакцией Г.Н.Сердюковской).-М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 270с.
5. Первая медицинская помощь при несчастных случаях м в экстремальных ситуациях / под редакцией М.Шляпцева/. – Кострома, 2009 – 160с.
6. Столяренко Л.Н. Примерное 10-дневное меню для питания детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения./Методические рекомендации/.- Издательский центр «Академия», 2008 – 180с.
7. Тарасов В.В. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений.-М.: Издательский центр «Академия», 2007 – 180с.
8. Тополев И.М. Воспитание здорового дошкольника.-М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 280с.
9. Титова Е.Л. Книга для родителей.-М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 280с.
10. Чабовская А.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста- учебное пособие для студентов пед.институтов –М.: Издательский центр «Академия», 2007 – 300с.
11. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.-М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 210с.

12. Фишкин А.В. Неотложная помощь: справочник./М.: -Экзамен, 2008 – 352с.

Интернет-ресурсы:

1. www.prosv.ru/attachmntnt.aspx?jd=9835 (УМК «Школа России»)
2. <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223>. (сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»).
3. <http://www.shool.tdu.ru> - Российский образовательный портал.
4. <http://www.ptdlib.ru> - библиотека.
5. <http://www:nfer-pedagogika.ru> - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.

Написать эссе по следующей тематике:

1. Заболевания нервной системы детей, их предупреждение и профилактика.
2. Нарушение зрения в детском возрасте профилактика этих нарушений.
3. Нарушение слуха в детском возрасте профилактика этих нарушений.
4. Нарушение обмена веществ в детском возрасте. Нарушение углеводного обмена. Сахарный диабет.
5. Нарушение кальциево-фосфорного обмена в детском возрасте.
6. Гельминтозы у детей и их профилактика.
7. Болезни органов дыхания их профилактика и предупреждение в детском возрасте.
8. Острые и хронические воспаления миндалин в детском возрасте, их профилактика, лечение.
9. Профилактика заболеваний органов дыхания в ДООУ.
10. Инфекционные заболевания в детском возрасте, их виды, классификация, профилактика, предупреждение.
11. Эпидемический и инфекционный процесса, его основные факторы и закономерности.
12. Иммуитет и его виды, значение.
13. Иммунопрофилактика детей, ее значение. в дошкольных учреждениях.
14. Инфекционные заболевания с воздушно-капельным путем передачи, их виды, симптомы, этиология, лечение и профилактика.
15. Острые вирусные респираторные инфекции, их виды, симптомы, этиология, лечение и профилактика.
16. Инфекционные заболевания с фекально-оральным механизмом передачи, их виды, симптомы, этиология, лечение и профилактика.
17. Детские пищевые отравления, их профилактика.
18. Нарушения опорно-двигательного аппарата и их профилактика в детском возрасте.
19. Аллергические состояния у детей, их виды, симптомы, этиология, лечение и меры профилактики.
20. Ревматизм у детей и его профилактика.
21. Хронические детские болезни, их классификация, симптоматика, этиология, лечение и меры профилактики.
22. Туберкулез в детском возрасте и его профилактика.
23. Кожные болезни детей, их классификация, симптомы, лечение и меры профилактики.
24. Первая медицинская помощь при несчастных случаях и неотложных состояниях в детском возрасте.
25. Закрытые и открытые повреждения опорно-двигательного аппарата у детей их виды и профилактика.
26. Виды кровотечений и оказание первой доврачебной помощи при их.

27. Первая помощь при попадании в организм инородного тела.
28. Организация системы закаливания в ДОУ.
30. Гигиена белья, одежды и обуви детей.